

Buku Referensi

PENGEMBANGAN MODEL ASUHAN KEPERAWATAN

Berbasis Riset Di Indonesia

Jelita Siska Herlina Hinonaung • Cicilia Nony Ayuningsih Bratajaya • Nurul Mawaddah
Anis Ika Nur Rohmah • Halimatussakdiah • Syamsul Alam Natsir • Febriyanti



BUKU REFERENSI PENGEMBANGAN MODEL ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS RISET DI INDONESIA

Penulis:

Ns. Jelita Siska Herlina Hinonaung, S.Kep., M.Kep.
Ns. Cicilia Nony Ayuningsih Bratajaya, S.Kep., MNS.
Nurul Mawaddah, S.Kep.Ns., M.Kep.
Anis Ika Nur Rohmah, M.Kep., Sp.Kep.MB.
Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Syamsul Alam Natsir, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.

Buku Referensi Pengembangan Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset di Indonesia

Penulis:

Ns. Jelita Siska Herlina Hinonaung, S.Kep., M.Kep.
Ns. Cicilia Nony Ayuningsih Bratajaya, S.Kep., MNS.
Nurul Mawaddah, S.Kep.Ns., M.Kep.
Anis Ika Nur Rohmah, M.Kep., Sp.Kep.MB.
Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Syamsul Alam Natsir, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-95-0

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi berjudul “Pengembangan Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset di Indonesia.” Buku ini disusun sebagai salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi keperawatan, serta pemangku kebijakan dalam memahami konsep, pengembangan, validasi, dan implementasi model asuhan keperawatan yang berlandaskan hasil penelitian. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat budaya ilmiah dalam praktik keperawatan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat semakin bermutu, aman, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan di Indonesia.

Isi buku ini disusun secara sistematis mulai dari pembahasan mengenai konsep pengembangan model dalam keperawatan, integrasi teori dan praktik, model asuhan keperawatan klinik, model asuhan berbasis komunitas, hingga validasi dan uji model asuhan keperawatan berbasis riset. Selanjutnya, buku ini juga menguraikan implementasi berbagai model dalam pelayanan, seperti evidence-based nursing, pemberdayaan keluarga, transcultural nursing, continuity of care, self-care, dan collaborative care. Pada bagian akhir, pembaca diajak untuk menelaah arah pengembangan model keperawatan Indonesia, termasuk kondisi eksisting, strategi implementasi, peluang, serta prospek masa depan dalam menjawab tantangan sistem pelayanan kesehatan nasional.

Penulis menyadari bahwa pengembangan model asuhan keperawatan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan kolaborasi antara dunia pendidikan, penelitian, pelayanan, organisasi profesi, serta masyarakat. Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan akademik, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menghasilkan inovasi model keperawatan yang berbasis bukti, berakar pada nilai budaya Indonesia, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi penguatan keilmuan keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 KONSEP PENGEMBANGAN MODEL DALAM KEPERAWATAN 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Model Keperawatan.....	2
C. Komponen Model Keperawatan	3
D. Perbedaan Model, Teori, dan Konsep	4
E. Metaparadigma Keperawatan.....	5
F. Teori-Teori Model Keperawatan	7
G. Pengembangan Model Keperawatan.....	12
H. Pengembangan Model Berbasis Penelitian.....	13
I. Implementasi Model Dalam Praktik Keperawatan	13
J. Evaluasi dan Pengembangan Model Keperawatan Berbasis Bukti	15
K. Tren dan Inovasi dalam Model Keperawatan	16
Referensi	18
Glosarium	20

BAB 2 INTEGRASI TEORI DAN PRAKTIK.....23

A. Hakikat Integrasi Teori dan Praktik dalam Keperawatan.....	23
B. Dinamika Kesenjangan Teori dan Praktik di Indonesia	24
C. Kerangka Konseptual Integrasi Teori dan Praktik	26
D. Proses Berpikir dan Pengambilan Keputusan dalam Integrasi Teori dan Praktik.....	27
E. Strategi Integrasi dalam Pembelajaran Keperawatan.....	28
F. Peran Pendidik dan Praktisi dalam Integrasi Teori dan Praktik.....	30
G. Hambatan Integrasi dan Upaya Penguatan	31
H. Penerapan Integrasi Teori dan Praktik	33
I. Penutup.....	36
Referensi	37

BAB 3 MODEL ASUHAN KEPERAWATAN KLINIK39

A. Pendahuluan.....	39
B. Konsep Model Asuhan Keperawatan Klinik	39
C. Jenis Model Asuhan keperawatan Klinik.....	41

D. Model Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)	44
E. Dokumentasi Keperawatan (SDKI-SIKI-SLKI)	46
F. Diagram Model Asuhan Keperawatan Klinik Berbasis EBP	48
G. Implementasi Model	51
H. Integrasi Teknologi dalam Model	53
I. Penutup	54
Referensi	55
 BAB 4 MODEL ASUHAN BERBASIS KOMUNITAS	57
A. Pendahuluan	57
B. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan Berbasis Komunitas	58
C. Teori dan Model keperawatan Komunitas	59
D. Jenis Jenis Pendekatan Asuhan Berbasis Komunitas	66
E. Inovasi Dan Pengembangan Model Asuhan Komunitas	68
F. Asuhan keperawatan Komunitas	71
G. Kaitan riset keperawatan dan model asuhan berbasis komunitas	73
H. Isu dan Tantangan dalam Keperawatan Komunitas	75
I. Penutup	77
Referensi	78
 BAB 5 VALIDASI DAN UJI MODEL ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS RISET	83
A. Pendahuluan	83
B. Kerangka Teori Dalam Pengembangan Model Asuhan Keperawatan	85
C. Konsep Model Asuhan Keperawatan	87
D. Pentingnya Validasi Model Keperawatan Berbasis Riset	89
E. Pengujian Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset	94
F. Implikasi Model Keperawatan Dalam Pelayanan Kesehatan	98
G. Penutup	98
Referensi	99
Glosarium	106
 BAB 6 IMPLEMENTASI MODEL DALAM PELAYANAN	109
A. Pendahuluan	109
B. Implementasi Model Asuhan Keperawatan Berbasis Evidence-Based Nursing dalam Pelayanan Klinis	109
C. Implementasi Model Pemberdayaan Keluarga dalam Pelayanan Keperawatan Komunitas	111

D. Implementasi Model <i>Transcultural Nursing</i> dalam Pelayanan Keperawatan di Indonesia.....	114
E. Implementasi Model <i>Continuity of Care</i> dalam Pelayanan Keperawatan Maternal dan Anak.....	115
F. Implementasi Model <i>Self-Care</i> dalam Manajemen Penyakit Kronis	117
G. Implementasi Model <i>Collaborative Care</i> dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	119
H. Penutup.....	120
Referensi	122
Glosarium	132
BAB 7 ARAH PENGEMBANGAN MODEL KEPERAWATAN INDONESIA	133
A. Pendahuluan.....	133
B. Konsep Dasar Model Keperawatan.....	134
C. Kondisi Eksisting Model Keperawatan di Indonesia	137
D. Konsep Landasan Pengembangan Model Keperawatan di Indonesia	139
E. Arah Pengembangan Model Keperawatan Indonesia.....	141
F. Strategi Implementasi Pengembangan Model	144
G. Peluang dan Prospek Masa Depan	146
H. Kesimpulan	148
Referensi	149
Glosarium	150
PROFIL PENULIS	153

BAB 1

KONSEP PENGEMBANGAN MODEL DALAM KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Model keperawatan membantu perawat memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Perkembangan model keperawatan tidak dapat dipisahkan dari evolusi paradigma keilmuan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring waktu.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, model keperawatan berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang memberikan arah dan panduan bagi praktik keperawatan profesional. Menurut Blais et al. (2005), model keperawatan membantu mendefinisikan ruang lingkup praktik, memberikan dasar untuk pendidikan keperawatan, dan mengarahkan penelitian keperawatan. Tanpa adanya model yang jelas, praktik keperawatan berisiko kehilangan identitas profesinya dan bercampur dengan disiplin ilmu kesehatan lainnya.

Situasi kesehatan global yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular, bahkan pandemi, hingga perubahan demografi, menuntut pendekatan keperawatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Model keperawatan yang relevan secara kontekstual mampu merespons kebutuhan pasien secara holistik, mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan visi World Health Organization (WHO) tentang pelayanan kesehatan yang berorientasi pada manusia seutuhnya.

Di Indonesia, pengembangan model keperawatan masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik di lapangan, sebagian besar penerapan model keperawatan masih mengadopsi model-model barat tanpa adaptasi yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal. Padahal, keberhasilan implementasi model keperawatan sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan konteks budaya, sosial, dan sistem kesehatan setempat.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan kesehatan membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi pengembangan model keperawatan. Topaz & Pruinelli (2017) mengemukakan bahwa integrasi kecerdasan buatan, telehealth, dan sistem informasi keperawatan ke dalam praktik klinis membutuhkan keahlian perawat memanfaatkan big data kedalam suatu

penerapan ataupun kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep pengembangan model keperawatan menjadi semakin krusial.

Buku referensi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang konsep pengembangan model dalam keperawatan, mulai dari fondasi teoritis hingga aplikasi praktis di berbagai setting klinis, dengan mempertimbangkan konteks Indonesia dan perkembangan ilmu keperawatan terkini.

Buku referensi ini mencakup konsep dasar model keperawatan, dilanjutkan dengan tinjauan komprehensif terhadap teori-teori keperawatan utama, proses pengembangan model, implementasi praktis, evaluasi berbasis bukti, hingga tren dan inovasi terkini dalam keperawatan.

B. Konsep Dasar Model Keperawatan

Model dalam konteks keilmuan merupakan representasi simbolis, gambar, atau konstruksi dari suatu konsep atau ide yang lebih besar dan kompleks. Dalam keperawatan, model berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengorganisasikan pengetahuan keperawatan secara sistematis. McEwen dan Wills (2019) mendefinisikan model keperawatan sebagai representasi konseptual dari hubungan antara konsep-konsep kunci dalam keperawatan, yang memberikan kerangka kerja untuk praktik, Pendidikan, dan penelitian.

Secara historis, penggunaan model dalam keperawatan dimulai sejak era Florence Nightingale yang mengembangkan konsep lingkungan sebagai determinan utama kesehatan pasien. Nightingale, melalui karya monumentalnya "Notes on Nursing" (1859), telah meletakkan fondasi pertama model keperawatan modern dengan menekankan pentingnya ventilasi, sanitasi, dan kondisi lingkungan dalam proses penyembuhan. Meskipun tidak diformulasikan secara eksplisit sebagai "model," pemikirannya menjadi cikal bakal pengembangan model-model keperawatan selanjutnya.

Dalam perkembangannya, berbagai tokoh keperawatan mendefinisikan model dengan penekanan yang berbeda-beda. Fawcett (2012) membedakan antara model konseptual dan teori keperawatan, di mana model konseptual bersifat lebih abstrak dan umum, sedangkan teori lebih spesifik dan dapat diuji secara empiris. Perbedaan hierarkis ini penting dipahami karena menentukan bagaimana suatu kerangka berpikir diterapkan dalam konteks penelitian maupun praktik klinik.

C. Komponen Model Keperawatan

Setiap model keperawatan umumnya terdiri dari empat komponen utama yang membentuk metaparadigma keperawatan. Peterson dan Bredow (2019) menjelaskan bahwa keempat komponen tersebut—manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan—saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk fondasi dari setiap model keperawatan yang dikembangkan. Pemahaman terhadap komponen-komponen ini merupakan prasyarat untuk dapat menganalisis dan menerapkan model keperawatan secara efektif.

1. Manusia (Person)

Komponen manusia dalam model keperawatan mencakup pandangan tentang siapa yang menjadi penerima asuhan keperawatan. Manusia dipandang secara holistik, meliputi dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pandangan holistik ini membedakan pendekatan keperawatan dari pendekatan biomedis yang lebih menekankan pada dimensi fisik semata.

Dalam perkembangan terkini, konsep manusia dalam keperawatan diperluas untuk mencakup tidak hanya individu tetapi juga keluarga, kelompok, komunitas, dan populasi. Pender et al. (2021) dalam model promosi kesehatan mereka menekankan bahwa manusia merupakan makhluk aktif yang berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan tentang kesehatannya sendiri.

2. Lingkungan (Environment)

Lingkungan dalam konteks model keperawatan mencakup semua kondisi, keadaan, dan pengaruh yang melingkupi serta mempengaruhi perkembangan organisme. Nightingale pertama kali menekankan pentingnya lingkungan fisik dalam proses penyembuhan. Seiring waktu, konsep lingkungan berkembang untuk mencakup dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang turut mempengaruhi kesehatan individu. Pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan protektif yang mempengaruhi status kesehatan klien.

3. Kesehatan (Health)

Konsep kesehatan dalam model keperawatan telah mengalami evolusi dari sekadar “absens penyakit” menjadi konsep yang jauh lebih kompleks dan multidimensional. Menurut Wills dan McEwen (2019), kesehatan dalam perspektif keperawatan kontemporer dipahami sebagai keadaan sejahtera yang dinamis, mencakup kapasitas untuk berfungsi optimal dalam konteks sosial dan

lingkungan seseorang. Pandangan ini selaras dengan definisi WHO yang mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh.

4. Keperawatan (Nursing)

Komponen keperawatan dalam model keperawatan mendefinisikan tujuan, peran, dan fungsi perawat dalam hubungannya dengan klien. Berbagai model keperawatan memberikan penekanan yang berbeda pada komponen ini. Sebagai contoh, Orem menekankan peran perawat dalam membantu klien yang mengalami defisit perawatan diri, sementara Watson menekankan aspek caring dan hubungan terapeutik sebagai inti dari praktik keperawatan (Watson et al., 2021). Perbedaan perspektif ini mencerminkan kekayaan dan keberagaman pendekatan dalam keperawatan sebagai disiplin ilmu.

D. Perbedaan Model, Teori, dan Konsep

Dalam literatur keperawatan, istilah model, teori, dan konsep sering digunakan secara bergantian, padahal ketiganya memiliki makna yang berbeda dan menempati posisi hierarkis yang berbeda dalam struktur pengetahuan keperawatan. Fawcett dan DeSanto-Madeya (2013) menjelaskan struktur pengetahuan keperawatan dalam empat tingkatan: metaparadigma, filosofi, model konseptual, dan teori—dari yang paling abstrak ke yang paling konkret.

Pada umumnya ketika pembahasan berfokus pada praktik keperawatan berbasis model konseptual, teori dan indikator empiris tidak disebutkan. Demikian pula, ketika pembahasan berfokus pada praktik keperawatan berbasis teori, model konseptual dan indikator empiris mungkin tidak disebutkan. Padahal menurut Fawcett dan DeSanto-Madeya (2013) Penerapan model konseptual keperawatan atau teori keperawatan dalam dunia nyata praktik keperawatan, penelitian keperawatan, pendidikan keperawatan, atau administrasi keperawatan terjadi ketika suatu model konseptual, satu atau lebih teori, serta satu atau lebih indikator empiris dihubungkan untuk membentuk suatu sistem pengetahuan keperawatan yang bersifat konseptual-teoretis-empiris. Oleh karena itu, aktivitas praktis dan ilmiah yang berbasis model konseptual atau teori pada dasarnya melibatkan implementasi suatu sistem pengetahuan keperawatan conceptual-theoretical-empirical secara utuh (sistem C-T-E). Praktik keperawatan berbasis sistem C-T-E didefinisikan sebagai pelayanan kepada masyarakat yang dipandu oleh pengetahuan yang spesifik dalam disiplin keperawatan, sebagaimana diartikulasikan dalam model konseptual keperawatan dan teori keperawatan. Penerapan sistem C-T-E dalam praktik keperawatan memerlukan tingkat berpikir

kritis yang tinggi; penalaran klinis; penggunaan keterampilan psikomotor yang efisien dan efektif; hubungan interpersonal yang peka terhadap budaya; serta proses keperawatan yang didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia, sesuai secara etis, dan mempertimbangkan perspektif semua pihak yang berkepentingan.

Konsep merupakan unit fundamental dari pengetahuan yang merepresentasikan ide, objek, atau fenomena tertentu. Teori terdiri dari serangkaian konsep yang saling terhubung untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan suatu fenomena. Di sisi lain, model berfungsi sebagai representasi dari teori atau sekelompok konsep yang memberikan gambaran tentang bagaimana fenomena keperawatan berinteraksi. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk menghindari ambiguitas dalam komunikasi ilmiah dan pengembangan pengetahuan keperawatan.

Model konseptual atau teori keperawatan yang dipilih harus sesuai dengan populasi partisipan keperawatan yang dilayani oleh institusi pelayanan kesehatan serta selaras dengan filosofi keperawatan. Jika titik awalnya adalah teori keperawatan, maka model konseptual yang menjadi dasar pengembangan teori tersebut harus diidentifikasi, begitu pula indikator empiris yang sesuai. Jika titik awalnya adalah model konseptual, maka perlu diidentifikasi teori-teori keperawatan yang unik serta teori dari disiplin ilmu terkait yang mendukung pengetahuan spesifik yang dibutuhkan dalam praktik dengan populasi partisipan keperawatan yang dilayani oleh institusi kesehatan tersebut. Teori-teori ini merupakan bentuk bukti untuk praktik keperawatan berbasis bukti, berupa deskripsi, penjelasan, dan prediksi yang relatif konkret dan spesifik mengenai individu dengan berbagai kondisi Kesehatan.

Teori-teori tersebut tersusun atas konsep dan proposisi yang merupakan hasil dari penelitian keperawatan serta penelitian dalam disiplin ilmu terkait seperti fisiologi, biokimia, nutrisi, farmakologi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan. Laporan hasil penelitian yang relevan dapat ditemukan dalam buku teks, jurnal praktik spesialis, dan jurnal penelitian.

E. Metaparadigma Keperawatan

Metaparadigma keperawatan merupakan konsep-konsep global yang mengidentifikasi fenomena minat keperawatan dan mengajukan hubungan umum di antara konsep-konsep tersebut. Jacqueline Fawcett pada 1984 pertama kali memperkenalkan konsep metaparadigma keperawatan yang terdiri dari empat konsep: person (manusia), environment (lingkungan), health (kesehatan), dan nursing (keperawatan), yang kemudian dikenal dengan akronim PEHN. Keempat

konsep ini memberikan fondasi universal bagi semua model dan teori keperawatan.

Konsep-konsep dalam metaparadigma keperawatan mengidentifikasi fenomena yang menjadi fokus disiplin keperawatan, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Ketika diterjemahkan, konsep-konsep metaparadigma tersebut menjadi: partisipan keperawatan—yang dapat berupa individu, keluarga, komunitas, atau seluruh masyarakat—yang membutuhkan asuhan keperawatan; lingkungan dari partisipan keperawatan, termasuk orang-orang terdekat, kondisi fisik sekitar, dan setting praktik keperawatan; kondisi kesehatan partisipan keperawatan; serta proses keperawatan, atau metode praktik yang digunakan (Fawcett dan DeSanto-Madeya, 2013).

Metaparadigma dari suatu disiplin ilmu menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan keilmuan yang khas dalam bidangnya masing-masing. Hal ini merupakan dasar bagi aktivitas ilmiah yang diperlukan untuk memajukan suatu profesi (Purisima, et. al., 2024). Sebagai contoh penelitian pengembangan model yang dilakukan oleh Purisima dkk adalah membingkai ulang domain lingkungan dalam metaparadigma keperawatan: eksplorasi ruang, tempat, dan teknologi. Dimana hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

No	Teori	Definisi Lingkungan
1	Nightingale's Environmental Theory (Nightingale, 1859)	Lingkungan mencerminkan model kesehatan komunitas, di mana segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dianggap penting bagi kondisi kesehatannya.
2	Roy's Adaptation Model (Roy, 1974)	Lingkungan didefinisikan sebagai kondisi, keadaan, dan pengaruh yang memengaruhi perkembangan dan perilaku manusia sebagai sistem adaptif. Lingkungan merupakan stimulus atau masukan yang menuntut seseorang untuk beradaptasi. Stimulus ini dapat bersifat positif maupun negatif.
3	Watson's Theory of Human Caring (Watson, 1979)	Lingkungan bergantung pada masyarakat yang menyediakan nilai-nilai yang menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku dan tujuan apa yang harus dicapai. Caring (kepedulian) dan keperawatan telah ada di setiap masyarakat. Setiap masyarakat memiliki individu yang peduli terhadap orang lain. Sikap peduli tidak diwariskan secara genetik, melainkan ditransmisikan melalui budaya

		profesi sebagai cara unik dalam menghadapi lingkungan.
4	King's Theory of Goal Attainment (King, 1971)	Lingkungan merupakan dasar bagi interaksi manusia. Lingkungan bersifat eksternal maupun internal terhadap individu.
5	Orem's Theory of Self-Care (Orem, 1991)	Lingkungan memiliki karakteristik fisik, kimia, dan biologis. Lingkungan juga mencakup keluarga, budaya, dan komunitas.

Metaparadigma membedakan setiap disiplin ilmu berdasarkan bagaimana masing-masing disiplin tersebut mengembangkan pengetahuan dan keilmuannya. Empat domain yang membentuk metaparadigma keperawatan adalah lingkungan, manusia, kesehatan, dan keperawatan. Di antara domain tersebut, domain lingkungan merupakan yang paling kurang teridentifikasi. Mengaitkan domain ini dengan makna substantif yang lebih luas dari konteks geografis dan lanskap dalam pertemuan keperawatan memerlukan penjelasan lebih lanjut (Purisima, et. al., 2024).

Melalui suatu proses diskursif, artikel ini memposisikan “ruang dan tempat” dengan merujuk pada lingkungan keperawatan. Artikel ini bertujuan untuk memperjelas dan menjelaskan perluasan cakupan domain lingkungan, dengan memperluas definisinya sekaligus mengakui jangkauan pengaruhnya dalam keperawatan dan pelayanan kesehatan (Purisima, et. al., 2024).

Membedakan lingkungan keperawatan sebagai domain yang mapan dalam metaparadigma keperawatan akan membuat praktik keperawatan menjadi lebih terlihat, bernilai, dan relevan. Sebagai domain yang ditandai oleh pengaruhnya terhadap pengembangan pengetahuan dalam disiplin yang membimbing praktik profesional, lingkungan menempati “ruang dan tempat” yang integral dalam praktik pelayanan kesehatan manusia (Purisima, et. al., 2024).

Dalam perkembangan terkini, beberapa ahli mengusulkan perluasan metaparadigma keperawatan untuk memasukkan dimensi-dimensi baru. Membingkai ulang dimensi-dimensi baru ini diharapkan dapat memperkuat relevansi dan aplikabilitas model keperawatan dalam menghadapi tantangan kesehatan kontemporer.

F. Teori-Teori Model Keperawatan

Berikut ini adalah beberapa teori model keperawatan yang menjadi acuan dalam praktik keperawatan:

1. Florence Nightingale: Teori Lingkungan

Florence Nightingale (1820–1910) sering disebut sebagai ibu keperawatan modern dan pelopor pertama pengembangan model keperawatan. Meskipun Nightingale tidak secara eksplisit menamakan karyanya sebagai “model,” pemikirannya tentang peran lingkungan dalam kesehatan telah membentuk dasar bagi perkembangan teori keperawatan selanjutnya. Kolagari (2023) menganalisis bahwa kontribusi Nightingale dalam statistik kesehatan dan manajemen lingkungan masih relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks keperawatan modern.

Model Nightingale berfokus pada manipulasi lingkungan untuk meningkatkan kesehatan pasien. Nightingale mengidentifikasi lima elemen lingkungan yang esensial: udara segar, air bersih, drainase yang efisien, kebersihan, dan cahaya. Dalam konteks kontemporer, Kozier et al. (2022) menginterpretasikan model Nightingale secara lebih luas untuk mencakup lingkungan sosial dan psikologis, tidak hanya lingkungan fisik. Interpretasi ini memperluas relevansi model Nightingale untuk diterapkan dalam setting keperawatan komunitas, kesehatan lingkungan, dan promosi kesehatan.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip model Nightingale masih sangat relevan dalam era pandemi dan perubahan iklim. Penerapan prinsip-prinsip lingkungan Nightingale dalam desain fasilitas kesehatan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka infeksi nosokomial dan peningkatan kepuasan pasien. Temuan ini memperkuat argumen tentang keberlanjutan relevansi model klasik ini dalam konteks modern

2. Virginia Henderson: Kebutuhan Dasar Manusia

Virginia Henderson (1897–1996) mengembangkan definisi keperawatan yang menjadi salah satu yang paling banyak dikutip dalam literatur keperawatan global. Henderson mendefinisikan fungsi unik perawat sebagai membantu individu, baik yang sakit maupun sehat, dalam melakukan kegiatan yang berkontribusi pada kesehatan, pemulihan, atau kematian yang damai—kegiatan yang akan mereka lakukan sendiri jika mereka memiliki kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang diperlukan.

Model Henderson terdiri dari 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang meliputi: bernapas normal, makan dan minum dengan cukup, eliminasi, bergerak dan mempertahankan postur tubuh, tidur dan istirahat, berpakaian, mempertahankan suhu tubuh, menjaga kebersihan tubuh, menghindari bahaya lingkungan, berkomunikasi, beribadah, bekerja, bermain dan rekreasi, serta belajar. McEwen dan Wills (2019) menjelaskan bahwa keempat belas komponen

ini mencerminkan pemahaman Henderson tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

3. Dorothea Orem: Teori Perawatan Diri

Dorothea Orem (1914–2007) mengembangkan Self-Care Deficit Nursing Theory (SCDNT) yang merupakan salah satu grand theory keperawatan yang paling berpengaruh dan banyak diaplikasikan secara luas. Teori Orem terdiri dari tiga teori yang saling berkaitan: teori perawatan diri (self-care theory), teori defisit perawatan diri (self-care deficit theory), dan teori sistem keperawatan (Alligood, 2022).

Konsep sentral dalam teori Orem adalah “self-care,” yaitu aktivitas yang dilakukan individu secara mandiri untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan dirinya, terjadi “self-care deficit” yang memerlukan intervensi keperawatan. Orem mengidentifikasi tiga sistem keperawatan: sistem kompensasi penuh (wholly compensatory), kompensasi sebagian (partially compensatory), dan sistem suportif-edukatif (Alligood, 2022). Klasifikasi ini membantu perawat dalam menentukan tingkat intervensi yang tepat berdasarkan kapasitas klien untuk melakukan perawatan diri.

Penelitian terkini menunjukkan relevansi teori Orem dalam berbagai setting klinis. Jandaghian, et. al.(2024) melakukan penelitian pada pasien diabetes melitus dan menemukan bahwa Model perawatan diri Orem dapat mengurangi gejala diabetes serta meningkatkan kualitas hidup, efikasi diri, dan kemampuan perawatan diri pada pasien dengan penyakit tidak menular tersebut.

4. Sister Callista Roy: Teori Adaptasi

Sister Callista Roy mengembangkan Roy Adaptation Model (RAM) sejak tahun 1964 dan terus menyempurnakannya hingga edisi terbaru. Model ini memandang manusia sebagai sistem adaptif yang berinteraksi dengan lingkungan melalui empat mode adaptasi: fisiologis-fisik, konsep diri-identitas kelompok, fungsi peran, dan interdependensi. Tujuan keperawatan dalam RAM adalah meningkatkan respons adaptif klien dan mengurangi respons yang tidak efektif.

Adaptasi adalah suatu proses di mana seseorang terlibat secara aktif dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan berbagai strategi. Model adaptasi Roy memandang individu sebagai sistem adaptif yang berada dalam interaksi yang stabil dengan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, individu terus

mengalami perubahan dan berusaha untuk beradaptasi. Ketika individu tidak mampu melakukan adaptasi yang diharapkan sehingga menghasilkan respons yang tidak efektif, perawat akan mengidentifikasi hal tersebut.

Hosseini, M., & Soltanian, M. (2022) dalam penelitiannya melakukan tinjauan sistematis terhadap studi-studi yang dilakukan di Iran mengenai model adaptasi Roy. Hasil penelitian menunjukkan penerapan program perawatan yang berbasis pada model adaptasi Roy meningkatkan perilaku adaptif (sehat) baik secara fisik maupun psikologis pada pasien dengan penyakit kronis. Hal ini dapat meningkatkan adaptasi psikologis pasien terhadap penyakit, pengendalian penyakit yang lebih baik, pengurangan komplikasi, serta kualitas asuhan keperawatan.

5. Betty Neuman: Sistem Kesehatan

Betty Neuman mengembangkan Neuman Systems Model (NSM) yang memandang klien sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai stresor lingkungan. Model ini menggunakan metafora lingkaran konsentris untuk menggambarkan tingkatan pertahanan klien: garis pertahanan fleksibel, garis pertahanan normal, dan garis resistensi (Alligood, 2021). Tujuan keperawatan dalam NSM adalah mempertahankan stabilitas sistem klien melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

Keperawatan adalah suatu profesi yang membutuhkan dedikasi tinggi dan keterlibatan pribadi yang besar. Perawat menghadapi stres yang berulang akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan. Burnout terjadi ketika perawat menjadi putus asa dan memiliki berkurangnya rasa empati terhadap pasien akibat beban yang terus-menerus. Stres dan burnout merupakan dua alasan paling umum yang menyebabkan perawat meninggalkan pekerjaan di rumah sakit. NSM (Neuman Systems Model) berfokus pada stresor yang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang (prediksi). Perawat membantu pasien pada saat-saat paling rentan dan menantang, seperti prosedur pembedahan, trauma, serta kehilangan pribadi dan fisik (Yaqoob, et. al., 2023).

Yaqoob, et. al., (2023) menyatakan NSM memungkinkan dilakukannya kajian terhadap intervensi yang bersifat preventif dan protektif. Karena fleksibilitas model ini, NSM dapat digunakan dalam berbagai situasi keperawatan. Pihak manajemen, rumah sakit, klinik, dan perawat lainnya dapat memperoleh manfaat dari paradigma ini. Selain itu, berbagai faktor yang berkontribusi terhadap burnout juga dapat dievaluasi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor klien seperti karakteristik fisiologis, sosiokultural,

perkembangan, dan spiritual. Memandang individu sebagai sistem terbuka yang merespons stimulus lingkungan mendorong pemahaman bahwa adanya stresor dapat memicu terjadinya burnout.

Keunggulan NSM terletak pada kemampuannya untuk diterapkan pada berbagai tingkatan klien—individu, keluarga, kelompok, komunitas, hingga organisasi.

6. Jean Watson: Teori Caring

Jean Watson mengembangkan Theory of Human Caring yang menempatkan caring sebagai esensi fundamental dari keperawatan. Watson mengidentifikasi sepuluh “Caritas Processes” sebagai panduan untuk praktik keperawatan yang berbasis caring, yang mencakup: membentuk sistem nilai humanistik-altruistik, menanamkan kepercayaan dan harapan, mengembangkan kepekaan terhadap diri dan orang lain, hingga mengizinkan kekuatan eksistensial-spiritual (Watson, 2018). Pendekatan Watson menekankan dimensi relasional dan humanistik dalam keperawatan.

Teori Watson memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kesehatan mental dan perawatan paliatif. Pajnkihar et al. (2017) melakukan penelitian pada tenaga perawat di unit perawatan paliatif dan menemukan bahwa perawat yang menerapkan prinsip-prinsip caring Watson menunjukkan tingkat burnout yang lebih rendah dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa teori Watson tidak hanya bermanfaat bagi klien tetapi juga bagi perawat itu sendiri sebagai pribadi yang merawat.

Dalam perkembangan terkini, Watson terus memperbarui teorinya untuk merespons perkembangan zaman. Watson (2018) memperkenalkan konsep “Unitary Caring Science” yang mengintegrasikan dimensi spiritual, kosmologi, dan etika universal ke dalam praktik caring keperawatan. Pengembangan ini mencerminkan komitmen Watson terhadap kedalaman dan keluasan disiplin keperawatan sebagai ilmu yang berorientasi pada kemanusiaan.

7. Madeline Leininger: Teori transcultural dalam keperawatan

Madeleine Leininger mengembangkan Culture Care Diversity and Universality Theory yang menjadi landasan keperawatan transkultural. Leininger berargumen bahwa perawatan (care) merupakan esensi keperawatan, dan bahwa perawatan bersifat kultural—berbeda-beda di setiap budaya sekaligus memiliki unsur-unsur universal yang diakui secara lintas budaya (McFarland & Wehbe-Alamah, 2019). Model Sunrise (Sunrise Model) yang dikembangkan

Leininger memberikan panduan visual tentang faktor-faktor budaya yang mempengaruhi ekspresi perawatan.

Relevansi model Leininger sangat tinggi dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Penelitian Latumenasse (2026) menerapkan teori Leininger dalam mengevaluasi efektivitas model keperawatan transkultural dalam meningkatkan perawatan gizi dan kepuasan pasien dalam lingkungan rumah sakit multikultural. Temuan studi menunjukkan bahwa model keperawatan transkultural secara efektif meningkatkan perawatan nutrisi yang sensitif secara budaya dan kepuasan pasien di lingkungan rumah sakit multicultural

Dalam era globalisasi, keperawatan transkultural semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. McFarland dan Wehbe-Alamah (2019) menekankan bahwa kompetensi kultural bukan hanya tentang memahami budaya orang lain, tetapi juga tentang refleksi terhadap bias budaya diri sendiri sebagai perawat. Pengembangan kompetensi kultural ini menjadi salah satu prioritas dalam pendidikan keperawatan kontemporer, terutama di negara-negara dengan populasi yang beragam.

G. Pengembangan Model Keperawatan

Pengembangan model keperawatan merupakan proses yang sistematis, metodologis, dan memerlukan integrasi antara teori, penelitian, dan praktik. Pengembangan model yang baik mencakup beberapa tahapan: identifikasi fenomena minat, review literatur yang komprehensif, analisis konsep, pembangunan pernyataan relasional, dan pengujian empiris. Setiap tahapan memiliki kontribusi yang tidak tergantikan dalam menghasilkan model yang valid, reliabel, dan dapat diterapkan.

Tahap awal pengembangan model keperawatan dimulai dari identifikasi fenomena keperawatan yang belum terpenuhi secara teoritis. Pentingnya melakukan gap analysis yang sistematis dalam literatur keperawatan untuk mengidentifikasi area-area di mana pemahaman teoritis masih terbatas. Gap analysis ini dapat dilakukan melalui systematic review, meta-analisis, atau konsultasi dengan pakar dan praktisi keperawatan yang berpengalaman.

Tahap selanjutnya adalah pengembangan konsep-konsep utama model melalui analisis konsep yang mendalam. Analisis konsep merupakan proses eksplorasi sistematis terhadap konsep untuk mengidentifikasi atribut-atribut definisinya, kasus-kasus yang menggambarkan konsep tersebut, anteseden, dan konsekuensi.

Evaluasi terhadap suatu model keperawatan memerlukan kriteria yang jelas dan terstandar. Fawcett (2012) mengusulkan enam kriteria evaluasi model keperawatan: eksplisitnya pernyataan tentang keempat konsep metaparadigma, kesesuaian antara filosofi dengan komponen model, logika dan konsistensi internal, kapasitas generatif penelitian, kapasitas implementasi praktik, dan kontribusi terhadap pengetahuan disiplin keperawatan.

H. Pengembangan Model Berbasis Penelitian

Penelitian merupakan tulang punggung dari pengembangan model keperawatan yang valid dan dapat diandalkan. Pendekatan penelitian campuran (mixed methods) semakin diakui sebagai strategi yang paling komprehensif dalam pengembangan model keperawatan, karena mampu mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk membangun pemahaman yang lebih utuh. Hirose & Creswell (2023) menekankan bahwa mixed methods research sangat sesuai untuk pengembangan model karena memungkinkan validasi statistik sekaligus pemahaman kontekstual yang mendalam.

Grounded theory merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengembangan model keperawatan, khususnya untuk fenomena yang belum memiliki kerangka teoritis yang memadai. Pendekatan grounded theory memungkinkan pengembangan teori yang berakar pada data empiris, sehingga menghasilkan model yang lebih relevan dengan realitas praktik keperawatan.

Systematic review dan meta-analisis juga memainkan peran penting dalam pengembangan dan validasi model keperawatan. Systematic review memberikan sintesis evidence terbaik yang tersedia, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan dan pembaruan model keperawatan. Proses ini memastikan bahwa model yang dikembangkan dilandasi oleh bukti empiris yang kuat, bukan sekadar spekulasi teoritis.

I. Implementasi Model Dalam Praktik Keperawatan

Implementasi Model Dalam Praktik Keperawatan meliputi penerapan model dalam setting klinik dan penerapan proses keperawatan berbasis model, serta dokumentasi asuhan keperawatan.

1. Penerapan Model dalam Setting Klinik

Implementasi model keperawatan dalam setting klinik merupakan jembatan antara teori dan praktik. Meskipun model keperawatan telah dikembangkan secara ekstensif di ranah akademis, penerapannya di lingkungan klinis masih menghadapi berbagai hambatan. Alligood (2022) mengidentifikasi

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi model di klinik, antara lain: dukungan administratif institusi, kompetensi staf perawat, ketersediaan waktu untuk pendidikan, dan budaya organisasi yang mendukung praktik berbasis teori.

Setting rumah sakit merupakan konteks yang paling banyak dikaji dalam implementasi model keperawatan. Penelitian Wulandari (2021) di rumah sakit menunjukkan bahwa implementasi manajemen discharge planning secara efektif meningkatkan kepuasan pasien dan peran perawat dalam pemenuhan 14 kebutuhan dasar model Henderson di unit rawat inap. Peningkatan kualitas pengkajian keperawatan, berkurangnya insiden komplikasi yang dapat dicegah, dan peningkatan kepuasan pasien. Keberhasilan ini dikaitkan dengan komponen-komponen model Henderson.

Setting keperawatan komunitas juga menjadi area yang penting bagi implementasi model keperawatan. Blais et al. (2022) menjelaskan bahwa model keperawatan komunitas membutuhkan pendekatan yang berbeda dari model yang dirancang untuk setting akut, karena harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial determinan kesehatan, kapasitas komunitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam. Model seperti NSM Neuman dan model promosi kesehatan Pender sangat sesuai untuk diterapkan dalam setting komunitas karena pendekatannya yang komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

2. Proses Keperawatan Berbasis Model

Proses keperawatan merupakan metode sistematis yang digunakan perawat dalam memberikan asuhan, yang terdiri dari lima tahap: pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ketika dilandasi oleh model keperawatan yang jelas, setiap tahap dalam proses keperawatan menjadi lebih terarah dan bermakna. Potter et al. (2023) menjelaskan bahwa model keperawatan memberikan kerangka konseptual yang membimbing perawat dalam mengidentifikasi data yang relevan, merumuskan diagnosis yang tepat, dan merancang intervensi yang sesuai.

Pengkajian keperawatan yang dilandasi model menghasilkan data yang lebih komprehensif dan terorganisasi. Sebagai contoh, pengkajian berbasis model Orem berfokus pada identifikasi kemampuan perawatan diri klien dan area-area defisit yang memerlukan intervensi keperawatan. Sementara itu, pengkajian berbasis model Roy mengeksplorasi respons adaptif dan maladaptif klien dalam keempat mode adaptasi. Kozier et al. (2022) menekankan bahwa

konsistensi antara model yang dianut dengan instrumen pengkajian yang digunakan merupakan syarat penting untuk validitas data keperawatan.

Pengembangan diagnosis keperawatan yang berlandaskan model teoritis memungkinkan identifikasi masalah yang lebih akurat dan komprehensif. NANDA International terus mengembangkan taksonomi diagnosis keperawatan yang dapat diselaraskan dengan berbagai model keperawatan. Herdman et al. (2021) mempresentasikan pembaruan taksonomi NANDA 2021–2023 yang mencakup diagnosis-diagnosis keperawatan baru yang merespons perubahan konteks kesehatan global, termasuk diagnosis yang berkaitan dengan trauma, ageisme, dan kesehatan digital.

Penelitian Bratajaya & Ernawati (2023) yang berjudul Persepsi Pasien tentang Tantangan Perawatan Luka Kronis Diabetes Melitus serta Implikasinya terhadap Kebutuhan Soft-skills Perawat menunjukkan proses keperawatan berbasis model. Dalam penelitian ini didapati bahwa pasien seringkali merasa malu, takut dan cemas terhadap luka yang dideritanya. Kaitan dengan interaksi perawat dan pasien maka Imogene King (1992) meyakini bahwa persepsi setiap individu berbeda termasuk bagaimana individu merasakan gambaran dirinya. Perawat memiliki peran besar dalam hal ini. Karena, interaksi perawat dan pasien sangat nyata dalam program perawatan luka.

J. Evaluasi dan Pengembangan Model Keperawatan Berbasis Bukti

Evaluasi model keperawatan merupakan proses kritis yang memastikan bahwa model yang digunakan tetap relevan, valid, dan bermanfaat bagi praktik. Pendekatan evaluasi yang komprehensif, mencakup analisis filosofi, analisis model konseptual, analisis teori, dan pengujian empiris. Setiap komponen evaluasi memberikan informasi yang berbeda tentang kekuatan dan keterbatasan suatu model.

1. Evidence-Based Practice (EBP)

Evidence-Based Practice (EBP) dalam keperawatan merupakan integrasi antara bukti penelitian terbaik yang tersedia, keahlian klinik, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan asuhan keperawatan. EBP sebagai proses yang melibatkan lima langkah: formulasi pertanyaan klinis (PICO/PICOT), pencarian evidence, penilaian kritis evidence, integrasi evidence ke dalam praktik, dan evaluasi outcomes.

Hubungan antara model keperawatan dan EBP bersifat saling melengkapi dan memperkuat. Model keperawatan menyediakan kerangka konseptual yang mengarahkan pencarian evidence, sementara evidence yang ditemukan dapat digunakan untuk memperkuat, memodifikasi, atau mengembangkan model.

Wills dan McEwen (2019) berargumen bahwa tanpa kerangka teoritis yang kuat, EBP berisiko menjadi sekadar kumpulan praktik terbaik yang tidak terintegrasi secara koheren. Sebaliknya, tanpa dukungan evidence, model keperawatan berisiko menjadi spekulasi teoritis yang tidak relevan dengan realitas praktik.

Perkembangan terkini dalam EBP keperawatan mencakup penggunaan evidence sintetik melalui systematic review dan meta-analisis.

2. Tantangan Implementasi Model dalam Praktik

Meskipun model keperawatan memiliki nilai yang signifikan secara teoritis, implementasinya dalam praktik klinis masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi secara sistematis.

Hambatan pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling sering disebutkan dalam implementasi model. Banyak perawat yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang model keperawatan selama masa studi mereka, atau mendapatkan pendidikan teoritis yang tidak terhubung dengan aplikasi praktis. Blais et al. (2005) merekomendasikan pendekatan pendidikan yang lebih integratif, di mana model keperawatan diajarkan secara bersamaan dengan keterampilan klinik dalam konteks kasus-kasus nyata, bukan sebagai konstruksi teoritis yang abstrak.

Hambatan sistemik pada tingkat institusi juga perlu mendapat perhatian serius. Dukungan kepemimpinan keperawatan yang kuat merupakan faktor determinan terpenting dalam keberhasilan implementasi model di tingkat institusi. Pemimpin keperawatan yang memahami dan berkomitmen terhadap model keperawatan tertentu akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perawat di bawahnya untuk menerapkan model tersebut dalam praktik sehari-hari.

K. Tren dan Inovasi dalam Model Keperawatan

Tren dan Inovasi Model Keperawatan kian terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi maka penerapan model keperawatan perlu dikembangkan secara relevan.

1. Model Keperawatan di Era Digital

Revolusi digital dalam layanan kesehatan membawa perubahan fundamental yang menuntut adaptasi model keperawatan. Teknologi seperti telehealth, wearable devices, kecerdasan buatan (AI), dan big data analytics mengubah cara perawat berinteraksi dengan pasien, mengumpulkan data klinis, dan membuat keputusan. Topaz et al. (2017) berargumen bahwa model

keperawatan di era digital perlu mengintegrasikan dimensi teknologi sebagai komponen baru yang mempengaruhi semua aspek dari metaparadigma keperawatan—manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan itu sendiri.

Telehealth dan telenursing membuka paradigma baru dalam pemberian asuhan keperawatan yang melampaui batas geografis. Dalam model keperawatan konvensional, interaksi perawat-pasien diasumsikan terjadi secara tatap muka dalam setting fisik tertentu. Telenursing mengadaptasi model keperawatan tradisional ke dalam konteks virtual, dengan menekankan pentingnya literasi digital, keamanan data, dan ekuitas akses teknologi sebagai komponen-komponen baru dalam model keperawatan digital.

Kecerdasan buatan dan machine learning membuka peluang revolusioner dalam keperawatan berbasis data. Algoritma AI dapat menganalisis data klinis dalam jumlah besar untuk memprediksi risiko komplikasi, mengoptimalkan intervensi, dan mendukung pengambilan keputusan klinis.

2. Keperawatan Berbasis Teknologi dan Inovasi

Inovasi teknologi medis seperti robotik, nanotechnology, dan genomics juga membawa implikasi signifikan bagi model keperawatan. Perawat masa depan perlu memiliki kompetensi dalam mengintegrasikan teknologi-teknologi baru ini ke dalam praktik caring yang tetap berpusat pada manusia.

Simulasi dan virtual reality (VR) telah merevolusi pendidikan keperawatan dan memiliki potensi besar dalam implementasi model keperawatan. Teknologi simulasi memungkinkan mahasiswa dan perawat klinisi untuk mempraktikkan penerapan model keperawatan dalam skenario klinis yang realistis tanpa risiko terhadap pasien nyata.

3. Prospek Pengembangan Model Keperawatan ke Depan

Masa depan pengembangan model keperawatan ditandai oleh beberapa tren yang saling berkaitan. Pertama, meningkatnya kolaborasi interprofesional dalam pengembangan model yang mencerminkan realitas layanan kesehatan modern yang bersifat tim-based. Saat ini sebagian besar model keperawatan dikembangkan secara disiplin-spesifik, padahal dalam praktik, perawat bekerja dalam ekosistem profesional yang kompleks.

Kedua, pengembangan model yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan determinan sosial kesehatan. Ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan, diskriminasi rasial, dan kemiskinan sebagai determinan kesehatan semakin mendapat perhatian dalam literatur keperawatan..

Ketiga, pengembangan model-model keperawatan yang lahir dari negara-negara berkembang dan konteks non-Barat. Selama ini, model keperawatan yang diakui secara internasional hampir seluruhnya berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun model-model ini memiliki nilai universal, kontekstualisasi yang lebih dalam terhadap realitas sistem kesehatan dan nilai-nilai budaya negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—diharapkan akan menghasilkan model-model baru yang lebih relevan dan adaptif (McFarland & Wehbe-Alamah, 2019). Perawat dan peneliti keperawatan Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus peluang besar untuk berkontribusi dalam pengembangan model-model keperawatan yang berakar pada kekayaan budaya dan konteks kesehatan lokal.

Keempat, integrasi yang lebih erat antara model keperawatan dengan teknologi informasi kesehatan. Pengkodean model keperawatan ke dalam sistem informasi kesehatan akan memfasilitasi implementasi yang lebih konsisten dan memungkinkan evaluasi berbasis data dalam skala besar.

Referensi

- Alligood, M. R. (2021). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Blais, K., Hayes, J. S., & Kozier, B. (2005). *Professional nursing practice: Concepts and perspectives* (5th ed.). Pearson Education.
- Bratajaya, C. N. A., & Ernawati, E. (2023). Persepsi Pasien tentang Tantangan Perawatan Luka Kronis Diabetes Melitus serta Implikasinya terhadap Kebutuhan Soft-skills Perawat. *Faletehan Health Journal*, 10(02), 121-130.
- Fawcett, J., & DeSanto-Madeya, S. (2013). *Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories*. F.A. Davis Company.
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023* (12th ed.). Thieme.
- Hirose, M., & Creswell, J. W. (2023). Applying core quality criteria of mixed methods research to an empirical study. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(1), 12-28.
- Hosseini, M., & Soltanian, M. (2022). Application of Roy's adaptation model in clinical nursing: A Systematic Review. *Journal of Iranian Medical Council*.
- Jandaghian Bidgoli M, Jamalnia S, Pashmforosh M, Shaterian N, Darabiyani P, Rafi A. (2024) The effect of Orem self-care model on the improvement of symptoms and quality of life in patients with diabetes: A scoping review. *Invest Educ Enferm*. 2024 Mar;42(1):e08. doi: 10.17533/udea.iee.v42n1e08.
- King, I. M. (1992). King's Theory Of Goal Attainment. *Nursing Science Quarterly*, 5(1), 19–26

- Kolagari S. (2023). Increasing Importance of Florence Nightingale's Theory During the 21st-Century Pandemic Period. *Florence Nightingale J Nurs*. doi: 10.5152/FNJJN.2023.23010.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2022). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- McEwen, M., & Wills, E. M. (2019). *Theoretical basis for nursing* (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins
- McFarland MR, Wehbe-Alamah HB. (2019) Leininger's Theory of Culture Care Diversity and Universality: An Overview With a Historical Retrospective and a View Toward the Future. *J Transcult Nurs*. 30(6):540-557. doi: 10.1177/1043659619867134.
- Pajnkihar M, McKenna HP, Štiglic G, Vrbnjak D. (2017). Fit for Practice: Analysis and Evaluation of Watson's Theory of Human Caring. *Nurs Sci Q*. 30(3):243-252. doi: 10.1177/0894318417708409.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2021). *Health promotion in nursing practice* (8th ed.). Pearson Education.
- Peterson, S., & Bredow, T. S. (2019). *Middle range theories: Application to nursing research and practice*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Purísima EM, Arde BO Jr, Nero FD, Locsin RC, Montayre J. (2024) Reframing the environment domain of the nursing metaparadigm: Exploring space, place, and technology. *Belitung Nurs J*. 10(6):614-623. doi: 10.33546/bnj.3458.
- Topaz, M., & Pruinelli, L. (2017). Big data and nursing: implications for the future. *Stud Health Technol Inform*, 232, 165-171.
- Watson, Jean (2018). *Unitary Caring Science: The Philosophy and Praxis of Nursing*. University Press of Colorado
- Wulandari, D. F., Hariyati, R. T. S., & Kuntarti, K. (2021). Henderson's approach in nursing discharge planning to improve patient satisfaction. *Enfermeria clinica*, 31, S170-S174.
- Yaqoob, A., Jan, R., Rattani, S., & Kumar, S. (2023). Betty Neuman system model: a concept analysis. *Anxiety*, 7, 011-015.

Glosarium

A

AI : Artificial Intelligence

C

CTE : Conceptual-Theoretical-Empirical

E

EBP : Evidence-Based Practice

N

NANDA : North American Nursing Diagnosis Association

NSM : Neuman Systems Model

P

PEHN : Person-Environment-Health-Nursing

S

SCDNT : Self-Care Deficit Nursing Theory

V

VR : Virtual Reality

W

WHO : World Health Organization

BAB 2

INTEGRASI TEORI DAN PRAKTIK

A. Hakikat Integrasi Teori dan Praktik dalam Keperawatan

Integrasi teori dan praktik dalam keperawatan pada hakikatnya merupakan cara sistematis dalam menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan tindakan keperawatan. Teori sebagai dasar penalaran yang memandu pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan. Sedangkan praktik adalah wujud nyata dari penerapan ilmu yang telah melalui proses pemahaman, interpretasi, dan penyesuaian dengan kondisi pasien serta lingkungan pelayanan. Integrasi teori dan praktik menekankan bahwa pengetahuan keperawatan dibangun melalui hubungan timbal balik antara ilmu dan pengalaman. Teori memberikan kerangka berpikir untuk memahami fenomena kesehatan, sedangkan praktik menjadi ruang untuk menguji, memperkaya, dan memaknai teori tersebut. Dengan demikian, integrasi bukan sekadar penerapan langsung teori ke praktik, tetapi merupakan proses berpikir reflektif yang melibatkan interpretasi, penyesuaian, dan pengambilan keputusan klinis secara kontekstual.

Seiring dengan perkembangan keperawatan saat ini, integrasi teori dan praktik semakin dipertegas melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based nursing). Pendekatan ini menempatkan hasil penelitian sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga keputusan keperawatan tidak hanya didasarkan pada pengalaman, tetapi juga pada bukti ilmiah yang valid. Integrasi ini penting karena tanpa keterhubungan yang jelas antara teori, riset, dan praktik, pelayanan keperawatan berisiko menjadi tidak konsisten dan kurang optimal dalam mencapai outcome pasien. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam keperawatan. Kesenjangan ini terjadi ketika pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam situasi klinik nyata. Kondisi ini menandakan bahwa integrasi belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam menghubungkan teori, hasil riset, dan praktik keperawatan.

Berdasarkan perspektif pengembangan ilmu, integrasi teori dan praktik memiliki posisi strategis sebagai fondasi berpikir dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset. Integrasi ini tidak berfokus pada bentuk model yang dihasilkan, melainkan pada proses bagaimana teori dan hasil penelitian

dipahami, dimaknai, dan dihubungkan dengan praktik. Integrasi menjadi mekanisme yang memastikan bahwa setiap intervensi keperawatan memiliki dasar ilmiah sekaligus relevansi praktis.

Proses integrasi tersebut mencakup beberapa tahapan berpikir. Pertama, pemahaman terhadap teori sebagai dasar konseptual dalam melihat masalah keperawatan. Kedua, interpretasi hasil penelitian sebagai sumber evidence yang memperkuat atau memodifikasi teori. Ketiga, penghubungan antara teori dan evidence dengan situasi praktik melalui penalaran klinis. Pada tahap ini, perawat tidak hanya menerapkan teori secara langsung, tetapi melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi pasien, sumber daya, serta konteks pelayanan. Oleh karena itu, integrasi teori dan praktik merupakan proses aktif yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan pengambilan keputusan. Proses ini memungkinkan perawat untuk tidak hanya “menggunakan” teori, tetapi juga “memahami” dan “menghidupkan” teori dalam praktik sehari-hari. Integrasi yang baik akan menghasilkan praktik keperawatan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga memiliki landasan ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan integrasi teori dan praktik menjadi sangat penting mengingat kompleksitas pelayanan kesehatan dan keberagaman kondisi masyarakat. Integrasi yang efektif akan membantu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan praktik, sekaligus mendorong pemanfaatan hasil riset dalam pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, integrasi teori dan praktik harus dipandang sebagai proses berpikir yang berkelanjutan, bukan sebagai tahap akhir, melainkan sebagai dasar dalam setiap pengembangan dan penerapan asuhan keperawatan berbasis riset.”

B. Dinamika Kesenjangan Teori dan Praktik di Indonesia

Kesenjangan antara teori dan praktik (theory–practice gap) merupakan fenomena yang masih menjadi tantangan dalam pelayanan keperawatan, termasuk di Indonesia. Kesenjangan ini merujuk pada kondisi ketika pengetahuan teoretis yang diperoleh dalam pendidikan keperawatan tidak sepenuhnya terimplementasi dalam praktik klinik. Dalam konteks pelayanan, bentuk kesenjangan ini tampak pada praktik keperawatan yang lebih banyak didasarkan pada kebiasaan, pengalaman, atau rutinitas kerja, dibandingkan dengan penggunaan teori dan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bentuk kesenjangan di layanan dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara standar asuhan berbasis teori dengan tindakan yang dilakukan di lapangan. Kedua, rendahnya penggunaan hasil penelitian dalam praktik keperawatan sehari-hari. Ketiga, keterbatasan

kemampuan perawat dalam mengaitkan konsep teoretis dengan situasi klinis yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara teori, riset, dan praktik belum terjalin secara optimal dalam sistem pelayanan keperawatan.

Penyebab kesenjangan teori dan praktik bersifat multidimensional, mencakup aspek pendidikan, klinik, dan sistem pelayanan. Pada aspek pendidikan, kurikulum yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan praktik serta keterbatasan pengalaman klinik mahasiswa menjadi faktor penting. Selain itu, metode pembelajaran yang lebih menekankan pada penguasaan teori dibandingkan aplikasi juga berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan (Afaneh et al., 2023). Hasil studi Unis et al. (2025), menunjukkan bahwa kesenjangan teori dan praktik dalam pendidikan keperawatan di Indonesia terlihat dari kurikulum yang masih lebih menekankan aspek teoretis dibandingkan pengalaman praktik yang terintegrasi. Keterbatasan integrasi antara pembelajaran akademik dan praktik klinik menyebabkan mahasiswa kurang optimal dalam menghubungkan pengetahuan teori dengan situasi nyata di lapangan.

Penyebab kesenjangan teori dan praktik pada aspek klinik, lingkungan praktik yang dinamis dan kompleks sering kali tidak selaras dengan kondisi ideal yang diajarkan dalam teori. Perawat di lapangan dihadapkan pada keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, serta keterbatasan sumber daya, sehingga cenderung mengandalkan pengalaman praktis dibandingkan pendekatan berbasis teori. Selain itu, variasi kualitas pembimbing klinik turut memengaruhi kemampuan mahasiswa dan perawat dalam mengintegrasikan teori ke dalam praktik. Berdasarkan penelitian Hasnawati, Putra, dan Kasmini (2023), kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan profesi keperawatan di Indonesia terlihat dari persepsi mahasiswa terhadap bimbingan klinik yang diberikan oleh Clinical Instructor (CI). Meskipun sebagian besar mahasiswa menganggap CI kompeten, kualitas komunikasi dan keterampilan profesional CI perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian kompetensi klinik mahasiswa. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun teori dipahami di kelas, tantangan di lapangan, seperti bimbingan klinik yang tidak optimal, menghambat penerapan teori dalam praktik. Komunikasi CI yang baik berpengaruh pada pemahaman mahasiswa terhadap teori yang diterapkan, sedangkan komunikasi yang buruk memperbesar kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan keperawatan.

Sementara itu, pada aspek sistem pelayanan, kesenjangan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya hubungan antara institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pola hubungan akademik–klinik di Indonesia masih cenderung bersifat administratif, belum sepenuhnya menjadi kemitraan strategis

dalam pengembangan praktik berbasis riset. Hal ini menyebabkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tidak selalu terdiseminasi dan dimanfaatkan secara efektif dalam layanan keperawatan.

Karakteristik kesenjangan dalam konteks Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti keberagaman budaya, variasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar wilayah. Dalam beberapa setting, praktik keperawatan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kebiasaan lokal, yang tidak selalu sejalan dengan pendekatan ilmiah berbasis teori dan riset. Hal ini memperkuat kompleksitas dalam mengintegrasikan teori ke dalam praktik secara konsisten.

Dampak dari kesenjangan teori dan praktik cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan keperawatan. Kesenjangan ini dapat menurunkan kualitas pengambilan keputusan klinis, menghambat penerapan praktik berbasis bukti, serta berpotensi memengaruhi keselamatan pasien. Selain itu, kesenjangan juga berdampak pada perkembangan profesional perawat, termasuk menurunnya kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi klinis. Kesenjangan antara teori dan praktik juga berdampak pada rendahnya pemanfaatan hasil riset dalam pelayanan keperawatan. Hasil penelitian yang seharusnya menjadi dasar pengembangan praktik sering kali tidak diimplementasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara dunia akademik sebagai penghasil ilmu dan dunia praktik sebagai pengguna ilmu. Akibatnya, pengembangan asuhan keperawatan berbasis riset menjadi kurang maksimal (Ugwu et al., 2023).

Dinamika kesenjangan teori dan praktik di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara pendidikan, layanan, dan sistem kesehatan. Kesenjangan ini tidak hanya merupakan permasalahan teknis, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang, budaya kerja, dan struktur sistem pelayanan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik dan dinamika kesenjangan ini menjadi penting sebagai dasar dalam memperkuat integrasi antara teori, riset, dan praktik dalam keperawatan.

C. Kerangka Konseptual Integrasi Teori dan Praktik

Kerangka konseptual integrasi teori, riset, dan praktik dalam keperawatan merupakan landasan berpikir yang menjelaskan bagaimana ilmu keperawatan dikembangkan, diuji, dan diterapkan dalam pelayanan. Integrasi ini tidak sekadar menunjukkan hubungan linier, tetapi mencerminkan suatu proses dinamis yang menghubungkan tiga komponen utama, yaitu teori sebagai dasar konseptual, riset sebagai sumber bukti ilmiah, dan praktik sebagai konteks implementasi nyata. Secara konseptual, hubungan antara teori, riset, dan praktik dapat dipahami

sebagai suatu alur berkesinambungan (teori → riset → praktik) di mana teori memberikan kerangka untuk memahami fenomena kesehatan, riset menguji dan mengembangkan teori melalui pendekatan ilmiah, dan praktik menjadi ruang penerapan hasil riset (Naz & Ganaie, 2023).

Integrasi ini semakin diperkuat dengan pendekatan *evidence-based nursing* (EBN), yang menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan keperawatan. *Evidence* berperan sebagai elemen kunci yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, dan bukan hanya sebagai hasil penelitian, tetapi juga sebagai dasar rasional dalam menentukan intervensi yang efektif dan aman bagi pasien (Naz & Ganaie, 2023). Hasil riset tidak langsung diterapkan, tetapi melalui pemahaman, interpretasi, dan penyesuaian dengan kondisi klinis. Proses ini melibatkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis perawat dalam menghubungkan teori dengan situasi nyata, yang menjadikan integrasi ini lebih reflektif dan kontekstual.

Integrasi teori, riset, dan praktik harus dipahami sebagai suatu kerangka yang saling melengkapi, dan tidak terpisah. Hasil studi penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara riset, *evidence-based practice*, dan peningkatan mutu pelayanan merupakan kompetensi penting dalam pendidikan dan praktik keperawatan modern (Dunlap et al., 2025). *Evidence* berperan sebagai penghubung utama antara teori dan praktik, memungkinkan teori diuji secara empiris melalui penelitian, dan memberikan dasar ilmiah dalam praktik keperawatan. Tanpa *evidence*, teori berisiko menjadi abstrak dan tidak aplikatif, sedangkan praktik berpotensi menjadi tidak terstandar.

Hubungan antara dunia akademik dan praktik klinik juga memengaruhi efektivitas integrasi teori, riset, dan praktik. Kemitraan antara institusi pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting dalam memperkuat praktik berbasis *evidence* dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya terjadi pada level individu perawat, tetapi juga pada level sistem dan kelembagaan (Halili et al., 2024). Dengan demikian, integrasi teori, riset, dan praktik harus dipahami sebagai suatu siklus yang saling berhubungan, yang menjadi dasar dalam membangun praktik keperawatan yang berbasis riset dan berkualitas.

D. Proses Berpikir dan Pengambilan Keputusan dalam Integrasi Teori dan Praktik

Integrasi teori dan praktik dalam keperawatan sangat bergantung pada proses berpikir yang mendasari pengambilan keputusan klinis, yaitu *clinical reasoning*. Proses ini merupakan kemampuan perawat dalam mengumpulkan,

menganalisis, dan menginterpretasikan data pasien untuk menentukan tindakan yang tepat, sehingga menjadi jembatan utama antara teori, hasil riset, dan praktik dalam situasi nyata. *Clinical reasoning* berbasis teori dan evidence bersifat terstruktur, di mana teori digunakan sebagai kerangka konseptual dan *evidence* sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan (Doyon & Raymond, 2025).

Proses berpikir klinis melibatkan tahapan yang saling terkait, mulai dari pengkajian, identifikasi masalah, penetapan diagnosis keperawatan, pemilihan intervensi, hingga evaluasi hasil. Proses ini tidak bersifat terpisah, tetapi berlangsung secara dinamis dengan memanfaatkan teori untuk memahami pola data dan evidence untuk menentukan intervensi yang efektif. Dengan demikian, keputusan keperawatan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi pada analisis rasional yang didukung oleh ilmu pengetahuan.

Pengambilan keputusan berbasis riset menjadi bagian penting dalam integrasi teori dan praktik, yang menuntut perawat mampu menilai kualitas dan relevansi *evidence* serta menyesuaikannya dengan kondisi pasien. Penguatan kemampuan *clinical reasoning* melalui pendekatan pembelajaran berbasis konsep dan aktif terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas keputusan klinis perawat (Hallemeyer et al., 2024). Namun, kompleksitas situasi klinis menuntut adanya kemampuan reflektif untuk menghubungkan teori dengan pengalaman praktik secara kontekstual.

Refleksi memungkinkan perawat mengevaluasi tindakan, memahami hubungan antara teori dan praktik, serta memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang, baik melalui refleksi individu maupun kolektif. Dengan demikian, *clinical reasoning* dan refleksi menjadi mekanisme utama yang memastikan teori dan hasil riset benar-benar digunakan dalam praktik. Kemampuan berpikir klinis dan reflektif ini pada akhirnya menjadi inti integrasi teori dan praktik sekaligus indikator profesionalisme perawat dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

E. Strategi Integrasi dalam Pembelajaran Keperawatan

Integrasi teori dan praktik dalam pendidikan keperawatan memerlukan strategi pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu mahasiswa menghubungkan pengetahuan dengan tindakan profesional. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori, riset, dan situasi praktik secara bermakna. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan reflektif sangat penting untuk mendukung integrasi ini.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan teori dan praktik adalah penggunaan metode pembelajaran seperti *case-based learning* (CBL), *problem-based learning* (PBL), *Reflective Learning*, dan *Field Trip* mata kuliah. Metode pembelajaran *case-based learning* (CBL), menempatkan kasus nyata sebagai pusat pembelajaran. CBL memungkinkan mahasiswa untuk memahami bagaimana teori diterapkan dalam situasi klinis, mendorong mereka untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mengembangkan solusi berdasarkan teori dan *evidence*. Penelitian menunjukkan bahwa CBL efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam pendidikan keperawatan (Yao et al., 2023).

Metode pembelajaran *problem-based learning* (PBL) juga menjadi strategi penting dalam integrasi teori dan praktik. PBL fokus pada pemecahan masalah yang kompleks. Mahasiswa secara aktif mengidentifikasi kebutuhan belajar, mencari informasi berbasis *evidence*, dan mengaplikasikannya. Pendekatan ini mendorong kolaborasi, kemampuan berpikir analitis, serta meningkatkan pengambilan keputusan klinis dan penalaran mahasiswa (Komuhangi et al., 2025).

Metode pembelajaran *Reflective Learning* juga berperan penting dalam memperkuat integrasi dengan memungkinkan mahasiswa mengevaluasi pengalaman mereka, menghubungkan teori dengan tindakan, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (Zia et al., 2023).

Metode pembelajaran *field trip* menjadi metode yang efektif dalam memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan keperawatan jiwa yang telah dipelajari di kelas. Kegiatan *Field Trip* ini melibatkan mahasiswa dalam observasi langsung dan penerapan intervensi di layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu jiwa, rumah perawatan disabilitas gangguan jiwa, dan sekolah (Mawaddah & Prastya, 2023; Mawaddah & Prastya, 2023; Mawaddah et al., 2025; Maharani et al., 2025). Melalui *Field Trip* mahasiswa dapat berperan aktif sebagai kader kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan jiwa. Selain itu, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas.

Strategi integrasi melalui penggunaan metode pembelajaran CBL, PBL, *Field Trip*, dan *Reflective Learning*, memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam mendukung integrasi teori dan praktik. Kombinasi semua metode memungkinkan mahasiswa untuk menginternalisasi teori secara lebih mendalam dan aplikatif. Integrasi dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa untuk menerapkan teori dan hasil riset pada kasus nyata di lapangan, yang kemudian dianalisis, direfleksikan, dan diperkuat melalui praktik berbasis SKS, memberikan kesempatan untuk

menguji pemahaman teoretis, mengembangkan kemampuan berpikir klinis dan reflektif, serta menerima umpan balik yang memperkuat keterampilan mereka.

F. Peran Pendidik dan Praktisi dalam Integrasi Teori dan Praktik

Integrasi teori dan praktik dalam keperawatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teori dan *evidence*, tetapi juga oleh peran aktif para pihak yang terlibat dalam proses pendidikan dan praktik keperawatan. Pendidik dan praktisi memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam menjembatani kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan penerapannya di lapangan. Sinergi antara keduanya menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa teori dan hasil riset dapat diinternalisasi dan digunakan secara efektif dalam praktik keperawatan.

Dosen sebagai pendidik memiliki peran strategis dalam membangun landasan konseptual mahasiswa. Dosen tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mengarahkan mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara teori, riset, dan praktik. Melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis kasus, masalah, dan refleksi, dosen membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan klinis. Selain itu, dosen juga berperan dalam menanamkan pentingnya penggunaan *evidence* dalam pengambilan keputusan keperawatan, sehingga mahasiswa terbiasa mengaitkan pengetahuan teoretis dengan situasi nyata.

Peneliti memiliki peran penting dalam menghasilkan *evidence* yang menjadi dasar integrasi teori dan praktik. Hasil penelitian yang relevan dan berkualitas memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu keperawatan serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan klinis. Peneliti tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam menyajikan hasil riset dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh praktisi. Oleh karena itu, peran peneliti tidak terpisah dari praktik, melainkan menjadi bagian dari proses pengembangan asuhan keperawatan berbasis riset.

Clinical instructor (CI) berperan sebagai penghubung antara dunia akademik dan praktik klinik. CI membimbing mahasiswa dalam menerapkan teori dan *evidence* dalam situasi nyata, serta membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan *clinical reasoning*. Pada proses pembelajaran klinik, CI memberikan umpan balik langsung terhadap tindakan mahasiswa, sehingga terjadi proses pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Peran CI sangat penting dalam memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara tepat dalam praktik.

Perawat klinik sebagai praktisi memiliki peran utama dalam mengimplementasikan teori dan *evidence* dalam pelayanan sehari-hari. Perawat klinik tidak hanya melaksanakan tindakan keperawatan, tetapi juga menjadi role

model bagi mahasiswa dalam menerapkan praktik berbasis bukti. Melalui pengalaman praktik, perawat klinik memberikan contoh nyata bagaimana teori dan hasil riset digunakan dalam pengambilan keputusan klinis. Selain itu, interaksi antara perawat klinik dan mahasiswa menjadi sarana penting dalam mentransfer pengalaman praktis yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas.

Hubungan antara pendidik dan praktisi dalam integrasi teori dan praktik bersifat kolaboratif. Kolaborasi akademik–klinik memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua pihak. Pendidik memperoleh pemahaman tentang kondisi praktik terkini, sementara praktisi mendapatkan akses terhadap perkembangan ilmu dan hasil penelitian terbaru. Hubungan ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk integrasi teori dan praktik, serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan praktik keperawatan.

Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara institusi pendidikan dan praktik klinik berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan *evidence* dalam praktik serta mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik. Kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga pada peningkatan kompetensi perawat dalam menerapkan praktik berbasis bukti, sehingga integrasi teori dan praktik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peran dosen, peneliti, clinical instructor, dan perawat klinik merupakan elemen penting dalam integrasi teori dan praktik dalam keperawatan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun keterkaitan antara pengetahuan ilmiah dan praktik nyata. Kolaborasi yang baik antara pendidik dan praktisi menjadi dasar dalam menciptakan proses pembelajaran dan praktik keperawatan yang berbasis riset, sehingga mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara menyeluruh.

G. Hambatan Integrasi dan Upaya Penguatan

Integrasi teori dan praktik dalam keperawatan merupakan proses yang kompleks dan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek kognitif (pemahaman terhadap teori), struktural (sistem layanan), maupun budaya praktik. Pemahaman terhadap berbagai hambatan ini menjadi penting sebagai dasar dalam memperkuat integrasi teori dan praktik, khususnya dalam konteks pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset.

Hambatan kognitif berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami dan mengimplementasikan teori keperawatan serta hasil penelitian. Dalam praktiknya, tidak semua perawat atau mahasiswa memiliki kemampuan yang

memadai dalam mengaitkan konsep teoretis dengan situasi klinis. Teori sering kali dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit diaplikasikan, sehingga kurang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan dalam memahami metode penelitian dan interpretasi hasil riset juga menjadi faktor yang menghambat penggunaan *evidence* dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi *evidence-based practice* berkontribusi terhadap kesenjangan antara teori dan praktik dalam keperawatan (Lehane et al., 2023).

Selain aspek kognitif, hambatan struktural juga berperan signifikan dalam integrasi teori dan praktik. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja dan sistem pelayanan yang memengaruhi praktik keperawatan. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, serta kurangnya akses terhadap sumber informasi ilmiah menjadi faktor yang membatasi penggunaan teori dan hasil riset dalam praktik. Di sisi lain, lingkungan praktik yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran berbasis *evidence* juga dapat menghambat proses integrasi. Studi menunjukkan bahwa kondisi organisasi dan ketersediaan sumber daya merupakan determinan penting dalam penerapan praktik berbasis bukti (Dunlap et al., 2025).

Hambatan budaya praktik juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Budaya kerja yang lebih mengutamakan kebiasaan dibandingkan penggunaan *evidence* dapat menghambat integrasi teori dan praktik. Dalam beberapa setting, praktik keperawatan masih didasarkan pada pengalaman atau tradisi yang telah berlangsung lama, sehingga perubahan menuju praktik berbasis riset tidak mudah dilakukan. Selain itu, kurangnya budaya refleksi dan diskusi ilmiah dalam praktik sehari-hari juga membatasi kesempatan perawat untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teori dan *evidence*.

Meskipun berbagai hambatan tersebut masih ditemukan, upaya penguatan integrasi teori dan praktik dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis pendidikan dan riset. Penguatan integrasi teori dan praktik berbasis Pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, *clinical reasoning*, serta literasi *evidence-based practice*. Strategi pembelajaran yang aktif dan kontekstual, seperti *case-based learning*, *problem-based learning*, *Field Trip* dan *reflective learning*, dapat membantu mahasiswa dalam mengimplementasikan teori dan mengaitkannya dengan praktik. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakannya dalam situasi nyata.

Penguatan integrasi teori dan praktik berbasis riset dilakukan dengan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran dan praktik. Hasil riset perlu disajikan dalam bentuk yang lebih aplikatif dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

keperawatan. Penguatan ini tidak hanya dilakukan dalam ruang kelas, tetapi juga dalam kegiatan praktik berbasis Satuan Kredit Semester (SKS), yang memberi mahasiswa kesempatan untuk menerapkan teori dan riset dalam situasi nyata, sambil mendapatkan umpan balik yang memperkuat keterampilan mereka. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dan perawat dalam kegiatan penelitian juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya *evidence* dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan, riset, dan praktik dapat meningkatkan kompetensi perawat dalam menerapkan *evidence-based practice* (Xia et al., 2023). Upaya penguatan integrasi juga dapat dilakukan melalui pengembangan budaya reflektif dalam praktik keperawatan. Refleksi memungkinkan perawat untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, memahami kesenjangan antara teori dan praktik, serta memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Dengan adanya budaya refleksi, proses integrasi menjadi lebih dinamis dan berkelanjutan.

Melalui integrasi yang kuat antara pendidikan dan riset, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, dan refleksi yang mendalam, sehingga dapat menghubungkan teori dan praktik secara efektif. Strategi ini juga memperkuat kemampuan perawat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah klinis dengan menggunakan bukti ilmiah yang relevan. Dalam konteks pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset di Indonesia, penguatan integrasi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

H. Penerapan Integrasi Teori dan Praktik

Penerapan integrasi teori dan praktik dalam keperawatan adalah suatu proses yang penting dalam memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dapat diterapkan secara langsung dalam praktik klinis. Teori memberikan dasar konseptual yang membantu perawat memahami fenomena kesehatan, sementara praktik memungkinkan mereka untuk menguji dan mengaplikasikan teori tersebut dalam situasi nyata. Proses ini bukan hanya sekadar memindahkan teori ke lapangan, tetapi melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori dan hasil riset bisa diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif dalam merawat pasien.

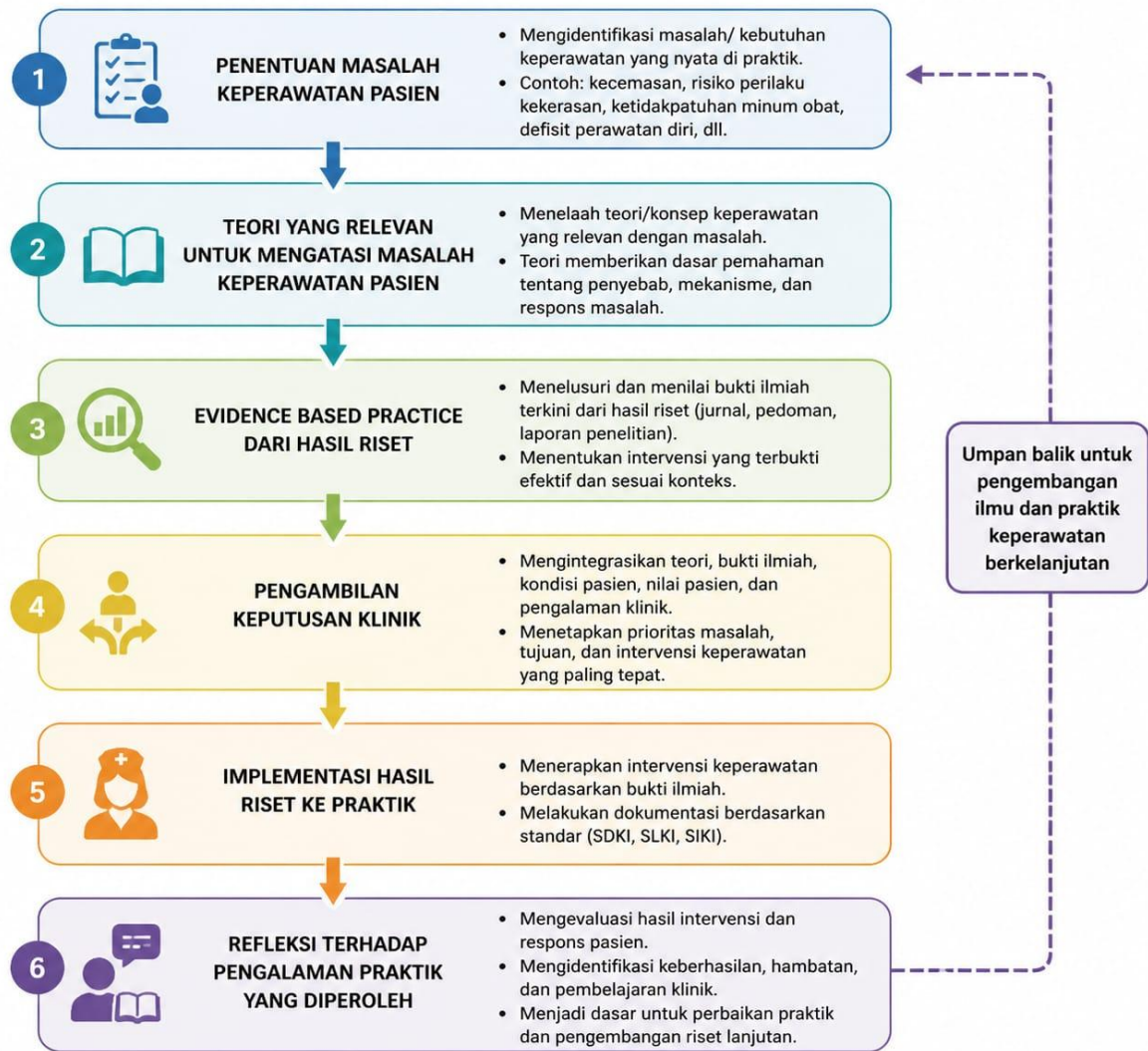
Proses penerapan integrasi teori dan praktik diawali dengan memahami teori yang relevan dengan kondisi klinis yang dihadapi. Teori digunakan untuk memahami suatu fenomena kesehatan, misalnya dalam perawatan pasien hemodialisis yang mengalami depresi, maka teori tentang manajemen depresi menjadi dasar dalam merancang intervensi yang tepat (Mawaddah et al., 2023).

Contoh lain pada kasus ketidakpatuhan remaja putri untuk konsumsi tablet tambah darah (TTD), memerlukan intervensi edukasi kesehatan yang sesuai dengan teori pada standar intervensi keperawatan Indonesia dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (SIKI PPNI) (Mawaddah et al., 2024). Namun, pemahaman teori saja tidak cukup; perawat juga perlu menggunakan bukti ilmiah yang didapat dari penelitian untuk memperkuat tindakan yang diambil. Dengan demikian, teori dan riset saling melengkapi dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih baik.

Tahap selanjutnya adalah *evidence-based practice* dari hasil riset, dimana perawat menelusuri dan menilai bukti ilmiah terkini yang dapat mendukung keputusan keperawatan. Bukti dari riset ini membantu perawat untuk menentukan intervensi yang terbukti efektif dan sesuai dengan konteks pasien. Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan klinik, di mana perawat mengintegrasikan teori, bukti ilmiah, kondisi pasien, serta pengalaman klinis untuk menentukan prioritas masalah, tujuan, dan intervensi yang paling tepat. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut diimplementasikan dalam praktik, yaitu perawat menerapkan intervensi berdasarkan bukti ilmiah yang telah ditemukan. Selain itu, perawat juga melakukan dokumentasi sesuai dengan standar yang ada, seperti SDKI, SLIKI, dan SIKI.

Dalam praktik berbasis riset tersebut, proses integrasi tidak berhenti pada penerapan intervensi, tetapi juga melibatkan refleksi terhadap pengalaman praktik yang diperoleh. Ditahapan ini, perawat mengevaluasi hasil intervensi, mengidentifikasi hambatan, dan mengkaji ulang tindakan yang dilakukan untuk pengembangan praktik dan riset ke depan. Refleksi ini penting untuk memahami kesesuaian antara teori, hasil penelitian, dan kondisi nyata di lapangan. Melalui refleksi, integrasi menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak statis.

Proses penerapan integrasi teori dan praktik ini membentuk siklus berkelanjutan yang memungkinkan perawat untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, memperbaiki praktik yang ada, dan mengembangkan riset lebih lanjut, sehingga teori dan praktik tetap saling terhubung dan mendukung pengembangan keperawatan yang lebih baik. Alur proses integrasi teori dan praktik keperawatan dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1: Proses Integrasi Teori dan Praktik Keperawatan

Penerapan integrasi teori dan praktik juga menunjukkan bahwa praktik dapat menjadi sumber pengembangan ilmu. Pengalaman di lapangan dapat memunculkan pertanyaan baru yang mendorong dilakukannya penelitian lanjutan. Dengan demikian, terjadi siklus yang berkesinambungan antara teori, riset, dan praktik, di mana masing-masing komponen saling memperkaya. Studi menunjukkan bahwa integrasi yang efektif antara pendidikan, riset, dan praktik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penggunaan *evidence* dalam praktik keperawatan (Dunlap et al., 2025).

Selain itu, pendekatan *evidence-based nursing* menegaskan pentingnya penggunaan hasil penelitian dalam praktik sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan klinis. *Evidence* berperan sebagai penghubung antara teori dan praktik, sehingga intervensi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam

pembelajaran berbasis riset dapat meningkatkan pemahaman terhadap integrasi teori dan praktik serta memperkuat kompetensi klinis (Xia et al., 2023).

Alur proses penerapan integrasi teori dan praktik ini menegaskan bahwa integrasi teori dan praktik bukan sekadar tahapan prosedural, tetapi merupakan proses berpikir yang melibatkan pemahaman, penerapan, dan refleksi. Fokus utama dari integrasi ini adalah bagaimana teori dan hasil riset dipahami dan dihubungkan dengan praktik secara kontekstual, bukan pada bentuk model atau intervensi yang dihasilkan. Dengan demikian, integrasi menjadi fondasi dalam pengembangan asuhan keperawatan berbasis riset. Pada konteks pendidikan keperawatan di Indonesia, proses integrasi melalui praktik berbasis SKS memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mahasiswa dapat menginternalisasi teori dan *evidence* dalam praktik. Proses ini tidak hanya meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga membentuk cara berpikir ilmiah yang menjadi dasar dalam praktik keperawatan profesional. Oleh karena itu, integrasi teori dan praktik perlu terus diperkuat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan keperawatan berbasis riset

Penerapan integrasi teori dan praktik menjadi fondasi penting dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana teori dan riset dapat dipahami, diterjemahkan, dan diterapkan sesuai dengan kondisi praktik di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset melalui integrasi teori dan praktik bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa perawat di Indonesia dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasien

I. Penutup

Integrasi teori dan praktik dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset di Indonesia memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga diterapkan dalam praktik nyata. Teori memberikan kerangka berpikir, riset menyajikan bukti ilmiah, dan praktik menjadi ruang untuk menguji serta menyempurnakan keduanya. Proses ini bersifat dinamis dan reflektif, di mana pengalaman praktik memberi umpan balik bagi pengembangan teori dan riset selanjutnya. Dengan demikian, penguatan integrasi ini penting untuk membangun model asuhan yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pasien serta kondisi pelayanan di Indonesia.

Referensi

- Afaneh, T., Villamor, M. Y., Opinion, F., Hassan, N., & Mihdawi, M. (2023). Exploring the gap between school of nursing theoretical foundations and clinical practice. *Journal of Professional Nursing*, 49, 158–164. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.10.002>
- Doyon, O., & Raymond, L. (2025). Clinical reasoning and clinical judgment in nursing research: A bibliometric analysis. *International Journal of Nursing Knowledge*, 36(3). <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12484>
- Dunlap, J. J., Waldrop, J. B., Brewer, T. L., & Mainous, R. O. (2025). Differentiation and integration of research, evidence-based practice, and quality improvement. *Journal of Nursing Education*, 64(6), e44–e47. <https://doi.org/10.3928/01484834-20240514-01>
- Hallemeyer, D., Tyo, M., Travers, E. A. (2024). Implementation of clinical reasoning concepts to improve clinical judgment and self-confidence of nursing students in the clinical setting. *Teaching and Learning in Nursing*. 19. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2023.12.013>
- Komuhangi, G., Neuhaan, F., Louis, V., Ocan, M., Kinengyere, A. A., Wacker, J. (2025). Efficacy of Problem Based Learning approach for teaching Evidence Based Practice in midwifery and nursing education: a systematic review. *BMC Nurs*, 24(1412). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-04101-w>
- Hasnawati, E., Putra, E., & Kasmini, L. (2023). Persepsi mahasiswa pendidikan profesi ners terhadap clinical instructor (CI) dengan pencapaian kompetensi praktik klinik di RSUD dr. Zainoel Abidin. *Getsempena Health Science Journal*, 2(2), 93–107. <https://doi.org/10.37612/ghsj.v2i2.1234>
- Halili, X., Xia, Y., Li, Z., Tang, S., Wang, H., & Chen, Q. (2024). Academic-practice partnerships in evidence-based nursing practice: A theory-guided scoping review. *International nursing review*, 71(4), 729–746. <https://doi.org/10.1111/inr.12965>
- Mawaddah, M., Mujiadi, M., Utomo, R. W. (2023). Management Of Depression In Hemodialysis Patients: A Pilot Study. *Psychiatry Nursing Journal (Jurnal Keperawatan Jiwa)*, 5(2), 37–45, <https://doi.org/10.20473/pnj.v5i2.48054>
- Mawaddah, N., Nurwidji, N., Abidah, R. S., Puspitasari, N. (2024). Edukasi kesehatan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja. *Journal of Health Research Science*, 4(2), 266–275, <https://doi.org/10.34305/jhrs.v4i2.1375>
- Mawaddah, N., Prastya, A. (2023). Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Sebagai Kader Posyandu Jiwa Melalui Program *Field Trip*. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), Hal 314–319, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.12233>
- Mawaddah, N., Prastya, A. (2023). Upaya Peningkatan Kesehatan Mental Remaja

- Melalui Stimulasi Perkembangan Psikososial Pada Remaja. *DEDIKASI SAINTEX (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 2(2), Hal 115-125, 3. <https://doi.org/10.58545/djpm.v2i2.180>
- Mawaddah, N., Rachmah, S., Amilia, A. F., Zulfani, A., Besan, T. Z. (2025). Pemberdayaan Penderita Gangguan Jiwa Melalui Pelatihan Keterampilan Kerja Di Posyandu Jiwa Sebagai Upaya Pemulihan Kesehatan Jiwa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Keperawatan Optimal*, 2(2), Hal 46-55, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19904474>
- Maharani, I., Aprilliani, P. A. W., Rohma, N. N., Mawaddah, N., Irawati, D. (2025). Implementasi Upaya Promotif Pada Remaja Melalui Program Literasi Kesehatan Untuk Meningkatkan Peran UKS Di Sekolah. *Jurnal Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)*, 5(1), Hal 79-88, <https://doi.org/10.34305/3q366r87>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer. <https://doi.org/10.1097/9781975185724>
- Naz, H., & Ganaie, N. A. (2023). Evidence-based practice in nursing: A comprehensive review. *Clinical Medicine and Health Research Journal*, 3(6), 713–715. <https://doi.org/10.18535/cmhrj.v3i6.254>
- Ugwu, S. N., Ogbonnaya, N. P., Chijioke, V. C., & Esievo, J. N. (2023). Causes and effects of theory-practice gap during clinical practice: The lived experiences of baccalaureate nursing students. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2164949>
- Unis, B. D., Kydland, A. G. R., Svård, J., Thorø, B., Nais, S., Marianthi, D., & Grøndahl, V. A. (2025). Nursing curricula in Indonesia and Scandinavia: What can we learn from each other to strengthen nursing education. *Nurse Education Today*, 149, 106657. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106657>
- Xia, Y., Huang, H., Yu, Q., Halili, X., & Chen, Q. (2023). Academic-practice partnerships in evidence-based nursing education: A theory-guided scoping review. *Nurse Education in Practice*, 73, 103839. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103839>
- Yao, J., Fu, R., Zhu, M., Jia, L., Dong, X., Shi, Y., Zhang, X., & Yuan, H. (2023). Case-based learning interventions for undergraduate nursing students in a theoretical course: A review of design, implementation, and outcomes. *Journal of Professional Nursing*, 46, 119–133. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.03.007>
- Yao, J., Yuan, H., Zhu, M., Wang, J., Wang, Q., Chen, Z., Chen, Y., & Zhang, X. (2023). Nursing student learning of evidence-based nursing through case-based learning and flipped learning: A mixed study. *Nursing Open*, 10(9), 6551–6558. <https://doi.org/10.1002/nop2.1910>
- Zia, T., Sabeghi, H., & Mahmoudirad, G. (2023). Problem-based learning versus reflective practice on nursing students' moral sensitivity. *BMC Nursing*, 22, 215. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01377-8>

BAB 3

MODEL ASUHAN KEPERAWATAN KLINIK

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan klinik merupakan elemen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkontribusi langsung terhadap kualitas layanan, keselamatan pasien, serta luaran klinis. Transformasi pelayanan kesehatan global menuntut praktik keperawatan yang tidak hanya berbasis rutinitas, tetapi berlandaskan *evidence-based practice* (EBP), keselamatan pasien, dan pendekatan berpusat pada pasien (*patient-centered care*).

Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) adalah integrasi antara bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, dan nilai serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinik (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Implementasi EBP terbukti meningkatkan kualitas asuhan, menurunkan komplikasi, dan meningkatkan kepuasan pasien (Dang et al., 2022; Melnyk et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, pengembangan model asuhan keperawatan klinik berbasis riset menjadi krusial untuk memenuhi tuntutan mutu layanan, akreditasi (SNARS), serta penguatan profesionalisme perawat sesuai UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

B. Konsep Model Asuhan Keperawatan Klinik

Definisi

Model asuhan keperawatan klinik adalah kerangka konseptual-operasional yang mengarahkan bagaimana asuhan diberikan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada pasien. Model ini mencakup struktur organisasi, proses keperawatan, sistem dokumentasi, serta hubungan profesional. Menurut Alligood (2022), model keperawatan berfungsi sebagai panduan praktik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinik dan konsistensi intervensi.

Adapun tujuan model sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas pelayanan** melalui standardisasi praktik berbasis bukti.
2. **Menjamin keselamatan pasien** dengan meminimalkan risiko dan *adverse events*.

3. **Meningkatkan kepuasan pasien** melalui pelayanan holistik dan berpusat pada pasien.
4. **Meningkatkan profesionalisme perawat** melalui *clinical reasoning* dan *critical thinking*.
5. **Menjamin kontinuitas asuhan** lintas shift dan lintas unit.

Model asuhan keperawatan klinik terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu *input*, *proses*, *output*, dan *kontrol*. Keempat komponen ini membentuk suatu sistem yang terintegrasi dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan. Keseimbangan dan keterpaduan antar komponen menjadi kunci keberhasilan implementasi model dalam praktik klinik (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2021; Yoder-Wise, 2023).

1. Komponen Input

Komponen input merupakan sumber daya awal yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Input meliputi sumber daya manusia (SDM), kompetensi perawat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. SDM tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga kualitas, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman klinis, pelatihan, dan sertifikasi profesional. Rasio perawat terhadap pasien menjadi indikator penting karena berkaitan dengan beban kerja dan keselamatan pasien (Aiken et al., 2021). Selain itu, ketersediaan fasilitas seperti alat kesehatan, teknologi informasi (misalnya *electronic health record*), serta lingkungan kerja yang kondusif turut memengaruhi efektivitas pelayanan keperawatan (Kelly et al., 2021).

2. Komponen Proses

Komponen proses menggambarkan rangkaian aktivitas asuhan keperawatan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Proses ini merupakan inti dari praktik keperawatan klinik dan harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta berbasis *evidence-based practice*. Kepatuhan terhadap SOP menjadi indikator utama dalam menilai kualitas proses karena memastikan bahwa tindakan keperawatan aman, efektif, dan sesuai standar profesi (Melnik & Fineout-Overholt, 2023). Proses yang terstruktur dan berbasis bukti terbukti dapat meningkatkan kualitas asuhan serta menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan (Dang et al., 2022).

3. Komponen Output

Komponen output merujuk pada hasil langsung dari proses asuhan keperawatan yang diberikan. Output biasanya diukur melalui indikator klinis seperti *length of stay* (LOS), angka komplikasi, tingkat kesembuhan, serta

kepuasan pasien. Outcome pasien menjadi refleksi dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas asuhan keperawatan yang baik berkorelasi dengan penurunan mortalitas, lama rawat inap, serta peningkatan kepuasan pasien (Aiken et al., 2021). Oleh karena itu, pengukuran output menjadi penting sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan keperawatan.

4. Komponen Kontrol

Komponen kontrol berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses asuhan keperawatan. Kontrol dilakukan melalui kegiatan audit keperawatan, supervisi klinik, serta evaluasi kinerja perawat. Salah satu indikator penting dalam komponen ini adalah kepatuhan dokumentasi, yang mencerminkan akuntabilitas dan profesionalisme perawat (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2021). Selain itu, pendekatan *continuous quality improvement* (CQI) digunakan untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan keperawatan (Kelly et al., 2021). Sistem kontrol yang efektif memungkinkan identifikasi kesenjangan antara standar dan praktik serta mendukung peningkatan mutu layanan secara sistematis.

Secara keseluruhan, keberhasilan model asuhan keperawatan klinik sangat ditentukan oleh keselarasan antara komponen input, proses, output, dan kontrol. Ketidakseimbangan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan sistem yang terintegrasi dan berbasis bukti sangat diperlukan dalam pengembangan model asuhan keperawatan klinik modern.

Tabel 3.1: Komponen Model

Komponen	Uraian	Indikator
Input	SDM, kompetensi, sarana	Rasio perawat, sertifikasi
Proses	Pengkajian–evaluasi	Kepatuhan SOP
Output	Outcome pasien	LOS, komplikasi
Kontrol	Audit, supervisi	Kepatuhan dokumentasi

Fawcett & DeSanto-Madeya (2021) menekankan bahwa keselarasan keempat komponen menentukan keberhasilan model.

C. Jenis Model Asuhan keperawatan Klinik

Dalam praktik keperawatan klinik, terdapat berbagai model asuhan yang digunakan untuk mengorganisasi pemberian pelayanan kepada pasien. Pemilihan model asuhan keperawatan sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi, jumlah dan kompetensi tenaga perawat, serta kompleksitas kebutuhan pasien. Setiap

model memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan secara kritis (Yoder-Wise, 2023; Marquis & Huston, 2021).

1. Model Fungsional

Model fungsional merupakan pendekatan yang berorientasi pada pembagian tugas berdasarkan fungsi tertentu. Dalam model ini, setiap perawat bertanggung jawab terhadap satu jenis tindakan keperawatan, seperti pemberian obat, perawatan luka, atau pengukuran tanda vital.

Kelebihan utama model ini adalah efisiensi dalam penggunaan tenaga, terutama pada kondisi keterbatasan sumber daya manusia. Namun, kelemahan utamanya adalah terjadinya fragmentasi pelayanan, dimana pasien tidak mendapatkan asuhan secara holistik karena ditangani oleh banyak perawat dengan tugas yang berbeda-beda (Yoder-Wise, 2023). Model ini juga berpotensi menurunkan kontinuitas asuhan dan kepuasan pasien.

2. Model Tim

Model tim merupakan pendekatan kolaboratif dimana sekelompok perawat bekerja sama dalam memberikan asuhan kepada sekelompok pasien. Tim biasanya dipimpin oleh seorang perawat profesional yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan supervisi.

Keunggulan model ini terletak pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan ketua tim. Jika koordinasi tidak berjalan optimal, maka kualitas asuhan dapat menurun (Kalisch et al., 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa teamwork yang baik dapat menurunkan missed nursing care.

3. Model Primary Nursing

Model primary nursing menempatkan satu perawat sebagai penanggung jawab utama terhadap asuhan pasien selama periode perawatan. Perawat primer bertanggung jawab secara penuh mulai dari perencanaan hingga evaluasi asuhan keperawatan.

Model ini memiliki kelebihan dalam hal kontinuitas asuhan dan hubungan terapeutik yang lebih kuat antara perawat dan pasien. Selain itu, akuntabilitas perawat menjadi lebih jelas. Namun, model ini membutuhkan jumlah perawat yang cukup dengan tingkat kompetensi tinggi, sehingga kurang efektif jika terjadi keterbatasan SDM (Marquis & Huston, 2021).

4. Model Case Method

Model case method merupakan pendekatan dimana satu perawat bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan pasien dalam satu periode shift. Model ini menekankan pelayanan yang bersifat holistik dan individual.

Kelebihan model ini adalah pemberian asuhan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Namun, kelemahannya adalah beban kerja yang tinggi bagi perawat, terutama jika jumlah pasien banyak atau tingkat keparahan pasien tinggi. Hal ini dapat berdampak pada kelelahan kerja (burnout) dan penurunan kualitas pelayanan (Kelly et al., 2021).

5. Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)

Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) merupakan model yang mengintegrasikan nilai-nilai profesional, struktur organisasi, serta proses keperawatan secara komprehensif. Model ini dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui pendekatan sistem yang terstruktur dan berbasis standar profesi.

Kelebihan model MAKP adalah kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, meningkatkan profesionalisme perawat, serta mendukung dokumentasi yang sistematis. Namun, implementasi model ini relatif kompleks karena membutuhkan kesiapan organisasi, pelatihan SDM, serta dukungan manajemen yang kuat (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2021). Studi di Indonesia juga menunjukkan bahwa MAKP dapat meningkatkan kualitas dokumentasi dan kepuasan pasien (Pramidyasstuti et al., 2024).

Sintesis Perbandingan Model

Secara umum, tidak ada satu model yang paling ideal untuk segala situasi. Model fungsional lebih cocok untuk kondisi keterbatasan tenaga, sedangkan model primary nursing dan case method lebih sesuai untuk pelayanan yang menekankan kontinuitas dan pendekatan holistik. Model tim menjadi pilihan moderat dengan pendekatan kolaboratif, sementara MAKP merupakan model komprehensif yang mengintegrasikan berbagai aspek profesional keperawatan. Oleh karena itu, pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien, sumber daya, serta kebijakan organisasi (Yoder-Wise, 2023).

Tabel 3.2: Perbandingan Model

Model	Fokus	Kelebihan	Kelemahan
Fungsional	Tugas	Efisien	Fragmentasi

Tim	Kolaborasi	Komunikasi baik	Leadership dependent
Primary	Pasien	Kontinuitas tinggi	Membutuhkan SDM tinggi
Case	Individu	Holistik	Beban kerja tinggi
MAKP	Profesional	Komprehensif	Implementasi kompleks

D. Model Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

1. Konsep Evidence-Based Practice (EBP)

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik (best available evidence), keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinik. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta efisiensi pelayanan kesehatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

Dalam praktiknya, EBP tidak hanya berfokus pada hasil penelitian semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks klinik dan kondisi individu pasien. Dengan demikian, keputusan klinik yang diambil menjadi lebih komprehensif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Implementasi EBP terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan hingga 30%, serta menurunkan variasi praktik yang tidak berbasis bukti (Melnyk et al., 2022).

2. Tahapan Evidence-Based Practice (EBP)

Implementasi EBP dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan terpercaya. Tahapan tersebut meliputi:

a. Identifikasi masalah klinik

Tahap awal EBP adalah mengidentifikasi permasalahan klinik yang muncul dalam praktik keperawatan. Masalah ini dapat berasal dari variasi praktik, kejadian tidak diharapkan, atau kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

b. Formulasi pertanyaan klinik (PICO)

Permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan klinik menggunakan pendekatan PICO (Population, Intervention,

Comparison, Outcome). Pendekatan ini membantu memperjelas fokus pencarian bukti ilmiah.

c. Pencarian literatur

Perawat melakukan pencarian bukti ilmiah melalui database terpercaya seperti PubMed, CINAHL, atau Cochrane Library. Bukti yang dicari harus relevan, mutakhir, dan memiliki tingkat evidensi yang tinggi.

d. *Critical appraisal*

Tahap ini bertujuan untuk menilai kualitas dan validitas penelitian yang ditemukan. Perawat harus mampu mengevaluasi metodologi, hasil, serta tingkat kepercayaan terhadap bukti tersebut (Dang et al., 2022).

e. Implementasi

Bukti yang telah dinilai kemudian diimplementasikan dalam praktik klinik dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan sumber daya yang tersedia.

f. Evaluasi

Tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil implementasi untuk mengetahui efektivitas intervensi yang dilakukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan действительно memberikan manfaat bagi pasien.

Pendekatan sistematis ini memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah.

3. Model Implementasi EBP

Untuk memfasilitasi penerapan EBP dalam praktik klinik, beberapa model implementasi telah dikembangkan. Model-model ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan.

a. Iowa Model of Evidence-Based Practice

Iowa Model merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam praktik keperawatan. Model ini menekankan pada identifikasi masalah berbasis prioritas organisasi serta penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan. Iowa Model juga melibatkan tim interdisipliner dalam proses implementasi sehingga meningkatkan keberhasilan penerapan EBP.

b. Stetler Model

Stetler Model berfokus pada penggunaan hasil penelitian oleh individu praktisi. Model ini menekankan pada proses refleksi kritis dan pengambilan keputusan secara mandiri oleh perawat dalam mengaplikasikan bukti ilmiah ke dalam praktik klinik.

c. Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model (JHNEBP)

Model Johns Hopkins merupakan model yang sistematis dan mudah diaplikasikan dalam praktik klinik. Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Practice Question, Evidence, dan Translation (PET). Model ini membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah, mengkaji bukti, serta menerapkan hasil penelitian ke dalam praktik secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa model ini efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Dang et al., 2022).

Sintesis Model EBP dalam Keperawatan Klinik

Secara keseluruhan, penerapan EBP dalam model asuhan keperawatan klinik memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam pengambilan keputusan. Integrasi antara tahapan EBP dan model implementasi memungkinkan perawat untuk mengurangi variasi praktik, meningkatkan kualitas asuhan, serta memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar efektif dan aman bagi pasien. Oleh karena itu, EBP menjadi komponen penting dalam pengembangan model asuhan keperawatan klinik modern.

E. Dokumentasi Keperawatan (SDKI-SIKI-SLKI)

1. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)

SDKI merupakan komponen yang berfungsi sebagai dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual maupun potensial. Berbeda dengan diagnosis medis, diagnosis keperawatan berfokus pada respons manusia secara holistik, mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Penggunaan SDKI membantu perawat dalam merumuskan masalah pasien secara sistematis dan terstandar, sehingga meminimalkan variasi interpretasi antar tenaga kesehatan. Sebagai contoh, pada pasien dengan keterbatasan gerak, diagnosis yang dapat ditegakkan adalah *gangguan mobilitas fisik*. Standarisasi ini penting untuk meningkatkan akurasi klinis dan komunikasi antar perawat (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian esensial dalam praktik keperawatan klinik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi profesional, bukti legal, serta indikator mutu pelayanan kesehatan. Dokumentasi yang baik harus bersifat akurat, lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks praktik keperawatan di Indonesia, standar dokumentasi telah dikembangkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melalui tiga

komponen utama, yaitu **Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)**, **Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)**, dan **Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)**.

Penerapan SDKI–SIKI–SLKI memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam proses asuhan keperawatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Sistem ini juga mendukung implementasi praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) serta meningkatkan konsistensi dan kualitas dokumentasi. Studi menunjukkan bahwa penggunaan standar ini dapat meningkatkan akurasi diagnosis, kesesuaian intervensi, serta kejelasan luaran keperawatan (Rumbewas et al., 2025).

2. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)

SLKI merupakan komponen yang berfungsi untuk menentukan luaran atau hasil yang diharapkan dari intervensi keperawatan. Luaran ini digunakan sebagai indikator keberhasilan asuhan keperawatan dan dasar evaluasi.

SLKI memungkinkan perawat untuk mengukur perubahan kondisi pasien secara objektif dan terstandar. Sebagai contoh, luaran dari intervensi latihan ROM adalah peningkatan kekuatan otot atau kemampuan mobilitas pasien. Dengan adanya SLKI, evaluasi menjadi lebih terukur dan dapat digunakan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

3. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)

SIKI merupakan panduan dalam menentukan intervensi keperawatan yang sesuai dengan diagnosis yang telah ditetapkan. Intervensi keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah pasien atau meningkatkan status kesehatan.

SIKI disusun berdasarkan prinsip ilmiah dan praktik terbaik (*best practice*), sehingga membantu perawat dalam memilih tindakan yang efektif dan aman. Sebagai contoh, pada diagnosis *gangguan mobilitas fisik*, intervensi yang direkomendasikan adalah latihan *range of motion* (ROM) untuk meningkatkan kekuatan otot dan mencegah komplikasi. Dengan adanya SIKI, tindakan keperawatan menjadi lebih terarah, konsisten, dan sesuai standar profesi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

Integrasi SDKI-SLKI-SIKI dalam Dokumentasi Keperawatan

Ketiga komponen ini saling terintegrasi dalam satu siklus proses keperawatan, yaitu:

- **SDKI** sebagai dasar penetapan diagnosis
- **SLKI** sebagai indikator luaran
- **SIKI** sebagai panduan intervensi

Integrasi ini menghasilkan dokumentasi yang sistematis, logis, dan berkesinambungan, sehingga meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien. Selain itu, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas profesional perawat serta mempermudah proses audit dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan.

Table 3.3: Contoh SDKI-SLKI-SIKI

	Fungsi	Contoh
SDKI	Diagnosis	Gangguan mobilitas fisik
SLKI	Luaran	Kekuatan otot meningkat
SIKI	Intervensi	Latihan ROM

Rumbewas et al. (2025) menunjukkan peningkatan akurasi dokumentasi dengan sistem ini.



Gambar 3.1: Alur Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis SDKI-SLKI-SIKI

F. Diagram Model Asuhan Keperawatan Klinik Berbasis EBP

Model asuhan keperawatan klinik berbasis Evidence-Based Practice (EBP) dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu input, proses, output, outcome, dan evaluasi. Model ini menekankan bahwa

kualitas pelayanan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tindakan, tetapi juga oleh integrasi bukti ilmiah dalam setiap tahapan asuhan keperawatan. Pendekatan sistem ini sejalan dengan kerangka mutu pelayanan kesehatan yang dikemukakan oleh Donabedian, yang menghubungkan struktur, proses, dan outcome dalam evaluasi kualitas layanan (Donabedian, 2005; Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

1. Input

Komponen input mencakup seluruh sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis EBP, meliputi sumber daya manusia (SDM), kompetensi perawat, serta fasilitas dan sarana pendukung. SDM yang berkualitas ditandai dengan kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam praktik klinik. Selain itu, ketersediaan fasilitas seperti akses terhadap jurnal ilmiah, sistem informasi kesehatan, serta lingkungan kerja yang mendukung juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi EBP (Dang et al., 2022).

Rasio perawat terhadap pasien serta tingkat pendidikan dan pelatihan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan demikian, input yang optimal menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis bukti.

2. Proses

Komponen proses merupakan inti dari model ini, yaitu pelaksanaan asuhan keperawatan yang terintegrasi dengan prinsip EBP. Proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam konteks EBP, setiap tahap tersebut harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis perawat, serta preferensi pasien.

Penerapan EBP dalam proses keperawatan memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat, aman, dan efektif. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi EBP dalam praktik keperawatan dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi variasi praktik yang tidak berbasis bukti (Melnyk et al., 2022).

3. Output

Output merupakan hasil langsung dari proses asuhan keperawatan yang telah dilakukan, yang umumnya berupa tindakan atau intervensi keperawatan. Output mencerminkan sejauh mana rencana tindakan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.

Dalam model berbasis EBP, output tidak hanya dinilai dari jumlah tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari kesesuaian tindakan dengan bukti ilmiah yang ada. Dengan demikian, output menjadi indikator penting dalam menilai kualitas implementasi proses keperawatan.

4. Outcome

Outcome merupakan hasil akhir dari pelayanan keperawatan yang menunjukkan perubahan kondisi pasien setelah diberikan asuhan. Outcome dapat diukur melalui indikator klinis seperti peningkatan status kesehatan, penurunan komplikasi, lama rawat inap (length of stay), serta kepuasan pasien.

Penerapan EBP terbukti memberikan dampak positif terhadap outcome pasien, termasuk peningkatan keselamatan dan efektivitas pelayanan. Studi menunjukkan bahwa praktik berbasis bukti dapat meningkatkan kualitas layanan hingga 30% (Melnik et al., 2022).

5. Evaluasi

Komponen evaluasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu yang dilakukan melalui audit keperawatan, supervisi klinik, serta monitoring indikator kinerja. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas seluruh komponen dalam model, mulai dari input hingga outcome.

Pendekatan continuous quality improvement (CQI) digunakan dalam tahap ini untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi menjadi umpan balik (feedback loop) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas input dan proses di masa mendatang (Dang et al., 2022).

Model Input–Proses–Output–Outcome–Evaluasi dalam konteks EBP menunjukkan bahwa kualitas asuhan keperawatan merupakan hasil dari integrasi antara sumber daya, proses berbasis bukti, serta evaluasi yang berkelanjutan. Input yang optimal akan mendukung proses keperawatan yang efektif, menghasilkan output yang sesuai standar, serta outcome yang optimal bagi pasien. Evaluasi berperan sebagai mekanisme umpan balik yang memastikan keberlangsungan peningkatan mutu pelayanan.

Dengan demikian, model ini menjadi kerangka konseptual yang penting dalam pengembangan asuhan keperawatan klinik berbasis riset dan praktik profesional modern.

G. Implementasi Model

Implementasi model asuhan keperawatan klinik berbasis Evidence-Based Practice (EBP) tidak hanya ditentukan oleh desain model itu sendiri, tetapi juga oleh faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan penerapannya di lapangan. Dalam kerangka sistem input–proses–output–outcome–evaluasi, faktor pendukung dan penghambat berperan penting terutama pada tahap input dan proses, serta berdampak langsung terhadap kualitas output dan outcome yang dihasilkan (Donabedian, 2005; Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

1. Faktor Pendukung Implementasi Model

a. Pelatihan Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*)

Pelatihan berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi perawat dalam mengimplementasikan EBP dan standar dokumentasi (SDKI–SIKI–SLKI). Perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pencarian literatur, critical appraisal, serta penerapan hasil penelitian akan lebih सक्षम dalam mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik klinik. Program pelatihan yang sistematis terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap praktik berbasis bukti serta kualitas pelayanan keperawatan (Melnyk et al., 2022).

b. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan praktik keperawatan menuju pendekatan berbasis bukti. Pemimpin yang visioner dan suportif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, serta memotivasi perawat untuk mengadopsi inovasi dalam praktik klinik. Studi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan implementasi EBP dan kualitas pelayanan kesehatan (Yoder-Wise, 2023).

c. Budaya Organisasi yang Mendukung

Budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi model. Lingkungan kerja yang terbuka terhadap perubahan dan berbasis ilmiah akan mempermudah integrasi EBP dalam proses keperawatan. Selain itu, budaya keselamatan pasien (patient safety culture) juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas outcome pasien (Dang et al., 2022).

2. Faktor Penghambat Implementasi Model

a. Beban Kerja yang Tinggi

Beban kerja perawat yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan EBP dan dokumentasi yang optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan keterbatasan waktu untuk melakukan pengkajian mendalam, pencarian literatur, serta dokumentasi yang lengkap. Beban kerja yang tidak seimbang juga berpotensi meningkatkan risiko missed nursing care dan menurunkan kualitas pelayanan (Aiken et al., 2021).

b. Kurangnya Literasi Riset

Literasi riset yang rendah menjadi tantangan dalam implementasi EBP. Banyak perawat yang belum memiliki keterampilan dalam memahami, mengevaluasi, dan mengaplikasikan hasil penelitian dalam praktik klinik. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara bukti ilmiah dan praktik nyata di lapangan (Melnik & Fineout-Overholt, 2023).

c. Keterbatasan Waktu dan Akses Literatur

Keterbatasan waktu dan akses terhadap sumber literatur ilmiah merupakan hambatan yang paling sering dilaporkan dalam implementasi EBP. Perawat seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses database jurnal atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pencarian dan analisis bukti ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa faktor ini menjadi hambatan utama dalam penerapan praktik berbasis bukti di layanan kesehatan (Dang et al., 2022).

3. Integrasi Faktor dalam Model Sistem Asuhan Keperawatan

Faktor pendukung dan penghambat tersebut berinteraksi secara langsung dengan komponen dalam model sistem asuhan keperawatan. Faktor pendukung seperti pelatihan dan kepemimpinan memperkuat komponen input dan proses, sehingga menghasilkan output dan outcome yang optimal. Sebaliknya, faktor penghambat seperti beban kerja dan keterbatasan waktu dapat mengganggu proses keperawatan dan berdampak pada kualitas hasil yang dicapai.

Melalui mekanisme evaluasi dan feedback loop, organisasi dapat mengidentifikasi hambatan yang ada dan melakukan intervensi perbaikan secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Dengan demikian, implementasi model asuhan keperawatan berbasis EBP memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pada aspek klinis, tetapi juga pada aspek manajerial dan organisasi.

H. Integrasi Teknologi dalam Model

Perkembangan teknologi informasi kesehatan telah memberikan kontribusi signifikan dalam transformasi praktik keperawatan modern. Dalam konteks model asuhan keperawatan klinik berbasis Evidence-Based Practice (EBP), integrasi teknologi menjadi komponen penting yang memperkuat efektivitas setiap tahapan dalam sistem input–proses–output–outcome–evaluasi. Teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai enabler dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinik, akurasi dokumentasi, serta efisiensi pelayanan (Topaz et al., 2022; Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

1. Electronic Health Record (EHR)

Electronic Health Record (EHR) merupakan sistem pencatatan kesehatan berbasis digital yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data pasien secara terintegrasi. Dalam model asuhan keperawatan, EHR berperan penting pada komponen input dan proses, khususnya dalam mendukung pengkajian dan dokumentasi keperawatan.

Integrasi EHR dengan standar dokumentasi nasional seperti SDKI–SIKI–SLKI memungkinkan pencatatan yang lebih sistematis, akurat, dan real-time. Hal ini meningkatkan kontinuitas asuhan serta meminimalkan kesalahan dokumentasi. Selain itu, EHR juga mempermudah proses audit dan evaluasi mutu pelayanan karena data tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses (Topaz et al., 2022).

2. Clinical Decision Support System (CDSS)

Clinical Decision Support System (CDSS) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinik melalui penyediaan rekomendasi berbasis bukti ilmiah. Dalam konteks EBP, CDSS berperan penting dalam komponen proses, terutama dalam tahap perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan.

CDSS dapat mengintegrasikan data pasien dari EHR dengan database evidence terkini, sehingga menghasilkan rekomendasi intervensi yang lebih tepat dan individual. Penggunaan CDSS terbukti meningkatkan akurasi keputusan klinik, mengurangi variasi praktik, serta meningkatkan keselamatan pasien (Topaz et al., 2022). Dengan demikian, CDSS menjadi alat strategis dalam menjembatani kesenjangan antara penelitian dan praktik klinik.

3. Telehealth

Telehealth merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh, termasuk konsultasi, monitoring

pasien, dan edukasi kesehatan. Dalam model asuhan keperawatan, telehealth memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi pasien di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas.

Telehealth berkontribusi pada komponen output dan outcome, karena memungkinkan intervensi keperawatan tetap dilakukan secara berkelanjutan meskipun tanpa tatap muka langsung. Selain itu, telehealth juga mendukung pemantauan kondisi pasien secara real-time, sehingga memungkinkan deteksi dini komplikasi dan intervensi yang lebih cepat. Studi menunjukkan bahwa telehealth dapat meningkatkan kepatuhan pasien, kepuasan, serta hasil klinis secara keseluruhan (Melnyk et al., 2022).

Integrasi Teknologi dalam Model Sistem Asuhan Keperawatan

Integrasi EHR, CDSS, dan telehealth dalam model asuhan keperawatan berbasis EBP memperkuat seluruh komponen sistem:

1. Input: penyediaan data pasien yang akurat melalui EHR
2. Proses: pengambilan keputusan berbasis bukti dengan dukungan CDSS
3. Output: pelaksanaan intervensi yang lebih tepat dan terdokumentasi dengan baik
4. Outcome: peningkatan hasil klinis dan kepuasan pasien melalui telehealth
5. Evaluasi: kemudahan audit mutu melalui data digital yang terintegrasi

Dengan adanya teknologi, mekanisme feedback loop dalam model menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung *continuous quality improvement* dalam pelayanan keperawatan.

I. Penutup

Model asuhan keperawatan klinik berbasis riset merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Integrasi EBP, teknologi, dan standar nasional menjadi kunci keberhasilan implementasi model. Penggunaan SDKI, SIKI, dan SLKI dalam dokumentasi keperawatan merupakan inovasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Standarisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dokumentasi, tetapi juga memperkuat praktik keperawatan berbasis bukti serta profesionalisme perawat. Oleh karena itu, implementasi SDKI-SIKI-SLKI perlu didukung dengan pelatihan berkelanjutan, supervisi klinik, serta komitmen organisasi untuk mencapai mutu pelayanan yang optimal.

Keberhasilan implementasi model asuhan keperawatan klinik berbasis EBP sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat. Optimalisasi faktor pendukung serta mitigasi hambatan menjadi

strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen organisasi, penguatan kapasitas SDM, serta dukungan sistem yang memadai untuk memastikan keberhasilan implementasi model secara berkelanjutan.

Integrasi teknologi dalam model asuhan keperawatan klinik berbasis EBP merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga memperkuat implementasi praktik berbasis bukti serta sistem dokumentasi yang terstandar. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi teknologi memerlukan dukungan infrastruktur, peningkatan kompetensi digital perawat, serta kebijakan organisasi yang mendukung transformasi digital dalam pelayanan keperawatan.

Referensi

- Aiken, L. H., Sloane, D. M., Ball, J., Bruyneel, L., Rafferty, A. M., & Griffiths, P. (2021).
Alligood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
Armstrong, D. G., et al. (2021). Diabetic foot ulcers. *New England Journal of Medicine*.
Dang, D., Dearholt, S. L., Bissett, K., Ascenzi, J., & Whalen, M. (2022). *Johns Hopkins evidence-based practice for nurses and healthcare professionals: Model and guidelines* (4th ed.). Sigma Theta Tau International.
Donabedian, A. (2005). Evaluating the quality of medical care. *The Milbank Quarterly*, 83(4), 691–729. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00397.x>
European Association for the Study of the Liver. (2021). *Clinical practice guidelines*.
Fawcett, J., & DeSanto-Madeya, S. (2021). *Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories* (4th ed.). F.A. Davis Company.
Kalisch, B. J., Lee, K. H., & Salas, E. (2021). The impact of teamwork on missed nursing care. *Nursing Outlook*, 69(1), 19–27. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.08.001>
Kelly, L. A., Gee, P. M., & Butler, R. J. (2021). Impact of nurse burnout on organizational and position turnover. *Nursing Outlook*, 69(1), 96–102. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.06.008>
Langhorne, P., et al. (2020). Stroke rehabilitation. *The Lancet*.
Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.
Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.
Melnyk, B. M., et al. (2022). *Evidence-based practice outcomes. Worldviews on Evidence-Based Nursing*.

- Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Long, L. E., & Fineout-Overholt, E. (2022). The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 19(1), 6–15. <https://doi.org/10.1111/wvn.12588>
- Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: An observational study. *BMJ Open*, 11(1), e042128. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-042128>
- Pramidyasstuti, C. H. P., Hastuti, A. S. O., & Novianti, B. E. (2024). Penerapan model asuhan keperawatan profesional terhadap kualitas pelayanan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Rumbewas, T. Y., Wardani, R., & Sultan. (2025). Penerapan SDKI, SIKI, dan SLKI dalam meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan. *Jurnal Kolaborasi Keperawatan*, 6(1).
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Titler, M. G. (2021). The Iowa model of evidence-based practice to promote quality care. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 18(1), 1–3. <https://doi.org/10.1111/wvn.12495>
- Topaz, M., Murga, L., Gaddis, K. M., McDonald, M. V., Bar-Bachar, O., Goldberg, Y., & Bowles, K. H. (2022). Artificial intelligence and clinical decision support in nursing: A systematic review. *Journal of Nursing Administration*, 52(3), 158–165. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000001138>
- Yoder-Wise, P. S. (2023). *Leading and managing in nursing* (8th ed.). Elsevier.

BAB 4

MODEL ASUHAN BERBASIS KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Model asuhan berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis dalam praktik keperawatan modern yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada individu yang sakit, tetapi juga pada kelompok, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan dengan mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam konteks global dan nasional, peningkatan kasus penyakit menular maupun tidak menular menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui upaya promotif dan preventif di tingkat komunitas. Pelayanan keperawatan komunitas terbukti mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam penyelesaian masalah kesehatan. Model asuhan berbasis komunitas menjadi dasar penting dalam sistem pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup (Albarnawi et al., 2024).

Penerapan model ini semakin meningkat seiring dengan kompleksitas masalah kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya prevalensi penyakit kronis, penuaan populasi, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di fasilitas rujukan. Model asuhan berbasis komunitas memungkinkan identifikasi masalah kesehatan secara dini melalui pengkajian langsung di lingkungan masyarakat serta optimalisasi sumber daya lokal yang tersedia (Ewald et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu meningkatkan manajemen diri pasien, menurunkan risiko komplikasi penyakit, serta memperbaiki kualitas hidup, khususnya pada kelompok rentan seperti lansia dengan hipertensi (Halimatussakdiah & Faisal, 2022). Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses asuhan memperkuat keberlanjutan intervensi serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program Kesehatan (H. Macdonald et al., 2026).

Dari perspektif pemberi pelayanan kesehatan, model asuhan berbasis komunitas memberikan berbagai keuntungan, antara lain peningkatan efisiensi layanan, perluasan jangkauan pelayanan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Perawat komunitas berperan sebagai edukator, fasilitator, dan advokat yang tidak hanya memberikan asuhan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri

dalam menjaga kesehatannya. Bagi masyarakat, pendekatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran kesehatan, akses pelayanan yang lebih dekat, serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Implementasi model ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan perawat serta kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan (Jena et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan model asuhan berbasis komunitas menjadi sangat penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan Berbasis Komunitas

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Asuhan keperawatan berbasis komunitas merupakan suatu pendekatan pelayanan keperawatan yang berfokus pada individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks lingkungan tempat mereka hidup dan berinteraksi. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai pusat pelayanan dengan menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Keperawatan komunitas tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan perawatan mandiri serta pengendalian faktor risiko kesehatan (A. H. Macdonald et al., 2024).

Ruang lingkup asuhan keperawatan berbasis komunitas meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif terbatas, dan rehabilitatif yang dilaksanakan di berbagai tatanan seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan primer. Selain itu, ruang lingkup ini juga mencakup pengkajian kebutuhan kesehatan masyarakat, identifikasi masalah kesehatan prioritas, serta implementasi intervensi berbasis bukti yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Zeydani et al., 2023).

2. Filosofi dan Prinsip Dasar (Holistik, Promotif-Preventif)

Filosofi utama dalam keperawatan komunitas adalah pendekatan holistik yang memandang manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Oleh karena itu, intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu dan komunitas (Juniarti & Fuller, 2025).

Prinsip promotif dan preventif menjadi landasan utama dalam praktik keperawatan komunitas. Upaya promotif dilakukan melalui edukasi kesehatan,

peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan perilaku hidup sehat. Sementara itu, upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau komplikasi melalui deteksi dini dan pengendalian faktor risiko. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menurunkan beban penyakit dibandingkan pendekatan kuratif semata. Selain itu, prinsip lain yang mendasari adalah partisipasi masyarakat, pemberdayaan (*empowerment*), keadilan sosial, dan kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan (Zeydani et al., 2023).

3. Peran Perawat dalam Komunitas

Perawat komunitas memiliki peran yang luas dan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut meliputi sebagai pemberi asuhan (*care provider*), edukator, konselor, advokat, koordinator, serta peneliti. Sebagai pemberi asuhan, perawat memberikan pelayanan langsung kepada individu dan keluarga. Sebagai edukator, perawat berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Kesehatan (Weidmann, 2023.).

Selain itu, perawat komunitas juga berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, membantu komunitas dalam mengenali masalah kesehatan dan menemukan solusi secara mandiri. Peran advokasi juga sangat penting, terutama dalam memperjuangkan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan. Dalam praktiknya, perawat komunitas harus mampu bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai hasil yang optimal (Costa et al., 2020). Harapannya, perawat komunitas memiliki kontribusi besar dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

C. Teori dan Model keperawatan Komunitas

1. Model Health Belief Model (HBM)

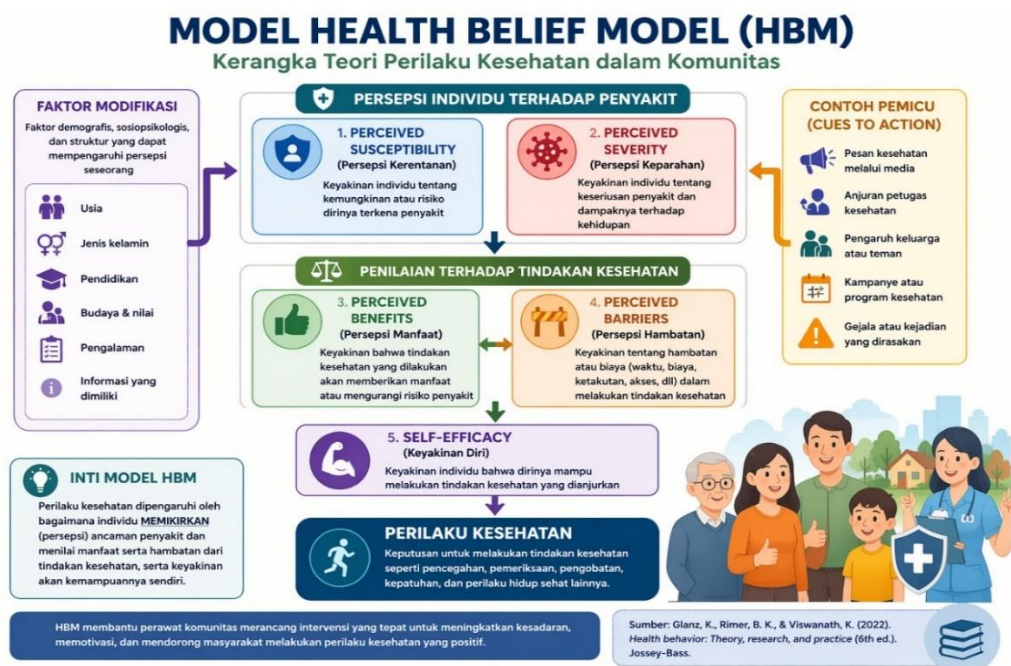
Health Belief Model (HBM) merupakan salah satu model teoritis yang paling banyak digunakan dalam promosi kesehatan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan individu. Model ini berfokus pada persepsi individu terhadap ancaman penyakit dan manfaat tindakan pencegahan. Komponen utama HBM meliputi *perceived susceptibility* (kerentanan), *perceived severity* (keparahan), *perceived benefits* (manfaat), *perceived barriers* (hambatan), serta *self-efficacy* atau keyakinan diri (Mcneil, 2024).

Dalam konteks keperawatan komunitas, HBM digunakan untuk memahami faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat, seperti kepatuhan pengobatan, imunisasi, dan perilaku hidup sehat. Penelitian menunjukkan

bahwa penggunaan HBM dalam intervensi komunitas dapat meningkatkan kesadaran kesehatan dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif, terutama dalam pencegahan penyakit kronis (Malinda, 2024).

Model ini menunjukkan bahwa perilaku kesehatan individu dalam komunitas tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses kognitif yang kompleks. Individu akan melakukan tindakan kesehatan jika mereka merasa rentan terhadap penyakit (*perceived susceptibility*) dan meyakini bahwa penyakit tersebut serius (*perceived severity*). Selanjutnya, individu akan mempertimbangkan manfaat tindakan (*perceived benefits*) dibandingkan hambatan yang mungkin dihadapi (*perceived barriers*).

Selain itu, adanya pemicu tindakan (*cues to action*) seperti edukasi dari tenaga kesehatan, kampanye kesehatan, atau pengalaman orang terdekat dapat memperkuat keputusan untuk bertindak. Faktor penting lainnya adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu bahwa mereka mampu melakukan tindakan kesehatan tersebut. Kombinasi seluruh komponen ini akhirnya menentukan apakah seseorang akan melakukan perilaku kesehatan atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan gambar 4.1 dibawah ini.



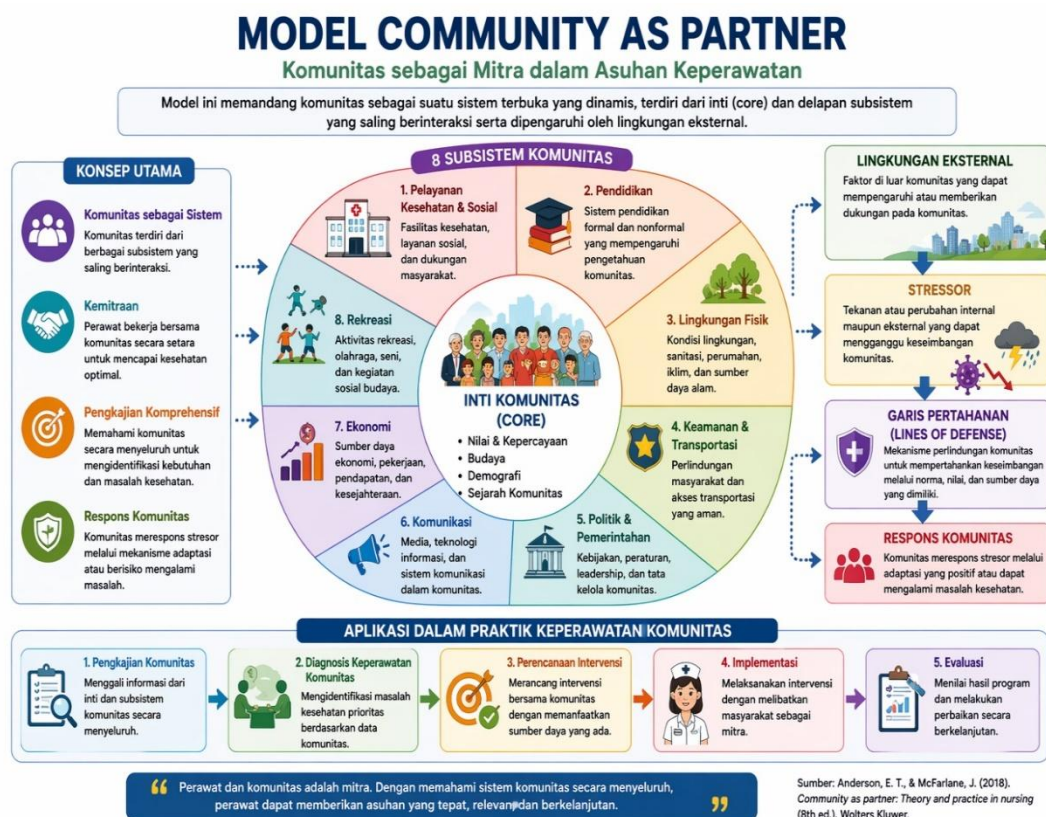
Gambar 4.1: Model Health Belief Model (HBM)

2. Model Community as Partner Model

Model *Community as Partner* dikembangkan oleh Anderson dan McFarlane, yang memandang komunitas sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi (Alcantara et al., 2015).

Model ini menekankan bahwa komunitas memiliki inti (*core*) berupa nilai, kepercayaan, dan budaya, yang dikelilingi oleh subsistem seperti lingkungan fisik, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan (Reports, 2025).

Dalam praktik keperawatan komunitas, model ini digunakan sebagai kerangka untuk melakukan pengkajian komunitas secara komprehensif, mengidentifikasi masalah kesehatan, serta merancang intervensi berbasis kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kemitraan antara perawat dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan (Weidmann, 2023). Berikut ini dijabarkan gambar Community as Partner Model.



Gambar 4.2: Model Community as Partner Model

Model *Community as Partner* menggambarkan komunitas sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri dari inti (*core*) dan berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Inti komunitas merupakan pusat dari model yang mencakup karakteristik penduduk seperti nilai, budaya, kepercayaan, sejarah, dan demografi. Di sekitar inti terdapat delapan subsistem utama yang mempengaruhi kesehatan komunitas, yaitu lingkungan fisik, pendidikan, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintahan, pelayanan kesehatan dan sosial, komunikasi, ekonomi, serta rekreasi.

Model ini juga menekankan adanya garis pertahanan (*lines of defense*), yaitu kondisi kesehatan normal komunitas yang dapat dipengaruhi oleh berbagai stressor, baik dari dalam maupun luar komunitas. Ketika stressor menembus sistem pertahanan, komunitas akan memberikan respons berupa adaptasi atau munculnya masalah kesehatan. Oleh karena itu, perawat komunitas perlu mengidentifikasi stressor dan memperkuat *lines of resistance* melalui intervensi promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini sangat penting dalam praktik keperawatan komunitas karena memberikan kerangka sistematis dalam melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, hingga evaluasi asuhan keperawatan berbasis komunitas. Model ini juga menekankan kemitraan antara perawat dan masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

3. Model PRECEDE–PROCEED

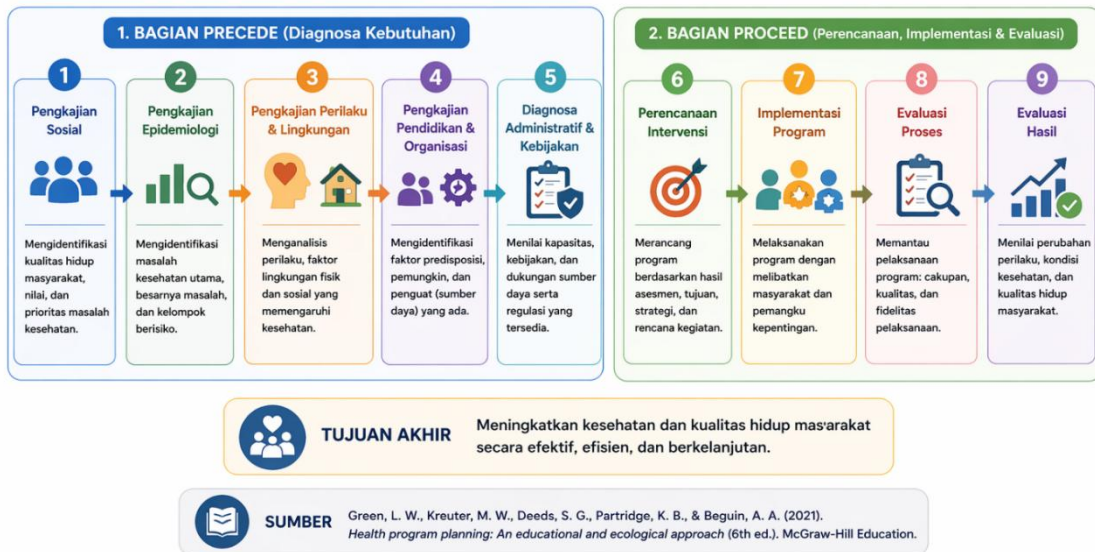
Model PRECEDE–PROCEED merupakan kerangka kerja perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan yang sistematis dan komprehensif. Model ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu PRECEDE (*Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation*) dan PROCEED (*Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development*). Model ini mencakup beberapa tahapan mulai dari pengkajian sosial, epidemiologi, perilaku, hingga implementasi dan evaluasi program kesehatan (Kim et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan model PRECEDE–PROCEED dalam program kesehatan masyarakat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan masyarakat, serta efektif dalam pencegahan penyakit kronis dan peningkatan kualitas hidup (Kim et al., 2022). Selain itu, model ini juga banyak digunakan dalam promosi kesehatan berbasis komunitas di Indonesia, seperti dalam program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Malinda, 2024).

MODEL PRECEDE-PROCEED

Kerangka Perencanaan dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan Berbasis Bukti

Model PRECEDE-PROCEED adalah kerangka kerja sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif.



Gambar 4.3: Model PRECEDE-PROCEED

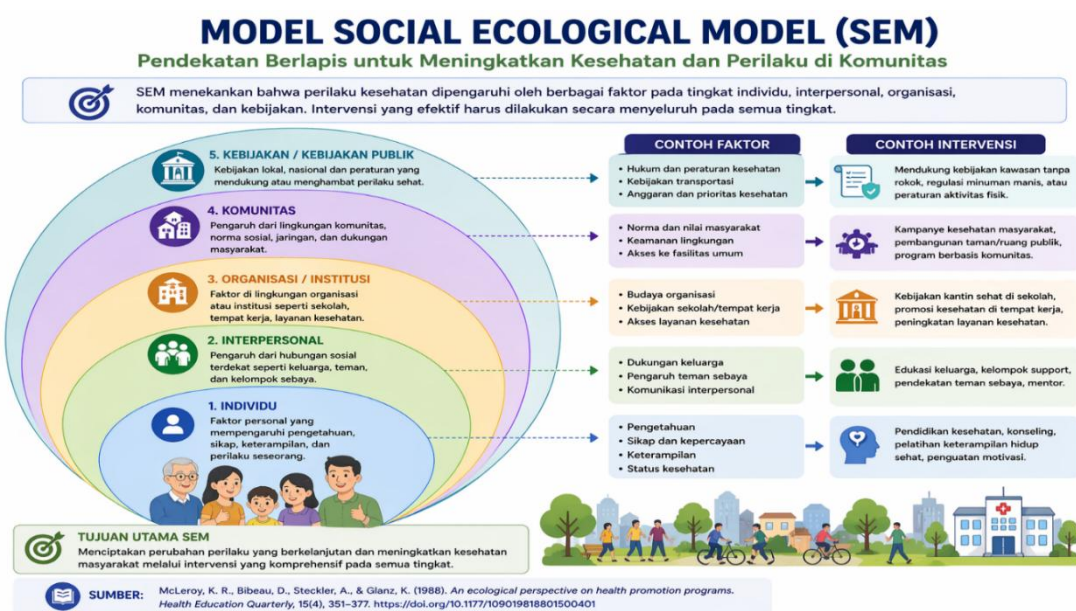
Model **PRECEDE-PROCEED** merupakan kerangka kerja sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat. Pada gambar terlihat dua bagian utama, yaitu tahap **PRECEDE** dan **PROCEED**. Tahap PRECEDE (langkah 1–5) berfokus pada proses diagnosis masalah, dimulai dari pengkajian sosial untuk memahami kualitas hidup masyarakat, dilanjutkan dengan pengkajian epidemiologi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan utama, kemudian analisis perilaku dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan, serta identifikasi faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat melalui pengkajian pendidikan dan organisasi. Tahap ini diakhiri dengan analisis kebijakan dan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya tahap PROCEED (langkah 6–9) merupakan tahap intervensi yang meliputi perencanaan program berdasarkan hasil pengkajian, implementasi program dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta evaluasi yang terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Secara keseluruhan, model ini menggambarkan alur yang terstruktur dari identifikasi masalah hingga penilaian dampak program, dengan tujuan akhir meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4. Model Social Ecological Model (SEM)

Social Ecological Model (SEM) merupakan model yang menekankan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi pada berbagai tingkat, yaitu individu, interpersonal, organisasi, komunitas, dan kebijakan publik. Model ini menegaskan bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi individu, tetapi memerlukan pendekatan yang melibatkan lingkungan sosial dan kebijakan (Johannes & Roman, 2025).

Dalam keperawatan komunitas, SEM digunakan untuk merancang intervensi yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kesehatan kompleks, seperti penyakit tidak menular dan masalah kesehatan lingkungan (B. C. Lee et al., 2017). Model SEM dirancang dalam gambar 4 berikut ini.



Gambar 4.4: Model PRECEDE-PROCEED

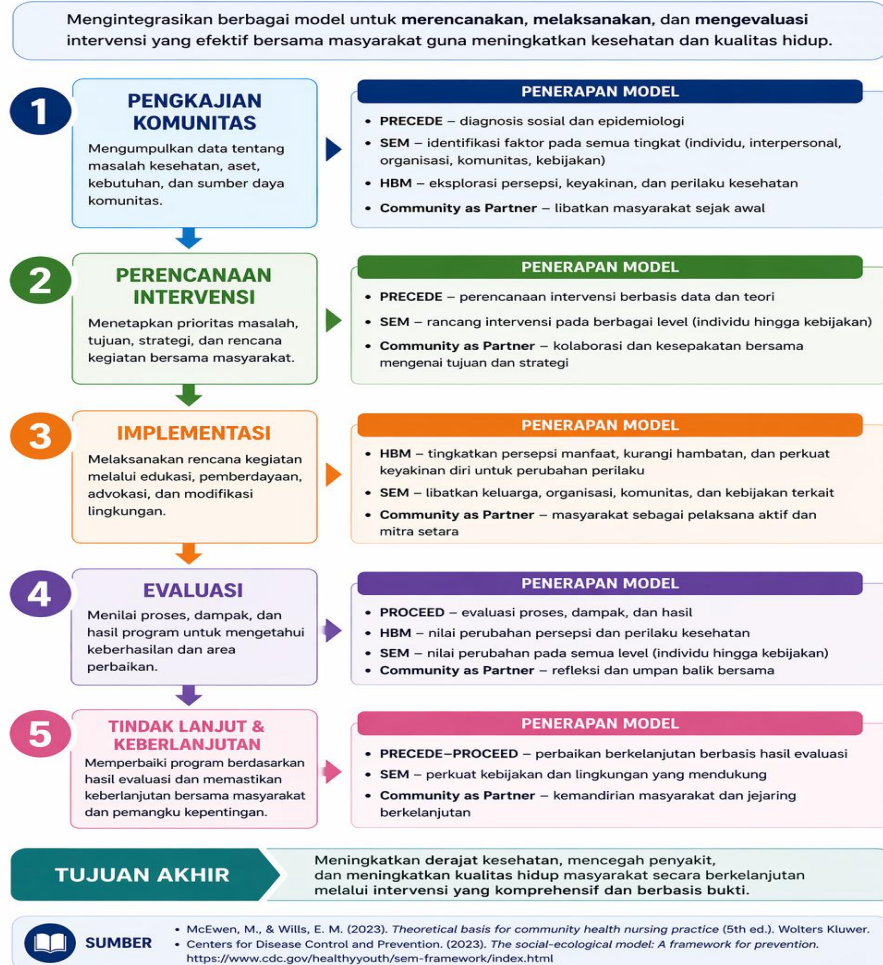
Model *Social Ecological Model* (SEM) pada gambar menggambarkan bahwa perilaku kesehatan individu dipengaruhi oleh berbagai lapisan faktor yang saling berinteraksi secara bertingkat. Lapisan paling dalam adalah individu, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Lapisan berikutnya adalah **interpersonal**, yaitu pengaruh dari hubungan sosial seperti keluarga, teman, dan kelompok sebaya. Selanjutnya, pada tingkat **organisasi**, perilaku dipengaruhi oleh lingkungan institusi seperti sekolah, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan. Pada tingkat **komunitas**, norma sosial, budaya, serta

jaringan sosial masyarakat turut membentuk perilaku kesehatan. Lapisan terluar adalah **kebijakan publik**, yang mencakup regulasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung atau menghambat perilaku sehat. Secara keseluruhan, model ini menekankan bahwa intervensi kesehatan akan lebih efektif jika dilakukan secara komprehensif pada seluruh tingkat tersebut, bukan hanya berfokus pada individu saja (Ewald et al., 2023).

5. Aplikasi Model dalam Praktik Keperawatan Komunitas

Penerapan berbagai model keperawatan komunitas dalam praktik memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan. Model HBM membantu perawat memahami perilaku individu, sementara *Community as Partner Model* memfasilitasi pengkajian komunitas secara menyeluruh. Di sisi lain, model **PRECEDE-PROCEED** memberikan panduan dalam perencanaan program kesehatan berbasis bukti, dan SEM membantu mengidentifikasi faktor-faktor multi-level yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 4.5 dibawah ini.

APLIKASI MODEL DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN KOMUNITAS



Gambar 4.5 Aplikasi Model dalam Praktik Keperawatan Komunitas

Integrasi model-model tersebut dalam **praktik keperawatan komunitas terbukti** meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, serta keberlanjutan program kesehatan. Pendekatan berbasis teori ini juga memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang lebih terarah, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rajan et al., 2023).

D. Jenis Jenis Pendekatan Asuhan Berbasis Komunitas

1. Pendekatan Keluarga (*Family-Centered Care*)

Pendekatan *family-centered care* (FCC) merupakan strategi dalam keperawatan komunitas yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pelayanan kesehatan. Dalam pendekatan ini, keluarga tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan. FCC menekankan kolaborasi antara perawat, pasien, dan keluarga dengan menghargai nilai, budaya, serta preferensi keluarga dalam pengambilan keputusan Kesehatan (Balqis et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan FCC dalam komunitas, khususnya pada pasien penyakit kronis dan lansia, mampu meningkatkan kualitas hidup, kepatuhan terapi, serta kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarganya. Selain itu, pendekatan ini juga efektif dalam meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui edukasi dan layanan *homecare* berbasis komunitas (Correia et al., 2025).

2. Pendekatan Kelompok Risiko (*Risk Group Approach*)

Pendekatan kelompok risiko adalah strategi yang memfokuskan intervensi keperawatan pada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah kesehatan tertentu, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, atau kelompok dengan penyakit kronis. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan intervensi (Senga & Kouhestani, 2020). Dalam praktik keperawatan komunitas, pendekatan ini dilakukan melalui identifikasi kelompok rentan, pengkajian faktor risiko, serta pemberian intervensi spesifik sesuai kebutuhan kelompok tersebut. Studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kelompok risiko dapat meningkatkan keberhasilan program kesehatan karena intervensi lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik populasi sasaran. Dengan demikian, pendekatan ini berperan penting dalam upaya promotif dan preventif untuk menekan angka kesakitan dan komplikasi (Bekele et al., 2023).

3. Pendekatan Siklus Hidup (*Life Cycle Approach*)

Pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*) merupakan pendekatan yang memberikan asuhan keperawatan berdasarkan tahap perkembangan manusia, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Setiap tahap kehidupan memiliki kebutuhan kesehatan dan faktor risiko yang berbeda, sehingga intervensi keperawatan harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan dan komprehensif sepanjang rentang kehidupan individu. Dalam keperawatan komunitas, pendekatan siklus hidup sering digunakan dalam program kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta pelayanan lansia. Penerapan pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena mampu mengintegrasikan

upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan (Macinko, 2005).

4. Pendekatan Berbasis Aset Komunitas (*Asset-Based Community Development /ABCD*)

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada potensi dan aset yang dimiliki komunitas, bukan pada kekurangan atau masalahnya. Aset tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sosial, ekonomi, fisik, maupun kelembagaan yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal dalam mengatasi masalah kesehatan secara mandiri (Ridhani, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan ABCD dalam program kesehatan komunitas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat jejaring sosial, serta menciptakan keberlanjutan program kesehatan berbasis komunitas. Pendekatan ini sangat relevan dalam keperawatan komunitas modern karena sejalan dengan prinsip pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat (Costa et al., 2020).

E. Inovasi Dan Pengembangan Model Asuhan Komunitas

1. Digital Health dan Telehealth Komunitas

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pelayanan kesehatan, termasuk dalam keperawatan komunitas. Namun, masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan. Fenomena ini semakin terlihat sejak pandemi COVID-19, di mana keterbatasan mobilitas mendorong penggunaan layanan kesehatan jarak jauh. Di sisi lain, literasi digital masyarakat yang belum merata serta keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam implementasi digital health di komunitas (Kruse et al., 2018).

Digital health dan telehealth komunitas merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, termasuk konsultasi, edukasi, monitoring, dan manajemen penyakit kronis. Dalam keperawatan komunitas, telehealth memungkinkan perawat melakukan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan tanpa harus bertatap muka langsung (Sundoro et al., 2025). Hal ini terbukti meningkatkan akses layanan, efisiensi, serta kualitas perawatan terutama pada pasien dengan penyakit kronis (Ismiyah et al., 2024).

Inovasi dan pengembangan model ini dapat dilakukan melalui integrasi aplikasi mobile health, penggunaan wearable devices, serta pengembangan sistem informasi berbasis komunitas. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Ke depan, telehealth komunitas dapat dikembangkan dengan pendekatan berbasis artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan personalisasi intervensi keperawatan (Halimatussakdiah et al., 2022).

2. Community-Based Participatory Research (CBPR)

Pendekatan penelitian tradisional sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga hasil penelitian kurang relevan dengan kebutuhan lokal. Fenomena ini menyebabkan rendahnya keberlanjutan program kesehatan di komunitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang lebih inklusif dan partisipatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penelitian (Febriyanti et al., 2025).

Community-Based Participatory Research (CBPR) adalah pendekatan penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi. Dalam keperawatan komunitas, CBPR memungkinkan perawat dan masyarakat bekerja sama dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini terbukti meningkatkan keberterimaan program, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan intervensi kesehatan (Yadav & Banerjee, 2025).

Pengembangan CBPR ke depan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Selain itu, integrasi CBPR dengan kebijakan kesehatan lokal dapat meningkatkan dampak program secara lebih luas. Model ini juga dapat dikembangkan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan berbasis komunitas secara berkelanjutan (Dwiadila & Putra, 2021).

3. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer sering kali masih belum terintegrasi, sehingga menyebabkan ketidakefisienan layanan dan kurang optimalnya hasil kesehatan masyarakat. Fenomena ini terlihat dari kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan, keterbatasan akses layanan, serta kurangnya kesinambungan perawatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan (A. H. Macdonald et al., 2024).

Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai layanan kesehatan, termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu sistem yang terkoordinasi. Dalam keperawatan komunitas, integrasi ini melibatkan kolaborasi antar profesi kesehatan, penggunaan sistem rujukan yang efektif, serta penguatan peran puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kualitas layanan, efisiensi sistem kesehatan, serta kepuasan pasien (Weidmann, n.d.).

Inovasi dalam integrasi pelayanan kesehatan primer dapat dilakukan melalui penguatan sistem digital health, pengembangan model pelayanan berbasis tim (*team-based care*), serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, integrasi dengan sektor non-kesehatan seperti pendidikan dan sosial juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara holistic (Jena et al., 2025).

4. Model Berbasis Kearifan Lokal

Globalisasi dan modernisasi sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal dalam pelayanan kesehatan, sehingga intervensi yang diberikan kurang sesuai dengan budaya masyarakat. Fenomena ini menyebabkan rendahnya penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan komunitas (Airhihenbuwa et al., 2020).

Model berbasis kearifan lokal adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai budaya, tradisi, dan praktik lokal dalam pelayanan kesehatan. Dalam keperawatan komunitas, pendekatan ini melibatkan tokoh masyarakat, penggunaan bahasa lokal, serta pemanfaatan sumber daya lokal dalam intervensi kesehatan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat, kepatuhan terhadap intervensi, serta keberhasilan program Kesehatan (Napier, 2014).

Pengembangan model ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang relevan. Selain itu, integrasi kearifan lokal dengan teknologi modern dapat menciptakan inovasi baru dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan ini juga dapat dikembangkan sebagai strategi untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan inklusif (Airhihenbuwa et al., 2020).

F. Asuhan keperawatan Komunitas

1. Pengkajian Komunitas (*Community Assessment*)

Pengkajian komunitas merupakan tahap awal dalam proses keperawatan komunitas yang bertujuan mengidentifikasi status kesehatan, kebutuhan, serta sumber daya yang dimiliki masyarakat. Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis baik data subjektif maupun objektif untuk memahami kondisi kesehatan populasi secara menyeluruh. Pengkajian menjadi dasar dalam seluruh tahapan berikutnya karena menentukan arah intervensi yang akan dilakukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Zeydani et al., 2023).

Dalam praktik lapangan, pengkajian komunitas dilakukan melalui berbagai metode seperti survei kesehatan, wawancara dengan tokoh masyarakat, observasi lingkungan, serta analisis data sekunder (misalnya laporan puskesmas atau profil kesehatan daerah). Perawat komunitas juga menilai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah prioritas serta potensi yang dapat dimanfaatkan dalam intervensi kesehatan (Cassells, n.d.).

Dari aspek riset, pengkajian komunitas dapat dikembangkan menjadi penelitian epidemiologi komunitas, analisis determinan sosial kesehatan, serta pemetaan kebutuhan kesehatan berbasis data. Penelitian ini penting untuk menghasilkan *evidence-based community assessment* yang lebih akurat dan kontekstual. Selain itu, riset juga dapat mengembangkan instrumen pengkajian yang valid dan reliabel untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan (Delanerolle et al., 2023).

2. Diagnosis Keperawatan Komunitas

Diagnosis keperawatan komunitas adalah tahap analisis data hasil pengkajian untuk mengidentifikasi masalah kesehatan aktual maupun potensial yang dialami masyarakat. Diagnosis ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi pada kelompok atau populasi, termasuk faktor risiko dan determinan yang mempengaruhi kesehatan. Diagnosis keperawatan menjadi dasar dalam penentuan intervensi yang tepat dan efektif (Zeydani et al., 2023).

Dalam penerapan praktik, diagnosis komunitas disusun berdasarkan prioritas masalah menggunakan pendekatan seperti analisis epidemiologi, skala prioritas, dan partisipasi masyarakat. Perawat komunitas biasanya menggunakan format standar seperti NANDA atau pendekatan berbasis masalah kesehatan masyarakat. Proses ini melibatkan kolaborasi dengan stakeholder lokal untuk memastikan diagnosis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam aspek riset, diagnosis keperawatan komunitas dapat dikembangkan melalui studi validasi diagnosis, pengembangan klasifikasi diagnosis berbasis komunitas, serta analisis hubungan antara diagnosis dengan luaran kesehatan. Penelitian juga dapat mengevaluasi keakuratan diagnosis dalam meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan dan outcome kesehatan masyarakat (Costa et al., 2020).

3. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi merupakan tahap penyusunan strategi untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini ditentukan tujuan, sasaran, serta intervensi yang akan dilakukan berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*). Perencanaan harus berbasis bukti (*evidence-based*) dan mempertimbangkan kondisi serta sumber daya komunitas (Albarnawi et al., 2024).

Dalam praktik lapangan, perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan intervensi yang dirancang dapat diterima dan berkelanjutan. Contohnya adalah program penyuluhan kesehatan, pemberdayaan kader, serta intervensi lingkungan seperti perbaikan sanitasi. Perencanaan juga mencakup penentuan indikator keberhasilan yang akan digunakan dalam evaluasi.

Dari sisi riset, perencanaan intervensi dapat dikembangkan melalui penelitian intervensi komunitas, uji efektivitas program kesehatan, serta pengembangan model intervensi inovatif. Penelitian dalam komunitas bertujuan menghasilkan strategi intervensi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis bukti ilmiah (Halimatussakdiah Halimatussakdiah et al., 2020).

4. Implementasi Program

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disusun. Tahap ini melibatkan tindakan nyata untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, baik melalui intervensi langsung maupun tidak langsung. Implementasi merupakan fase aksi dalam proses keperawatan yang menuntut keterampilan teknis, komunikasi, dan manajemen dari perawat (Yusuf et al., 2024).

Dalam praktik komunitas, implementasi dapat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, skrining penyakit, dan pemberdayaan masyarakat. Intervensi juga dapat dikategorikan menjadi klinis, perilaku, dan lingkungan tergantung pada sasaran

program kesehatan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan lintas sektor (Mm et al., 2026)

Dalam aspek riset, implementasi program dapat dikaji melalui penelitian implementasi (implementation research) yang menilai efektivitas, efisiensi, serta faktor pendukung dan penghambat program. Pada fase ini, penelitian penting dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat (S. Lee, 2026).

5. Evaluasi Berbasis Indikator Kesehatan

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan komunitas yang bertujuan menilai keberhasilan intervensi berdasarkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang diharapkan serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat

Dalam praktik, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi menggunakan indikator kesehatan seperti angka kejadian penyakit, tingkat pengetahuan masyarakat, serta perubahan perilaku kesehatan. Evaluasi juga melibatkan penilaian proses (*process evaluation*) dan hasil (*outcome evaluation*) untuk mengetahui efektivitas program (Reports, 2025)

Dari sisi riset, evaluasi berbasis indikator kesehatan dapat dikembangkan melalui penelitian evaluatif, studi longitudinal, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas program kesehatan komunitas serta sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti (Montolalu, 2024)(sumber...)

G. Kaitan riset keperawatan dan model asuhan berbasis komunitas

Kaitan riset keperawatan dan model asuhan berbasis komunitas merupakan bagian penting dalam penulisan ilmiah karena menunjukkan bagaimana ilmu keperawatan berkembang secara evidence-based dan aplikatif di masyarakat. Dalam narasi ini, perlu dijelaskan bahwa riset keperawatan berfungsi sebagai landasan ilmiah dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi model asuhan berbasis komunitas. Model asuhan komunitas tidak hanya berorientasi pada pelayanan klinis, tetapi juga pada promotif dan preventif, sehingga membutuhkan dukungan penelitian yang kuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Selanjutnya, penting dijelaskan bahwa riset keperawatan berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat serta faktor determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan. Dalam konteks ini, penelitian berbasis komunitas memungkinkan perawat memahami kondisi nyata di lapangan, seperti budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa intervensi keperawatan berbasis komunitas mampu meningkatkan self-management, kualitas hidup, dan kepuasan pasien karena disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat. Dengan demikian, model asuhan berbasis komunitas harus selalu didasarkan pada hasil riset yang kontekstual dan relevan ((Yadav & Banerjee, 2025).

Selain itu, hubungan antara riset keperawatan dan model komunitas juga terlihat dalam pengembangan intervensi inovatif berbasis bukti (*evidence-based practice*). Riset memberikan dasar dalam merancang berbagai strategi seperti home visit, edukasi kesehatan, telehealth, dan manajemen kasus (Bagaskara et al., 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan serta menurunkan beban layanan rumah sakit. Oleh karena itu, model asuhan berbasis komunitas tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian yang terus berkembang untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat (Dwiadila & Putra, 2021).

Aspek lain yang perlu ditulis adalah integrasi antara pendidikan, pelayanan, dan penelitian dalam keperawatan komunitas. Model seperti Nursing Center menekankan bahwa praktik keperawatan komunitas harus terintegrasi dengan kegiatan riset dan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan dan kompetensi perawat. Pendekatan ini melibatkan siklus mulai dari persiapan hingga evaluasi dan adopsi hasil penelitian dalam praktik nyata di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa riset bukan hanya kegiatan akademik, tetapi menjadi bagian dari praktik profesional keperawatan (Juniarti & Fuller, 2025).

Kemudian, perlu juga dijelaskan bahwa riset keperawatan mendukung evaluasi dan pengembangan model asuhan komunitas secara berkelanjutan. Melalui penelitian, efektivitas intervensi dapat diukur, kelemahan dapat diidentifikasi, dan model dapat disempurnakan sesuai kebutuhan populasi. Misalnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi komunitas dipengaruhi oleh durasi, intensitas, dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berbasis riset menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program kesehatan komunitas (Yadav & Banerjee, 2025).

Terakhir, aspek penting lainnya adalah peran riset dalam mendukung kebijakan kesehatan dan penguatan sistem pelayanan berbasis komunitas. Hasil penelitian keperawatan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan stakeholder kesehatan untuk mengembangkan

program yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara riset keperawatan dan model asuhan berbasis komunitas tidak hanya berdampak pada praktik klinis, tetapi juga pada pengembangan sistem kesehatan secara luas.

H. Isu dan Tantangan dalam Keperawatan Komunitas

1. Kesenjangan akses layanan kesehatan

Kesenjangan akses layanan kesehatan merupakan kondisi ketidakmerataan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Masalah ini masih menjadi isu utama dalam keperawatan komunitas, terutama pada kelompok rentan dan wilayah terpencil. Ketimpangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, serta kendala biaya dan akses transportasi, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat (Irfan Sazali Nasution et al., 2024).

Upaya mengatasi kesenjangan ini dapat dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi seperti telemedicine untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu, kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial sangat diperlukan, termasuk penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kolaborasi lintas sektor. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam advokasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata (Febriyanti et al., 2025).

2. Determinan Sosial Kesehatan

Determinan sosial kesehatan adalah faktor non-medis yang mempengaruhi status kesehatan individu dan masyarakat, seperti pendidikan, pendapatan, pekerjaan, lingkungan, dan kebijakan sosial. Faktor-faktor ini membentuk kondisi kehidupan seseorang sejak lahir hingga tua, sehingga sangat berperan dalam menentukan kesenjangan kesehatan di masyarakat. Determinan sosial sering kali menjadi akar masalah kesehatan karena berkaitan erat dengan ketidakadilan sosial dan ekonomi (Siswati et al., 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan intervensi yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pendidikan kesehatan, pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, serta penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan kesehatan. Perawat komunitas berperan dalam mengidentifikasi determinan sosial dan mengintegrasikannya

dalam perencanaan asuhan keperawatan berbasis komunitas (Komariah et al., 2025)

3. Perubahan Demografi dan Epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan pergeseran pola penduduk dan penyakit yang terjadi akibat peningkatan harapan hidup, urbanisasi, serta perubahan gaya hidup. Saat ini, terjadi peningkatan jumlah penduduk usia lanjut serta pergeseran penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi keperawatan komunitas karena membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih kompleks dan berkelanjutan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif, serta pengembangan program manajemen penyakit kronis di komunitas. Perawat komunitas dapat berperan dalam edukasi kesehatan, deteksi dini, serta pemberdayaan keluarga dalam merawat anggota yang sakit. Selain itu, inovasi dalam pelayanan seperti *home care* dan *community-based care* perlu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan populasi yang terus berubah (Mabunda et al., 2024).

4. Pengaruh Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan dampak yang kompleks terhadap kesehatan masyarakat. Di satu sisi, globalisasi mempermudah akses informasi dan layanan kesehatan, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyakit akibat gaya hidup tidak sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji dan kurang aktivitas fisik. Teknologi digital juga mempengaruhi pola interaksi sosial dan perilaku kesehatan masyarakat (Indawati et al., 2025).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pelayanan kesehatan, seperti digital health dan telehealth, serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Perawat komunitas perlu berperan sebagai edukator dalam penggunaan teknologi yang sehat dan bijak, serta mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi. Selain itu, kebijakan kesehatan global yang adaptif dan kolaboratif sangat penting dalam menghadapi dampak globalisasi terhadap kesehatan masyarakat (Sundoro et al., 2025).

I. Penutup

Bab Model Asuhan Berbasis Komunitas ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi kesehatan dalam memahami dan mengimplementasikan konsep asuhan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teori, pendekatan, serta praktik berbasis bukti terkini, buku ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keperawatan komunitas serta menjadi landasan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Referensi

- Airhihenbuwa, C. O., Iwelunmor, J., Munodawafa, D., & Ford, C. L. (2020). *Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID-19*. 1–8.
- Albarnawi, H. M., Alroqabi, S. M., Ogdi, W. Z., Jalal, A. A., Agdi, J. Z., Al-eid, H. S., Almutairy, A. K., Alanazi, M. K., & Albarnawi, H. M. (2024). *Community nursing interventions for chronic disease management*. 11(1), 1–5.
- Alcantara, L., Harper, G. W., & Keys, C. B. (2015). *Community Partnerships for Youth*. 47(4), 1–18. <https://doi.org/10.1177/0044118X12468141>.
- Bagaskara, D., Evalentin, F., Sinurat, D., Purba, G. R., Sinaga, J., & Rahmadani, T. W. (2025). *Kesehatan Digital Lewat Smartwatch Tren Atau Solusi ?* 04(01), 683–692.
- Balqis, U. M., Hariyanto, R. D., Mardiansyah, M. J., & Lestari, S. L. (2023). *Edukasi Homecare melalui Pendekatan Family Center Nursing (FCN) pada Perawat di Puskesmas Kabupaten Cianjur*. 2(1), 18–27.
- Bekele, T. H., Trijsburg, L., Brouwer, I. D., de Vries, J. H., Covic, N., Kennedy, G., Alemayehu, D., & Feskens, E. J. (2023). Dietary Recommendations for Ethiopians on the Basis of Priority Diet-Related Diseases and Causes of Death in Ethiopia: An Umbrella Review. *Advances in Nutrition*, 14(4), 895–913. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.05.005>
- Cassells, H. B. (n.d.). *Community Assessment*.
- Correia, T., Martins, M. M., Barroso, F., Pinho, L., & Valentim, O. (2025). *Patient and Family-Centered Care to Promote Inpatient Safety: An Exploration of Nursing Care and Management Processes*. 1–19.
- Costa, S., Adriana, M., & Henriques, P. (2020). *Community health and public health nursing: a systematic literature review*. 11, 80–96.
- Delanerolle, G., Jagadeesan, P., Li, G., Cavalini, H., Kazali, S., Zemokoho, A., Benfield, D., Shetty, A., Phiri, P., Inequalities, H., & Scholar, G. (2023). *A Systematic review and Meta- A Systematic Review and Meta-Epidemiology Study on Multimorbidity*. <https://doi.org/10.20944/preprints202308.1662.v1>
- Dwiadila, A., & Putra, M. (2021). *management to improve community*. 7(3), 141–150.
- Ewald, D. R., Michael, M., & Strack, R. W. (2023). SSM - Population Health The path to good health : Shifting the dialogue and promoting social ecological thinking. *SSM - Population Health*, 22(December 2022), 101378. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101378>
- Febriyanti, I., Azzura, A., Aulia, C., Fikri, M., & Ramdani, F. (2025). *Stratifikasi Sosial dan Akses Kesehatan : Analisis Kesenjangan dalam Sistem Pelayanan Publik*. 2(2), 62–82.
- Halimatussakdiah, H, Faisal, T. I., Nuraskin, C. A., Ahmad, A., & Alhuda, A. (2022). The Effect of Electronic Nursing Documentation (END) Implementation on Nursing

- Services Toward Patients' Satisfaction. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 237–246. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i1.842>
- Halimatussakdiah, Halimatussakdiah, Arifin, H., Haryati, W., Alhuda, A., & Asiah, N. (2020). Shariah Models-Based on Ethics Innovation in Nursing Documentation. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 130–139.
- Halimatussakdiah, Halimatussakdiah, & Faisal, T. I. (2022). Online education model on coffee addiction on the prevention of diabetes mellitus. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.30867/action.v7i2.958>
- Indawati, E., Kosasih, C. E., Haroen, H., & Anna, A. (2025). *Technology-integrated nursing interventions to improve adherence to tuberculosis medication: a scoping review*. 1–14.
- Irfan Sazali Nasution, Nurhazizah Br Said, Mutiara Salsabila, Ayu Maulidia, Zahwa Sinta Aulia, & Suci ramadhani. (2024). Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi. *Vitamin : Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(3), 195–206. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i3.509>
- Ismiyah, N., Asy-syifa, A. M., & Mangkurat, L. (2024). *Telemedicine dan Kesehatan: Memahami Dampak Teknologi Kedokteran di Era Digital dalam Konteks Ajaran Islam*. 4.
- Jena, A., Bist, L., Agarwal, S., Bhuyan, D., Abraham, G., & Borah, K. (2025). *Policy Innovation in Healthcare: Exploring the Adoption and Implementation of Telemedicine*. 136–144.
- Johannes, C., & Roman, N. V. (2025). *Applying the Social Ecological Model to Explore Physical Activity Levels and Psychosocial Factors among Undergraduate University Students: A Narrative Literature Review Abstract*: 1–15. <https://doi.org/10.2174/0118749445392277250428114135>
- Juniarti, N., & Fuller, J. (2025). *Strategies to enhance the integration of health services , education , research and community engagement within the Nursing Center Model*. 13(2), 115–119.
- Kim, J., Jang, J., Kim, B., & Lee, K. H. (2022). Effect of the PRECEDE - PROCEED model on health programs : a systematic review and meta - analysis. *Systematic Reviews*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02092-2>
- Komariah, N., Lestari, D., & Amanda, A. (2025). *Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kelurahan Tugu Kecil RT 003 RW 004 Kota Prabumulih Tahun 2024*. 2(11), 5043–5047.
- Kruse, C. S., Karem, P., Shifflett, K., Vegi, L., Ravi, K., & Brooks, M. (2018). *Evaluating barriers to adopting telemedicine worldwide: A systematic review*. 24(1), 4–12. <https://doi.org/10.1177/1357633X16674087>
- Lee, B. C., Bendixsen, C., Liebman, A. K., Gallagher, S. S., Lee, B. C., Bendixsen, C., Liebman, A. K., & Gallagher, S. S. (2017). Using the Socio-Ecological Model to

- Frame Agricultural Safety and Health Interventions. *Journal of Agromedicine*, 22(4), 298–303. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2017.1356780>
- Lee, S. (2026). *Understanding and Challenges of Community Nursing Practicums After COVID-19: A Qualitative Study*. 1–9. <https://doi.org/10.1155/nrp/6657747>
- Mabunda, N. F., Masondo, I. G., Beer, A. G. M., & Health, S. M. (2024). *Nurses' understanding of quality documentation: A qualitative study in a Mental Health Institution*. 1–8.
- Macdonald, A. H., Martin, M., Clark, E., Lunn, A. D., Gkiouleka, A., Harasgama, S., Lamb, D., & Ford, J. (2024). *What works: Community engagement and empowerment to address health inequalities*. November, 1–12.
- Macdonald, H., Martin, M., Ghanchi, A., Clark, E., Dehn, A., Gkiouleka, A., Harasgama, S., Lamb, D., & Ford, J. (2026). Public Health in Practice Community engagement and empowerment to address health inequalities: A rapid evidence review. *Public Health in Practice*, 11(March), 100773. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2026.100773>
- Macinko, J. (2005). *Contribution of Primary Care to Health Systems and Health*. 83(3), 457–502.
- Malinda, R. (2024). *Implementasi Model PRECEDE-PROCEED dalam Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)*. 2007, 0–5.
- Mcneil, D. W. (2024). *Behavioral and Cognitive-Behavioral Theories in Oral Health Research: Current State and Future Directions*. 1–22. <https://doi.org/10.1111/cdoe.12840>.Behavioral
- Mm, K., Hidding, C. Y., Buist, P., Sanavro, S. M., Lugt, D. Van Der, Stoffelen, J., Blanker, M. H., Worp, H. Van Der, Schers, H. J., Girolidi, E., WI, J., & Jansen, J. (2026). Patient Education and Counseling Exploring patient involvement and influencing factors in digital interdisciplinary consultation. *Patient Education and Counseling*, 142(September 2025), 109360. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2025.109360>
- Montolalu, I. A. (2024). *The Role of Telemedicine in Expanding Healthcare Access: A Post-Pandemic Evaluation of Virtual Care Models*. 2(1), 59–67.
- Park, A., & York, U. N. (2014). Profile David Napier: cultivating the role of culture in health. *The Lancet*, 384(9954), 1568. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61937-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61937-1)
- Rajan, D., Rouleau, K., Winkelmann, J., Jakab, M., Kringos, D., & Khalid, F. (n.d.). *Implementing the primary health care approach A primer*.
- Reports, C. C. (2025). *The Role of Community Health Nursing in Improving Public Health: A Global and Local Perspective*. 9(2), 1–3. <https://doi.org/10.59657/2837-2565.brs.25.224>
- Ridhani, M. Y. (2023). *Asset based community development sebagai penunjang*

pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala Asset based community development as a tools to improve rural development. 18.
<https://doi.org/10.20961/region.v18i1.56574>

Senga, M., & Kouhestani, M. (2020). *Risk communication and community engagement as an emerging pillar of health emergency management in Iran : Achievements and the way forward. 2020*(March).

Siswati, T., Muchlasin, A., Kristyanto, R. Y., Citra, D., & Gunawan, D. (2024). *Health Dynamics Determinants and Model for Estimating the Prevalence of Stunting Toddlers in Sleman Regency Health Dynamics. 1*(6), 191–198.

Sundoro, F. M., Wulan, A., Saputri, A., & Pradista, L. (2025). *Telemedicine dan Transformasi Digital Kesehatan Global 1999 – 2025. 23*(4), 634–650.
<https://doi.org/10.26623/slsi.v23i4.13058>

Weidmann, A. (n.d.). *Application of behavioral theories, models, and frameworks in pharmacy practice research.*

Yadav, R., & Banerjee, D. (2025). *Community-based nursing strategies for optimizing public health outcomes : a systematic review and meta-analysis.*

Yusuf, A., Purba, J. M., Putri, D. E., & Aditya, R. S. (2024). *Family-Centered Care Experiences in Elderly with Chronic Diseases in Communities : Qualitative Study of Patients , Families , Nurses , and Volunteers. 8,* 338–350.
<https://doi.org/10.1089/heq.2024.0009>

Zeydani, A., Shoorideh, F. A., Hosseini, M., & Anboohi, S. Z. (2023). Community-based nursing : a concept analysis with Walker and Avant ' s approach. *BMC Medical Education*, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04749-5>

BAB 5

VALIDASI DAN UJI MODEL ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS RISET

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan global saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya beban penyakit kronis, perubahan demografi, serta tuntutan terhadap mutu dan keselamatan pasien. Dalam konteks tersebut, perawat memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan terbesar yang berada di garis depan pelayanan. Secara global, jumlah tenaga keperawatan mencapai hampir 29,8 juta pada tahun 2023, namun distribusinya masih sangat timpang antar wilayah (World Health Organization, 2025)

Meskipun jumlah tenaga keperawatan mengalami peningkatan, dunia masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan adanya kekurangan sekitar 4,5 juta perawat secara global, dan kebutuhan ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 7 juta tenaga kesehatan tambahan pada tahun 2030 (Boniol et al., 2022)

Kesenjangan ini semakin nyata di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan salah satu wilayah dengan beban kekurangan tenaga keperawatan tertinggi di dunia. WHO melaporkan bahwa kawasan Asia Tenggara menyumbang sekitar 1,9 juta dari total kebutuhan tambahan tenaga kesehatan global, yang menunjukkan adanya ketimpangan serius antara kebutuhan pelayanan dan ketersediaan tenaga profesional (Darzi & Evans, 2016; Rao & Schmidt, 2023; Zapata et al., 2021)

Selain keterbatasan jumlah tenaga, tantangan lain yang dihadapi adalah kualitas pelayanan dan beban kerja tenaga keperawatan. Studi menunjukkan bahwa tingkat *turnover* perawat di Asia mencapai sekitar 19%, yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, dan sebagian besar disebabkan oleh tekanan kerja, ketidakpuasan kerja, serta keterbatasan sistem pelayanan (Ren et al., 2024)

Di Indonesia, kondisi ini menunjukkan fenomena yang lebih kompleks. Meskipun jumlah tenaga kesehatan cukup besar, distribusi dan pemanfaatannya masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa rasio tenaga kesehatan di Indonesia berada pada angka 3,84 per 1.000 penduduk, yang masih berada di

bawah standar minimal WHO sebesar 4,45 untuk mencapai cakupan kesehatan universal (*universal health coverage*) (Muharram et al., 2025)

Selain itu, perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar di Indonesia, dengan jumlah lebih dari 500 ribu tenaga, namun masih menghadapi permasalahan distribusi yang tidak merata antar wilayah, khususnya di daerah terpencil dan perdesaan (Gunawan J, 2020; Hikmah et al., 2016)

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tingginya beban kerja dan kejenuhan (*burnout*) pada perawat. Secara global, meta-analisis: prevalensi kelelahan emosional ~33%, depersonalisasi 25%, dan rendah pencapaian pribadi 33% (Getie et al., 2025). Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 30% tenaga keperawatan mengalami burnout, yang berdampak pada kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan kerja (Antonio et al., 2024; Juanamasta et al., 2024; Lamuri et al., 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Diperlukan pendekatan sistematis yang mampu mengoptimalkan praktik keperawatan melalui integrasi antara teori, penelitian, dan praktik klinis. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *evidence-based nursing practice* (EBNP), yang menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan klinis (Birhanu et al., 2022; Naz & Ganaie, 2023; Olabode, 2024; Papierkowska et al., 2025)

Dalam implementasinya, EBNP membutuhkan suatu kerangka kerja yang sistematis dalam bentuk model asuhan keperawatan berbasis riset. Model ini berfungsi sebagai panduan dalam memberikan asuhan keperawatan yang terstruktur, terstandar, dan berbasis bukti ilmiah (Chays-amania et al., 2025; Duff et al., 2020; Dusin et al., 2023; Schaffer et al., 2012). Model yang baik mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik serta meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara signifikan.

Namun demikian, pengembangan model asuhan keperawatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Model yang dikembangkan harus melalui proses validasi dan uji model untuk memastikan bahwa model tersebut memiliki dasar teoritis yang kuat, relevan dengan praktik klinis, serta efektif dalam meningkatkan outcome pasien (Bender et al., 2017; Bender & Micki, 2025; Prentice, et al., 2021; Vergara et al., 2021).

Validasi model bertujuan untuk menilai kesesuaian isi, struktur, dan hubungan antar komponen dalam model berdasarkan penilaian para ahli. Sementara itu, uji model bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas model melalui implementasi di lapangan dengan pendekatan penelitian kuantitatif maupun mixed-method (Ataiyero et al., 2025; Dehennin et al., 2023; Palinkas et al., 2019).

Kedua proses ini merupakan bagian penting dalam penelitian pengembangan (*research and development*) di bidang keperawatan.

Tanpa melalui proses validasi dan uji model yang sistematis, model asuhan keperawatan berpotensi tidak aplikatif, tidak efektif, bahkan dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan model keperawatan yang valid dan teruji menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta profesionalisme perawat.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep model, metode validasi, serta pengujian model asuhan keperawatan berbasis riset sebagai landasan dalam pengembangan praktik keperawatan yang berkualitas.

B. Kerangka Teori Dalam Pengembangan Model Asuhan Keperawatan

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konsep dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset. Dalam konteks keperawatan, kerangka teori berfungsi sebagai dasar dalam menyusun, mengembangkan, serta mengevaluasi suatu model agar memiliki validitas ilmiah yang kuat dan dapat diaplikasikan secara sistematis dalam praktik keperawatan.

Penggunaan kerangka teori dalam pengembangan model keperawatan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat dasar konseptual, tetapi juga untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan memiliki keterkaitan dengan teori-teori keperawatan yang telah berkembang. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi antara teori, penelitian, dan praktik keperawatan.

1. Teori Keperawatan sebagai Dasar Pengembangan Model

Pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset tidak terlepas dari kontribusi berbagai teori keperawatan yang telah berkembang. Beberapa teori yang sering digunakan sebagai landasan dalam pengembangan model keperawatan antara lain teori self-care, teori adaptasi, dan teori caring.

Teori Self-Care Deficit yang dikemukakan oleh Orem menekankan pentingnya kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri secara mandiri. Dalam teori ini, perawat memiliki peran untuk membantu individu dalam memenuhi kebutuhan self-care yang tidak dapat dilakukan secara mandiri, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasien (Orem, 2001). Teori ini menjadi dasar dalam merancang intervensi keperawatan yang berfokus pada peningkatan kemandirian pasien.

Selanjutnya, teori Adaptasi dari Roy memandang individu sebagai sistem adaptif yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, perawat berperan dalam memfasilitasi respon adaptif pasien terhadap perubahan kondisi kesehatan melalui intervensi yang tepat dan berkelanjutan (Roy, 2009). Pendekatan ini menekankan pentingnya kemampuan individu dalam beradaptasi terhadap stresor internal maupun eksternal.

Selain itu, teori Caring yang dikembangkan oleh Watson menekankan bahwa praktik keperawatan tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga pada hubungan interpersonal yang humanistik antara perawat dan pasien. Caring merupakan inti dari keperawatan yang mencakup dimensi emosional, spiritual, dan sosial dalam pemberian asuhan keperawatan (Watson, 2008).

Ketiga teori tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat dalam pengembangan model asuhan keperawatan yang bersifat holistik, berpusat pada pasien, serta memperhatikan keseimbangan antara aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

2. Konsep Evidence-Based Practice dalam Keperawatan

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan pendekatan dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). Pendekatan ini menjadi standar dalam praktik keperawatan modern karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

Penerapan EBP dalam praktik keperawatan memungkinkan perawat untuk menggunakan hasil penelitian terbaru sebagai dasar dalam menentukan intervensi yang paling efektif. Dengan demikian, praktik keperawatan tidak hanya didasarkan pada pengalaman semata, tetapi juga pada bukti ilmiah yang telah teruji (Polit & Beck, 2021).

Dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset, prinsip EBP berperan penting dalam memastikan bahwa setiap komponen model memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penerapan EBP mencakup pemilihan intervensi yang efektif, penggunaan hasil penelitian terkini, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi outcome klinis pasien.

3. Sintesis Kerangka Teori

Berdasarkan integrasi berbagai teori keperawatan dan konsep Evidence-Based Practice, kerangka teori dalam pengembangan model asuhan

keperawatan berbasis riset menekankan pendekatan yang komprehensif dan sistematis.

Asuhan keperawatan harus berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan kesehatan. Intervensi keperawatan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid serta mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara holistik. Selain itu, proses pengembangan model perlu dilakukan secara sistematis agar menghasilkan model yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik (Fawcett, 2017)

Outcome yang diharapkan dari penerapan model ini adalah peningkatan status kesehatan pasien secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, kerangka teori ini menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan model asuhan keperawatan yang efektif, aplikatif, dan berbasis riset.

C. Konsep Model Asuhan Keperawatan

Model asuhan keperawatan merupakan representasi konseptual yang menggambarkan hubungan sistematis antara berbagai komponen dalam praktik keperawatan. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu perawat dalam memahami fenomena keperawatan, mengarahkan proses pengambilan keputusan klinis, serta memastikan bahwa asuhan yang diberikan bersifat terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada pasien (Clarke & Davis, 2025; Connor et al., 2023; Dusi et al., 2023; Mccance & McCormack, 2025; Muntlin et al., 2023)

Secara konseptual, model keperawatan dibangun berdasarkan metaparadigma keperawatan yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Keempat komponen ini menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik keperawatan. Manusia dipandang sebagai individu yang holistik dengan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Lingkungan mencakup seluruh faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi kesehatan individu, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Kesehatan tidak hanya diartikan sebagai kondisi bebas dari penyakit, tetapi sebagai keadaan sejahtera secara menyeluruh. (Carole & Wagoro, 2020; Deliktas et al., 2019; Muntlin et al., 2023). Sementara itu, keperawatan merupakan tindakan profesional yang bertujuan untuk membantu individu mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Dalam perkembangan ilmu keperawatan modern, model tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai alat implementasi praktik berbasis bukti. Integrasi antara teori, hasil penelitian, dan praktik klinis menjadi landasan utama dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset

(Chesak et al., 2022; Meijel, 2004; Noprianty et al., 2022; Speroni, 2020). Model yang berbasis riset ini memungkinkan perawat untuk menerapkan intervensi yang telah terbukti efektif secara ilmiah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset umumnya dilakukan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, kajian literatur, pengembangan kerangka konseptual, penyusunan model awal, serta evaluasi model melalui proses validasi dan uji empiris (Rojas- et al., 2023; Samuelsson et al., 2025). Proses ini menunjukkan bahwa model keperawatan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan praktik dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks ini, validasi model menjadi tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan memiliki kualitas ilmiah yang memadai. Validasi model merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu model memiliki kesesuaian secara teoritis, relevansi dengan praktik, serta kelayakan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pemberian asuhan keperawatan (Barbosa, 2024; Hons, 2022; Huynh et al., 2021).

Validasi model mencakup beberapa aspek utama. Pertama, validitas isi (*content validity*), yaitu penilaian terhadap kesesuaian komponen model dengan konsep teoritis dan praktik klinis. Validitas ini biasanya dilakukan melalui penilaian oleh panel ahli yang memiliki kompetensi di bidang terkait. Kedua, validitas konstruk (*construct validity*), yang menilai hubungan antar variabel dalam model serta konsistensi struktur model. Ketiga, validitas tampilan (*face validity*), yang menilai sejauh mana model dapat dipahami dan digunakan oleh praktisi keperawatan (Almanasreh et al., 2018; Hosseini et al., 2025; Saiful & Yusoff, 2019; Vieira et al., 2020). Selain ketiga aspek tersebut, validasi model juga berkaitan dengan tingkat kejelasan, konsistensi, dan kemudahan implementasi model dalam praktik klinis (Salbego et al., 2024; Williams et al., 2023). Model yang baik tidak hanya valid secara teoritis, tetapi juga mudah dipahami dan diaplikasikan oleh perawat di lapangan.

Dalam praktik penelitian keperawatan, validasi model umumnya dilakukan melalui metode *expert judgment*, teknik Delphi (António et al., 2025; Cocchieri et al., 2021; Feng et al., 2025), maupun pendekatan statistik seperti *confirmatory factor analysis* (CFA) dan *structural equation modeling* (SEM) (Alavi, et al., 2020; Baharum et al., 2023; Pahlevan, 2018). Metode-metode tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap model yang dikembangkan.

Lebih lanjut, validasi model memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik keperawatan. Banyak hasil penelitian yang tidak dapat diimplementasikan secara langsung dalam praktik karena tidak memiliki kerangka kerja yang jelas (Kristensen et al., 2016; Poiroux et al., 2024; Singh et al., 2024). Dengan adanya model yang telah divalidasi, hasil penelitian dapat ditransformasikan menjadi intervensi yang aplikatif dan mudah diterapkan dalam pelayanan keperawatan.

Di sisi lain, validasi model juga berkontribusi dalam meningkatkan kredibilitas ilmiah suatu penelitian. Model yang telah melalui proses validasi akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi (Belfrage et al., 2024; Caro et al., 2014; Erdemir et al., 2020; Viceconti et al., 2023). Sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis maupun pengembangan kebijakan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, validasi model asuhan keperawatan berbasis riset menjadi sangat relevan. Hal ini mengingat adanya variasi kondisi sosial, budaya, serta sistem pelayanan kesehatan yang mempengaruhi praktik keperawatan (Indrawati, 2023; Setiawati et al., 2021; Zendrato & Hariyati, 2017). Model yang dikembangkan harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik lokal agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, model dan validasi merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa praktik keperawatan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memiliki dasar empiris yang kuat dan aplikatif. Untuk memastikan model yang dikembangkan memiliki kualitas ilmiah yang memadai, diperlukan metode validasi yang sistematis sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

D. Pentingnya Validasi Model Keperawatan Berbasis Riset

Validasi model merupakan tahapan krusial dalam penelitian pengembangan (*research and development*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan memiliki kualitas ilmiah yang memadai, baik dari segi isi, struktur, maupun aplikabilitas dalam praktik keperawatan (Bender et al., 2017; Sastre-fullana et al., 2017; Vieira et al., 2020). Proses validasi tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi awal terhadap model, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan ketepatan, kejelasan, dan relevansi model sebelum dilakukan uji empiris di lapangan (Polit & Beck, 2021).

Dalam konteks metodologi penelitian, validasi model dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur, yang melibatkan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (Cristine et al., 2023; Salbego et al., 2024). Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kualitas model, baik dari perspektif subjektif (penilaian ahli) maupun objektif (analisis statistik).

1. Desain Validasi Model

Desain validasi model umumnya menggunakan pendekatan *descriptive evaluative study*, yang bertujuan untuk menilai kelayakan model berdasarkan kriteria tertentu. Dalam beberapa penelitian, desain ini juga dikombinasikan dengan pendekatan *mixed methods* untuk memperkuat hasil validasi.

Validasi dilakukan sebelum tahap uji coba lapangan (*field testing*), sehingga hasil validasi menjadi dasar dalam melakukan revisi dan penyempurnaan model. Dengan demikian, validasi berperan sebagai tahap filtrasi awal untuk memastikan bahwa model yang diuji telah memenuhi standar ilmiah minimal.

2. Penentuan Panel Ahli (Expert Panel)

Pemilihan panel ahli merupakan komponen penting dalam validasi model. Panel ahli harus memiliki kompetensi yang relevan dengan topik penelitian, baik dari aspek akademik maupun klinis.

Kriteria panel ahli meliputi:

- a. Memiliki pendidikan minimal magister di bidang keperawatan atau kesehatan
- b. Memiliki pengalaman klinis atau penelitian minimal 3–5 tahun
- c. Memahami konsep model atau topik yang diteliti

Jumlah panel ahli umumnya berkisar antara 3 hingga 10 orang. Jumlah ini dianggap cukup untuk menghasilkan penilaian yang reliabel tanpa menimbulkan kompleksitas analisis yang berlebihan (Polit & Beck, 2021)

3. Pengembangan Instrumen Validasi

Instrumen validasi digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian model berdasarkan penilaian para ahli. Instrumen ini biasanya berbentuk kuesioner dengan skala Likert, misalnya skala 1–4, dengan kategori:

- a. 1=tidak relevan
- b. 2=kurang relevan
- c. 3=Relevan
- d. 4=Sangat Relevan

Instrumen validasi mencakup beberapa aspek penilaian, antara lain:

- a. Kejelasan konsep dalam model
- b. Kesesuaian model dengan teori keperawatan
- c. Relevansi model dengan praktik klinis

- d. Keterpahaman alur model
- e. Kelayakan implementasi

Instrumen yang baik harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai agar hasil penilaian dapat dipercaya (Devellis, 2017).

4. Analisis Content Validity Index (CVI)

Content Validity Index (CVI) merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menganalisis hasil validasi oleh panel ahli. CVI dihitung untuk setiap item (I-CVI) maupun secara keseluruhan (S-CVI).

a. Item-Level CVI (I-CVI)

I-CVI dihitung dengan rumus:

$I-CVI = (\text{jumlah ahli yang memberikan skor 3 atau 4}) / (\text{jumlah seluruh ahli})$

Nilai I-CVI berkisar antara 0 hingga 1. Interpretasi nilai

- 1) $\geq 0,78 \rightarrow$ valid
- 2) $0,70-0,77 \rightarrow$ perlu revisi
- 3) $< 0,70 \rightarrow$ tidak valid

b. Scale-Level CVI (S-CVI)

S-CVI merupakan rata-rata dari seluruh nilai I-CVI dan digunakan untuk menilai validitas keseluruhan model.

Nilai S-CVI $\geq 0,90$ menunjukkan bahwa model memiliki validitas yang sangat baik (Polit & Beck, 2021).

Penilaian validitas isi model dilakukan menggunakan Content Validity Index (CVI) berdasarkan evaluasi panel ahli, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1: Contoh Perhitungan Content Validity Indeks (CVI)

No	Komponen Model	Ahli 1	Ahli 2	Ahli 3	Ahli 4	Ahli 5	Jumlah Relevan	I-CVI
1	Pengkajian	4	4	3	4	4	5	1.00
2	Diagnosis Keperawatan	3	4	3	4	4	5	1.00
3	Perencanaan Intervensi	4	3	3	4	3	5	1.00
4	Implementasi	3	3	2	3	3	4	0.80
5	Evaluasi	4	3	3	3	4	5	1.00
6	Edukasi Pasien	3	3	3	2	3	4	0.80
7	Monitoring & Follow-up	4	4	3	3	4	5	1.00

Keterangan

- 1) Skor 1 = Tidak Relevan
- 2) Skor 2 = Kurang Relevan
- 3) Skor 3 = Relevan
- 4) Skor 4 = Sangat Relevan

Kriteria Validitas

- 1) $I-CVI \geq 0,78$ Valid
- 2) $I-CVI < 0,78 \rightarrow$ perlu revisi (Polit & Beck, 2021)
- 3) $I-CVI$ (Item Content Validity Index) = $\frac{\text{jumlah ahli yang menilai relevan}}{\text{jumlah ahli}}$

Berdasarkan Tabel 5.1, sebagian besar komponen model memiliki nilai $I-CVI \geq 0,78$ yang menunjukkan bahwa model asuhan keperawatan yang dikembangkan memiliki validitas isi yang baik. Beberapa komponen seperti implementasi dan edukasi pasien menunjukkan nilai $I-CVI$ sebesar 0,80, yang masih berada dalam kategori valid, namun memerlukan sedikit perbaikan berdasarkan masukan dari panel ahli. Secara keseluruhan, model dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap uji model di lapangan. Nilai Scale Content Validity Index ($S-CVI/Ave$) pada model ini sebesar 0,94 yang menunjukkan bahwa model memiliki validitas isi yang sangat baik secara keseluruhan

5. Analisis Content Validity Ratio (CVR)

Selain CVI, analisis validitas juga dapat dilakukan menggunakan Content Validity Ratio (CVR) yang dikembangkan oleh Lawshe (1975). CVR digunakan untuk menilai apakah suatu item dianggap esensial oleh panel ahli.

Rumus CVR:

$$CVR = (N_e - N/2) / (N/2)$$

Keterangan:

- N_e = jumlah ahli yang menyatakan item esensial
- N = jumlah total ahli

Nilai CVR berkisar antara -1 hingga +1. Nilai positif menunjukkan bahwa item dianggap penting oleh mayoritas ahli

6. Teknik Delphi dalam Validasi Model

Teknik Delphi merupakan metode validasi yang dilakukan melalui beberapa putaran (iteratif) untuk mencapai konsensus antar ahli. Pada setiap putaran, hasil penilaian dirangkum dan dikirim kembali kepada panel ahli untuk ditinjau ulang.

Keunggulan metode Delphi:

- a. Mengurangi bias individu
- b. Meningkatkan objektivitas
- c. Menghasilkan konsensus yang kuat
- d. Metode ini sangat cocok digunakan dalam pengembangan model keperawatan yang kompleks dan multidimensional (Hsu & Sandford, 2007)

7. Validitas Konstruk melalui Analisis Statistik

Untuk model yang memiliki struktur variabel yang kompleks, validasi konstruk dapat dilakukan menggunakan pendekatan statistik, seperti:

a. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Digunakan untuk menguji apakah struktur model sesuai dengan data empiris

b. Structural Equation Modeling (SEM)

Digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam model. Beberapa indikator kelayakan model dalam SEM meliputi:

- 1) Chi-square (χ^2)
- 2) RMSEA ($< 0,08$)
- 3) CFI ($> 0,90$)
- 4) TLI ($> 0,90$)

Pendekatan ini memberikan validasi yang lebih kuat karena didasarkan pada analisis kuantitatif (Hair et al., 2019)

8. Interpretasi dan Revisi Model

Hasil validasi harus diinterpretasikan secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai CVI, CVR, serta masukan kualitatif dari panel ahli. Item atau komponen model yang tidak memenuhi kriteria validitas perlu direvisi atau dihapus. Proses revisi ini merupakan bagian penting dalam siklus pengembangan model, yang bertujuan untuk menghasilkan model yang lebih optimal sebelum dilakukan uji lapangan.

9. Kriteria Model yang Valid

Model asuhan keperawatan dapat dikatakan valid apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki nilai CVI yang tinggi ($\geq 0,78$)
- b. Memiliki konsistensi struktur yang baik
- c. Relevan dengan praktik klinis
- d. Mudah dipahami dan diimplementasikan
- e. Didukung oleh teori dan bukti ilmiah

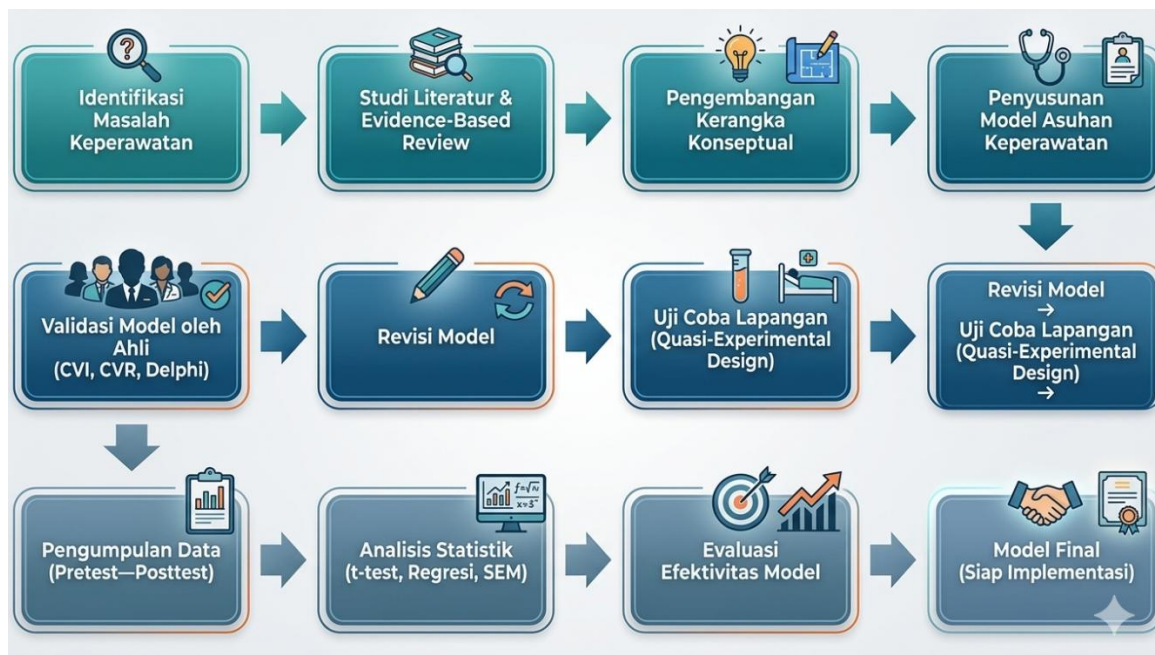
Model yang memenuhi kriteria tersebut memiliki peluang besar untuk berhasil dalam tahap uji model dan implementasi klinis.

E. Pengujian Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset

Pengujian model (*model testing*) merupakan tahap lanjutan setelah model asuhan keperawatan dinyatakan valid secara konseptual. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas model dalam meningkatkan outcome klinis melalui implementasi langsung di lapangan. Uji model menjadi komponen penting dalam penelitian pengembangan karena memberikan bukti empiris mengenai keberhasilan model dalam praktik nyata (Polit & Beck, 2021)

Berbeda dengan validasi yang berfokus pada kesesuaian teoritis dan struktur model, uji model berfokus pada aspek implementasi dan dampak model terhadap variabel hasil (*outcome variables*). Dengan demikian, uji model tidak hanya menjawab pertanyaan “apakah model ini valid?”, tetapi juga “apakah model ini efektif?”.

Untuk memperjelas alur pengembangan dan pengujian model asuhan keperawatan berbasis riset, proses tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram berikut



Gambar 5.1: Alur Validasi Dan Uji Model Keperawatan Berbasis Riset

Gambar 5.1 menunjukkan alur sistematis dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset yang dimulai dari identifikasi masalah hingga diperoleh model final yang siap diimplementasikan. Proses ini mencakup tahapan validasi oleh ahli menggunakan metode Content Validity Index (CVI), Content Validity Ratio

(CVR), dan teknik Delphi, serta uji model melalui pendekatan quasi-experimental. Analisis statistik digunakan untuk mengevaluasi efektivitas model dalam meningkatkan outcome pasien, sehingga model yang dihasilkan tidak hanya valid secara teoritis tetapi juga terbukti efektif secara empiris.

1. Desain Penelitian Uji Model

Desain penelitian yang umum digunakan dalam uji model adalah desain kuasi-eksperimental (*quasi-experimental design*), terutama dalam setting pelayanan kesehatan yang sulit menerapkan randomisasi penuh. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dalam kondisi yang relatif realistis (Gray & Grove, 2017).

Salah satu desain yang sering digunakan adalah:

- a. Kelompok intervensi diberikan perlakuan menggunakan model
- b. Kelompok kontrol diberikan perawatan standar
- c. Pengukuran dilakukan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) intervensi

Desain ini memungkinkan peneliti untuk menilai perubahan yang terjadi akibat implementasi model secara lebih objektif.

2. Populasi Dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel dalam uji model harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik model yang dikembangkan. Populasi dapat berupa pasien, keluarga, atau kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan fokus model.

Teknik sampling yang sering digunakan antara lain:

- a. *Purposive sampling*
- b. *Consecutive sampling*
- c. *Cluster sampling*

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan statistik, seperti uji kekuatan (*power analysis*), untuk memastikan bahwa penelitian memiliki kekuatan yang cukup dalam mendeteksi perbedaan yang signifikan (Polit & Beck, 2021).

3. Variabel Penelitian dalam Uji Model

Dalam uji model, variabel penelitian umumnya terdiri dari:

- a. Variabel independent
Model asuhan keperawatan berbasis riset
- b. Variabel dependen (outcome)
 - 1) Kepatuhan pasien
 - 2) Kualitas hidup

- 3) Status kesehatan
- 4) Penurunan komplikasi
- c. Variabel kontrol
 - 1) Usia
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Lama penyakit
 - 4) Faktor sosial ekonomi

Penentuan variabel yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil uji model dapat diinterpretasikan secara valid.

4. Prosedur Implementasi Model

Implementasi model dilakukan secara sistematis sesuai dengan komponen yang telah dikembangkan. Tahapan implementasi meliputi:

- a. Pelatihan perawat terkait penggunaan model
- b. Sosialisasi model kepada pasien atau responden
- c. Penerapan model dalam proses asuhan keperawatan
- d. Monitoring pelaksanaan model
- e. Evaluasi hasil implementasi

Konsistensi dalam implementasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan uji model.

5. Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam uji model harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Instrumen dapat berupa:

- a. Kuesioner
- b. Lembar observasi
- c. Skala penilaian klinis

Contoh instrumen:

- 1) Skala kepatuhan pasien
- 2) Skala kualitas hidup
- 3) Checklist asuhan keperawatan
- 4) Checklist asuhan Keperawatan

Instrumen yang digunakan sebaiknya telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelumnya untuk memastikan keakuratan data (Lamm et al., 2020)

6. Analisis dan Uji Model

Analisis data dilakukan untuk menilai efektivitas model. Metode analisis yang digunakan bergantung pada jenis data dan desain penelitian.

Beberapa analisis yang umum digunakan antara lain:

a. Paired t-test

Untuk membandingkan nilai pretest dan posttest dalam satu kelompok

b. Independent t-test

Untuk membandingkan kelompok intervensi dan kontrol

c. ANOVA

Untuk membandingkan lebih dari dua kelompok

d. Regresi linear/logistic

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap outcome

e. Structural Equation Modeling (SEM)

Untuk menguji hubungan kompleks antar variabel (Hair et al., 2019)

Nilai $p\text{-value} < 0,05$ menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik.

7. Interpretasi Hasil Uji Model

Interpretasi hasil tidak hanya berdasarkan signifikansi statistik, tetapi juga harus mempertimbangkan makna klinis (*clinical significance*). Suatu model dapat dikatakan efektif apabila:

a. Terdapat peningkatan signifikan pada outcome

b. Perubahan memiliki dampak klinis yang nyata

c. Model dapat diterapkan secara konsisten

d. Selain itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil, seperti kondisi lingkungan, kepatuhan responden, dan kualitas implementasi model

8. Contoh Aplikasi Model

Sebagai ilustrasi, pengembangan model deteksi dini risiko *diabetic foot ulcer* (DFU) berbasis aplikasi mobile menunjukkan efektivitas yang signifikan.

Dalam penelitian dengan desain quasi-experimental:

a. Kelompok intervensi menggunakan aplikasi

b. Kelompok kontrol menggunakan metode konvensional

Hasil Menunjukkan

a. Peningkatan kepatuhan perawatan kaki

b. Penurunan risiko DFU secara signifikan ($p < 0,05$)

Contoh lain adalah model kepatuhan pembatasan cairan pada pasien hemodialisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor kepatuhan pasien setelah diberikan intervensi berbasis model, serta hubungan signifikan antara lama menjalani hemodialisis dengan tingkat kepatuhan

9. Kriteria Keberhasilan Model

Model dapat dikatakan berhasil apabila:

- a. Terjadi peningkatan signifikan pada outcome
- b. Model dapat diterapkan secara praktis
- c. Tidak menimbulkan efek negatif
- d. Dapat direplikasi pada setting lain

Model dinyatakan efektif apabila mampu meningkatkan outcome pasien secara signifikan serta memberikan dampak klinis yang nyata dalam praktik keperawatan

F. Implikasi Model Keperawatan Dalam Pelayanan Kesehatan

Model asuhan keperawatan yang telah melalui proses validasi dan pengujian memiliki berbagai implikasi penting dalam praktik keperawatan. Salah satu implikasi utama adalah peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.

Model yang jelas dan sistematis dapat membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang lebih terarah dan efektif. Selain itu, model keperawatan juga dapat meningkatkan profesionalisme perawat dalam praktik klinik karena perawat memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan proses keperawatan.

Dalam konteks pendidikan keperawatan, model yang telah divalidasi juga dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa keperawatan untuk memahami proses pemberian asuhan keperawatan secara lebih komprehensif (Alligood, 2018)

Selain itu, model keperawatan juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan serta penelitian keperawatan di masa depan.

G. Penutup

Validasi dan uji model merupakan tahapan penting dalam pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan memiliki kesesuaian secara teoritis, relevansi dengan praktik klinis, serta kelayakan untuk diimplementasikan. Melalui proses validasi, model dapat disempurnakan berdasarkan masukan para ahli sehingga memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Selanjutnya, uji model dilakukan untuk menilai efektivitas model dalam praktik nyata. Pengujian ini memberikan bukti empiris mengenai kemampuan model dalam meningkatkan outcome pasien, baik dari aspek klinis maupun perilaku kesehatan. Dengan demikian, model yang telah melalui tahap uji tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan teruji secara ilmiah.

Integrasi antara proses validasi dan uji model menjadi kunci dalam menghasilkan model asuhan keperawatan yang berkualitas. Model yang valid dan

efektif dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik keperawatan berbasis bukti, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguasaan konsep dan metode validasi serta uji model menjadi kompetensi penting bagi perawat, dosen, dan peneliti. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan pengembangan model keperawatan di masa depan dapat semakin inovatif, relevan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, pengembangan model asuhan keperawatan berbasis riset diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan praktik keperawatan yang profesional, berbasis bukti, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Referensi

- Alavi, M., Visentin, D. C., Thapa, D. K., Hunt, G. ., Watson, R., & Cleary, M. (2020). *Chi-square for model fit in confirmatory factor analysis*. 2209–2211. <https://doi.org/10.1111/jan.14399>
- Almanasreh, E., Moles, R., & Chen, T. F. (2018). Research in Social and Administrative Pharmacy Evaluation of methods used for estimating content validity. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, xxxx, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2018.03.066>
- Antonio, F., Andy, A., & Moksidy, J. M. C. (2024). *The Association of Nurse Burnout with Patient Satisfaction from Nurse Perspective Mediated by Nurse Job Satisfaction and Caring Behavior*. 14(April), 40–52.
- António, M., Gonçalves, R., Aurora, M., Pereira, G., Jesus, N. De, & Machado, B. (2025). Development and Validation of a Preoperative Nursing Consultation Model : A Delphi Study. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*, 40(3), 586–589. <https://doi.org/10.1016/j.jopan.2024.07.007>
- Ataiyero, Y., Dube, A., Odell, J., Carter, V., Smith, H. A., Hardy, S., Leary, A., Jones, S., & Odell, J. (2025). *experimental study on the effectiveness and impact of implementing led ' therapeutic optimisation ' (THEO) intervention in two older persons wards: a mixed methods study protocol*. 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-102529>
- Baharum, H., Ismail, A., Awang, Z., Mckenna, L., & Ibrahim, R. (2023). *Validating an Instrument for Measuring Newly Graduated Nurses ' Adaptation*.
- Barbosa, L. C. (2024). *Geropalliative Caring Model analysis and assessment according to Fawcett ' s criteria*. 1–7.
- Belfrage, M., Johansson, E., & Lorig, F. (2024). *[In] Credible Models – Verification , Validation & Accreditation of Agent-Based Models to Support*. 27(4). <https://doi.org/10.18564/jasss.5505>

- Bender, M., & Micki, M. (2025). *Describing a programme of implementation- - effectiveness research on the organization and implementation of frontline nursing care delivery into diverse health systems. August 2024*, 8036–8049. <https://doi.org/10.1111/jan.16395>
- Bender, M., Williams, M., Su, W., & Hites, L. (2017). *Authors Refining and validating a conceptual model of Clinical Nurse Leader integrated care delivery*. <https://doi.org/10.1111/jan.13113>
- Birhanu, A., Id, D., Yilma, T. M., & Beshir, M. A. (2022). *Evidence-based practice and its associated factors among point-of-care nurses working at the teaching and specialized hospitals of Northwest Ethiopia: A concurrent study*. 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267347>
- Boniol, M., Kunjumen, T., Nair, T. S., Siyam, A., Campbell, J., & Diallo, K. (2022). *The global health workforce stock and distribution in 2020 and 2030: a threat to equity and ' universal ' health coverage ?* 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009316>
- Caro, J. J., Eddy, D. M., Kan, H., Kaltz, C., Patel, B., Eldessouki, R., & Briggs, A. H. (2014). i An update to this article is included at the end Questionnaire to Assess Relevance and Credibility of Modeling Studies for Informing Health Care Decision Making : An ISPOR- AMCP-NPC Good Practice Task Force Report. *Value in Health*, 17(2), 174–182. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2014.01.003>
- Carole, M., & Wagoro, A. (2020). *Nurses ' perspectives of an environment of optimum mental health : a grounded theory study*. <https://doi.org/10.1177/1744987120965651>
- Chays-amanian, A., Schwingrouber, J., Mazurek, B., Henri, P., & Julie, H. (2025). *Mapping Implementation Strategies and Outcomes When Using Evidence Based Practice Implementation Models in Nursing Settings: A Scoping Review*. <https://doi.org/10.1111/wvn.70050>
- Chesak, S. S., Scientists, N., Rhudy, L. M., Tofthagen, S. C., Scientists, N., Chlan, L. L., & Dean, A. (2022). *A practice- - based model to guide nursing science and improve the health and well- - being of patients and caregivers. June 2020*, 445–453. <https://doi.org/10.1111/jocn.15837>
- Clarke, J., & Davis, K. (2025). *Defining nurse-led models of care: Contemporary approaches to nursing. October 2024*. <https://doi.org/10.1111/inr.13076>
- Cocchieri, A., Magon, G., Cavalletti, M., Cristofori, E., & Zega, M. (2021). *Exploring hospital compliance with the primary nursing care model : validating an inventory using the Delphi method*. 1–8.
- Connor, T. O., Gibson, jo, Fellow, C., Lecturer, S., Lewis, J., & Karen Strickland. (2023). *Decision-making in nursing research and practice — Application of the Cognitive Continuum Theory: A meta-aggregative systematic review. April*, 7979–7995. <https://doi.org/10.1111/jocn.16893>

- Cristine, P., Costa, P., Jesus, T. De, Brito, L. De, Silva, S., Guimarães, R. B., Nogueira, L. D. A., & Kalinke, L. P. (2023). *CONTENT VALIDATION AND APPLICABILITY OF A NURSING CARE PROTOCOL FOR BURN VICTIMS*. 1–11.
- Darzi, A., & Evans, T. (2016). The global shortage of health workers — an opportunity to transform care. *The Lancet*, 388(10060), 2576–2577. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32235-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32235-8)
- Dehennin, L., Kinnaer, M., Vermassen, F., & Hecke, A. Van. (2023). *Role development , implementation and evaluation of nurse practitioners in a Belgian university hospital: a mixed methods study protocol*. 1–10. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-068101>
- Deliktas, A., Korujcu, O., Aydin, R., & Kabukcoglu, K. (2019). *Nursing Students ' Perceptions of Nursing Metaparadigms : A Phenomenological Study*. 27(5), 1–9.
- Devellis, R. F. (2017). *Scale Development Theory And Applications* (2nd ed.).
- Duff, J., Cullen, L., Hanrahan, K., & Steelman, V. (2020). *Determinants of an evidence-based practice environment : an interpretive description*. 0, 1–9.
- Dusin, J., Melanson, A., & Mische-, L. (2023). *based practice models and frameworks in the healthcare setting : a scoping review*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071188>
- Erdemir, A., Mulugeta, L., Ku, J. P., Drach, A., & Horner, M. (2020). Credible practice of modeling and simulation in healthcare: ten rules from a multidisciplinary perspective. *Journal of Translational Medicine*, 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02540-4>
- Fawcett, J. (2017). *Applying Conceptual Models Of Nursing : quality improvement, research, and practice* (J. Morita (ed.); 1st ed.).
- Feng, X., Xiao, W., Shen, F., Ye, Z., Su, W., Cai, A., Wu, X., & Chen, J. (2025). *Development and validation of an evaluation index system of health education competence for dental nurses in China : a mixed methods study*.
- Getie, A., Ayenew, T., Amlak, B. T., Gedfew, M., & Edmealem, A. (2025). *Global prevalence and contributing factors of nurse burnout : an umbrella review of systematic review and meta-analysis*.
- Gray, J. R., & Grove, S. K. (2017). *Burns & Grove ' s The Practice of Nursing Research Appraisal , Synthesis , and Generation of Evidence* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Gunawan J. (2020). *UNEQUAL DISTRIBUTION OF NURSES IN INDONESIA : A PERSPECTIVE FROM A NURSE*. 2(1), 8–9.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Multivariate Data Analysis* (8th ed.).
- Hikmah, N., Lazuardi, L., & Handono, D. (2016). *KESENJANGAN DISTRIBUSI TENAGA*

KESEHATAN DI PUSKESMAS WILAYAH INDONESIA TIMUR (Analisis Data IFLS East 2012). 19(03), 1–6.

- Hons, G. D. (2022). *Development , implementation and evaluation of a Professional Practice Model: A scoping review. May, 3519–3534.* <https://doi.org/10.1111/jonm.13820>
- Hosseini, F. A., Zarshenas, L., Parvan, K., & Shaygan, M. (2025). Assessment of the validity and reliability of the nurses ' professional values scale — revised in Persian version among nursing students. *BMC Medical Education.* <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06677-y>
- Hsu, C., & Sandford, B. A. (2007). *The Delphi Technique : 12(10).*
- Huynh, P., Williams, J., Dorcy, K. S., Sherinski, A., English, A., Heye, D., Joseph, S., & Ross, L. (2021). *Theory-Informed Models. 25(4), 2021.*
- Indrawati, E. (2023). *Penerapan manajemen asuhan keperawatan model tim dan model primer terhadap mutu asuhan keperawatan. 17(1), 71–78.*
- Juanamasta, I. G., Aunguroch, Y., Gunawan, J., Dino, M. J., & Polsook, R. (2024). Prevalence of burnout and its determinants among Indonesian nurses : a multicentre study. *Scientific Reports, 0123456789, 1–9.* <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63550-6>
- Kristensen, N., Nymann, C., & Konradsen, H. (2016). Implementing research results in clinical practice- the experiences of healthcare professionals. *BMC Health Services Research, 1–10.* <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1292-y>
- Lamm, K. W., Lamm, A. J., & Edgar, D. (2020). *Journal of International Agricultural and Extension Education. 27(2), 24–35.* <https://doi.org/10.5191/jiaee.2020.27224>
- Lamuri, A., Shatri, H., Umar, J., Sudaryo, M. K., Malik, K., Sitepu, M. S., Muzellina, V. N., Nursyirwan, S. A., Idrus, M. F., Renaldi, K., & Abdullah, M. (2023). Heliyon Burnout dimension profiles among healthcare workers in Indonesia. *Heliyon, 9(3), e14519.* <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14519>
- Lawshe, C. . (1975). *A QUANTITATIVE APPROACH TO CONTENT VA L I D I TY1.*
- Mccance, T., & McCormack, B. (2025). *The Person-centred Nursing Framework : a mid-range theory for nursing practice.* <https://doi.org/10.1177/17449871241281428>
- Meijel, B. Van. (2004). *The development of evidence-based nursing interventions : methodological considerations.*
- Muharram, F. R., Sulistya, H. A., Swannjo, J. B., Firmansyah, F. F., Rizal, M. M., Isfandiari, M. A., Dwi, A., & Romdhoni, A. C. (2025). *Adequacy and Distribution of the Health Workforce in Indonesia.* <https://doi.org/10.4103/WHO-SEAJP.HWHO-SEAJP.H>
- Muntlin, Å., Jangland, E., Laugesen, B., Lygum, S., Gunningberg, L., Greenway, K., Merriman, C., Grønkjær, M., Heinen, M., & Waal, G. H. (2023). International Journal of Nursing Studies Bedside nurses ' perspective on the Fundamentals of Care

- framework and its application in clinical practice: A multi-site focus group interview study. *International Journal of Nursing Studies*, 145, 104526. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104526>
- Naz, H., & Ganaie, N. A. (2023). *Evidence-Based Practice in Nursing: A Comprehensive Review Steps in the Evidence-Based Practice Process*: 03(06), 713–715. <https://doi.org/10.3163/1536-5050.99.3.010>
- Noprianty, R., Rustikayanti, R. N., Rokayah, C., & Nurlaela, D. (2022). *Penguatan Teori Keperawatan dan Kebidanan Dalam Melaksanakan Asuhan Kepada Pasien di Masa Pandemi*. 3(1), 18–27. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i1.214>
- Olabode, O. O. (2024). *Determinants of Implementation of Evidence-Based Practice in Clinical Decision- Making among Nurses in Primary Health Care Facilities*. 2(31), 90–106.
- Pahlevan, S. (2018). *A systematic review of structural equation modelling in nursing research*. 26, 28–31.
- Palinkas, L. A., Mendon, S. J., & Hamilton, A. B. (2019). *Innovations in Mixed Methods Evaluations*. 423–442.
- Papierkowska, R., Czapla, M., & Uchmanowicz, I. (2025). *Evaluation of Knowledge , Attitudes , and Skills in Evidence-Based Nursing Practice Among Master 's Degree Nursing Students*. 1–13.
- Poiroux, L., Bruyneel, A., Larcin, L., Fossat, G., Kamel, T., Labro, G., Goursaud, S., Rouze, A., Heming, N., & Hermann, B. (2024). *Intensive & Critical Care Nursing Barriers to research findings utilization amongst critical care nurses and allied health professionals: An international survey*. 81(December 2023). <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2023.103610>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing Research Appraising Evidence For Nursing Practice* (10th ed.). Wolters Kluwer Health. <https://digrep.mchs.mw/handle/123456789/357>
- Prentice, D., Moore, J., & Desai, Y. (2021). *Nursing care delivery models and outcomes: A literature review*. July, 1–9. <https://doi.org/10.1111/nuf.12640>
- Rao, K., & Schmidt, A. (2023). *Human Resources for Health in South - East Asia: Challenges and Strategies*. 11, 11–13.
- Ren, H., Li, P., Xue, Y., Xin, W., Yin, X., & Li, H. (2024). *Global Prevalence of Nurse Turnover Rates: A Meta-Analysis of 21 Studies from 14 Countries*. 2024.
- Rojas-, A., Natalia, R., Araceli, Q., Muñoz-, F., Concha-, L. C., Galiano, G. A., Larrain, A., & Sánchez, B. (2023). *Development of a Professional Practice Nursing Model for a University Nursing School and Teaching Hospital: A nursing methodology research*. July 2022, 358–366. <https://doi.org/10.1002/nop2.1308>
- Saiful, M., & Yusoff, B. (2019). *ABC of Content Validation and Content Validity Index*

- Calculation*. 11(2), 49–54. <https://doi.org/10.21315/eimj2019.11.2.6>
- Salbego, C., Nietzsche, E. A., Cogo, S. B., Girardon-perlini, N. M. O., Ramos, T. K., Bitencourt, P., Greco, T., & Sehnem, G. D. (2024). *VALIDATION OF A METHODOLOGICAL RESEARCH MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF NURSING*. 1–16.
- Samuelsson, M., Ericsson, A., Carlson, E., Sjögran, L., Hylén, M., & Striberger, R. (2025). Practice-based models for nurse scientists_ A scoping review of core components, development, evaluations, and key success factors. *Nursing Outlook*, 73(5), 102488. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2025.102488>
- Sastre-fullana, P., Morales-asencio, J. M., Sesé-abad, A., Bennasar-veny, M., Fernández-domínguez, J. C., & Pedro-gómez, J. De. (2017). *Advanced Practice Nursing Competency Assessment Instrument (APNCAI) : clinimetric validation*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013659>
- Schaffer, M. A., Sandau, K. E., & Diedrick, L. (2012). *and practical applications*. 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06122.x>
- Setiawati, S., Roahayani, L., & Akmaludin, I. (2021). *PENGETAHUAN PERAWAT PELAKSANA DENGAN PENERAPAN MODEL ASUHAN KEPERAWATAN PROFESIONAL PENYAKIT DALAM DAN BEDAH*. 3, 423–428.
- Singh, K., Mohammad, A., Alomari, A., Mohamed, H., Sayed, A., Mannethodi, K., Kunjavara, J., Joy, G. V, Hassan, N., Martinez, E., & Lenjawi, B. Al. (2024). *Barriers and Solutions to the Gap between Theory and Practice in Nursing Services : A Systematic Review of Qualitative Evidence*. 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/7522900>
- Speroni, K. G. (2020). *Use of Evidence-based Practice Models and Research Findings in Magnet-Designated Hospitals Across the United States : National Survey Results*. 98–107. <https://doi.org/10.1111/wvn.12428>
- Vergara, M. P., Lopera, E. M. C., Contreras, O. L. L., & Herrera, B. S. (2021). *Nursing Care at the Service of Life : A model including charity , quality , and leadership*. March, 10–14. <https://doi.org/10.1111/nuf.12624>
- Viceconti, M., Pappalardo, F., Rodriguez, B., Horner, M., & Musuamba, F. (2023). *In silico trials : Veri fi cation , validation and uncertainty quanti fi cation of predictive models used in the regulatory evaluation of biomedical products*. January 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2020.01.011>
- Vieira, T. W., Sakamoto, Victória Tiyoko Moraes, L. C. de, Blatt, C. R., & Caregnato, R. C. A. (2020). *Validation methods of nursing protocols : an integrative review*. 73(Suppl 5), 1–9.
- Williams, M., John, R. N., Coppin, D., & Miriam, M. P. H. (2023). *Predictors of Clinical Nurse Leader implementation success across a national sample of settings : A Bayesian multilevel modeling analysis*. July, 1238–1247.

<https://doi.org/10.1111/jnu.12926>

World Health Organization. (2025). *State of the world ' s nursing*.
<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a4173924-a18f-49b6-8bd1-9c2a4a098980/content>

Zapata, T., Zakoji, M., Kanda, M., Travis, P., Tangcharoensathien, V., Buchan, J., & Jhalani, M. (2021). *Implementing a decade of strengthening the health workforce in the WHO South-East Asia Region : achievements and way forward for primary health care*. 10(February).

Zendrato, M. V., & Hariyati, T. S. (2017). *Optimalisasi pengelolaan asuhan keperawatan di instalasi rawat jalan rumah sakit x*.

Glosarium

Analisis Statistik

Analisis Statistik: adalah Proses pengolahan dan interpretasi data menggunakan metode statistik untuk menarik kesimpulan dalam penelitian.

Burnout

Burnout: adalah Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan kerja yang berkepanjangan.

Content Validity Index (CVI)

Content Validity Index (CVI): adalah Indeks yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian atau relevansi item dalam suatu model berdasarkan penilaian panel ahli

Content Validity Ratio (CVR)

Content Validity Ratio (CVR): Adalah Ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu item dalam model dianggap penting atau esensial oleh para ahli.

Delphi Technique

Delphi Technique: adalah Metode pengumpulan pendapat ahli secara bertahap melalui beberapa putaran untuk mencapai konsensus.

Diabetic Foot Ulcer (DFU)

Diabetic Foot Ulcer (DFU): adalah Luka kronis pada kaki pasien diabetes yang disebabkan oleh neuropati dan gangguan sirkulasi, berisiko menyebabkan amputasi jika tidak ditangani dengan baik.

Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)

Evidence-Based Nursing Practice (EBNP): adalah Pendekatan praktik keperawatan yang didasarkan pada penggunaan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan preferensi pasien.

Implementasi Model

Implementasi Model: adalah Proses penerapan model asuhan keperawatan dalam praktik klinis atau setting penelitian.

Instrumen Penelitian (Research Instrument)

Instrumen Penelitian (Research Instrument): Adalah Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner, skala penilaian, atau lembar observasi.

Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset (Research-Based Nursing Care Model)

Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset (Research-Based Nursing Care Model) : adalah Kerangka kerja sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah.

Outcome Pasien (Patient Outcome)

Outcome Pasien (Patient Outcome): adalah Hasil atau dampak dari intervensi keperawatan terhadap kondisi kesehatan pasien.

Panel Ahli (Expert Panel)

Panel Ahli (Expert Panel): adalah Sekelompok individu dengan kompetensi khusus yang dilibatkan dalam proses validasi model.

Pretest–Posttest Design

Pretest–Posttest Design: adalah Desain penelitian yang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai perubahan.

Quasi-Experimental Design

Quasi-Experimental Design : adalah Desain penelitian untuk menguji efek intervensi tanpa randomisasi penuh.

Reliabilitas (Reliability)

Reliabilitas (Reliability): adalah Tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel yang sama.

Structural Equation Modeling (SEM)

Structural Equation Modeling (SEM): adalah Metode analisis statistik untuk menguji hubungan kompleks antar variabel dalam suatu model.

Uji Model (Model Testing)

Uji Model (Model Testing): adalah Proses pengujian efektivitas model dalam praktik nyata untuk menilai dampaknya terhadap outcome

Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC): adalah Konsep sistem kesehatan yang menjamin seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial.

Validasi Model (Model Validation)

Validasi Model (Model Validation): adalah Proses penilaian untuk memastikan bahwa model memiliki kesesuaian secara teoritis dan praktis

Variabel Dependen (Dependent Variable)

Variabel Dependen (Dependent Variable): adalah Variabel yang menjadi hasil atau dipengaruhi dalam suatu penelitian.

Variabel Independen (Independent Variable)

Variabel Independen (Independent Variable): adalah Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dalam suatu penelitian.

BAB 6

IMPLEMENTASI MODEL DALAM PELAYANAN

A. Pendahuluan

Model adalah metode berpikir ilmiah dan operasional yang memberikan panduan untuk menyelesaikan masalah dalam praktik keperawatan serta meningkatkan kualitas layanan keperawatan (Xue dkk., 2022). Model keperawatan mencakup struktur, proses, dan nilai profesional yang memungkinkan perawat untuk mengelola praktik mereka secara profesional (Amir dkk., 2020). Model dalam pelayanan keperawatan adalah alat penting untuk memastikan bahwa praktik keperawatan dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Cordo & Hill-Rodriguez, 2017; Juniarti & Fuller, 2025; Xue dkk., 2022). Perawat dapat meningkatkan kualitas praktik keperawatan dengan mengimplementasikan model dalam pelayanannya.

Implementasi model dalam pelayanan adalah proses yang melibatkan integrasi kerangka kerja teoretis, strategi organisasi, dan metode pemberian perawatan praktis untuk meningkatkan perawatan pasien, meningkatkan praktik keperawatan, dan mengatasi tantangan sistemik. Implementasi model dalam pelayanan yang telah diterapkan yaitu implementasi model asuhan keperawatan berbasis *evidence-based nursing* dalam pelayanan klinis, model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan keperawatan komunitas, model *transcultural nursing* dalam pelayanan keperawatan, dan model *continuity of care* dalam pelayanan keperawatan maternal dan anak, model *self care* dalam manajemen penyakit kronis, dan model *collaborative care* dalam sistem pelayanan kesehatan.

B. Implementasi Model Asuhan Keperawatan Berbasis Evidence-Based Nursing dalam Pelayanan Klinis

Evidence-Based Nursing (EBN) adalah pendekatan yang digunakan dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan menggunakan bukti-bukti ilmiah yang terkini dan relevan (Sampeangin dkk., 2025). Model ini mengintegrasikan bukti terbaik yang tersedia ke dalam praktik keperawatan klinis untuk meningkatkan status kesehatan pasien, meningkatkan kualitas perawatan, dan mendorong perawatan profesional. Di Indonesia,

keperawatan berbasis EBN semakin diakui sebagai pendekatan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Langkah-langkah penyusunan asuhan keperawatan berbasis *evidence-based nursing* dengan cara mengidentifikasi pertanyaan klinis, mencari bukti, mengevaluasi bukti, mengimplementasi bukti, dan mengevaluasi hasil (Sampeangin dkk., 2025). Contoh proses *evidence-based nursing* terkait keselamatan pasien (Irawan dkk., 2026; Sampeangin dkk., 2025) sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah atau pertanyaan klinis yang memerlukan jawaban berdasarkan bukti. Misalnya masalah pasien yaitu tingginya angka infeksi. Maka masalah tersebut kita ubah menjadi pertanyaan klinis berformat Populasi, Intervensi, Comparasi/perbandingan, *Outcome* (PICO).
2. Mencari bukti-bukti ilmiah yang relevan dan terkini untuk menjawab pertanyaan klinis. Misalnya mencari bukti terbaik melalui pencarian literature terkini baik melalui database jurnal ataupun studi dokumentasi.
3. Mengevaluasi kualitas dan relevansi bukti-bukti yang ditemukan. Misalnya data yang sudah kita dapat ditahap kedua dinilai validitasnya untuk mengeliminasi praktik yang tidak berbasis bukti.
4. Mengimplementasikan bukti-bukti yang telah dievaluasi ke dalam praktik keperawatan. Misalnya mengintegrasikan bukti yang divalidasi ke dalam praktik klinis.
5. Mengevaluasi hasil implementasi bukti-bukti ke dalam praktik keperawatan. Mengaudit dampak intervensi EBN terhadap outcome pasien dan memicu pertanyaan baru.

Manfaat dari implementasi EBN yaitu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, mengurangi kesalahan dan komplikasi, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, mengoptimalkan sumber daya keperawatan, dan meningkatkan profesional perawat (Sampeangin dkk., 2025). Praktik keperawatan EBN terbukti dapat meningkatkan status kesehatan pasien, seperti implementasi jalur klinis meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi lama rawat inap di rumah sakit di Indonesia (Rachmawaty dkk., 2025). Selain itu, program pendidikan EBN yang dilakukan di Sumatera Barat secara signifikan meningkatkan sikap, keterampilan, dan penerapan praktik berbasis bukti pada perawat (Novrianda & Fajria, 2022). Demikian pula, program pelatihan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri perawat dalam menangani kondisi spesifik seperti kelelahan terkait kanker (Tian dkk., 2017).

Hambatan dalam implementasi EBN di Indonesia, yaitu adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan budaya dan organisasi (Ekawati dkk., 2023; Friesen-Storms dkk., 2017; Ligita dkk., 2024;

Narulita dkk., 2025; Tian dkk., 2017). Studi terdahulu menunjukkan bahwa perawat di Indonesia kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menerapkan EBN secara efektif sehingga menghambat penerapan EBN (Ligita dkk., 2024; Narulita dkk., 2025). Hambatan lainnya seperti keterbatasan sumber daya klinis, kurangnya literasi penelitian, dan infrastruktur yang tidak memadai diidentifikasi secara signifikan menjadi penghambat dalam implementasi EBN (Ekawati dkk., 2023; Friesen-Storms dkk., 2017; Ligita dkk., 2024). Isu-isu seperti pengambilan keputusan hierarkis, kurangnya dukungan pemimpin, dan komunikasi yang tidak memadai antara penyedia layanan kesehatan dapat menghambat implementasi EBN (Friesen-Storms dkk., 2017; Tian dkk., 2017).

Rekomendasi untuk implementasi EBN yang efektif dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas perawat, adanya dukungan kelembagaan, adanya kebijakan dan pedoman, dan kolaborasi. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui investasi dalam pengembangan profesional berkelanjutan dan pelatihan literasi penelitian untuk perawat dan pembimbing keperawatan (Ligita dkk., 2024; Novrianda & Fajria, 2022). Dukungan kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat komitmen kepemimpinan dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi EBN (Friesen-Storms dkk., 2017; Tian dkk., 2017). Mengembangkan pedoman nasional dan sistem penghargaan untuk mendorong kepatuhan terhadap praktik EBN (Asmirajanti dkk., 2019). Selain itu, mendorong kerja tim multidisiplin dan keterlibatan pemangku kepentingan (Ekawati dkk., 2023; Friesen-Storms dkk., 2017).

C. Implementasi Model Pemberdayaan Keluarga dalam Pelayanan Keperawatan Komunitas

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat (Afriansyah dkk., 2023). Pemberdayaan keluarga merupakan mekanisme terjadinya perubahan kemampuan dalam keluarga yang berdampak positif dari rencana keperawatan dan tindakan promosi kesehatan serta sesuai dengan budaya dalam keluarga yang memengaruhi tindakan pengobatan dan perkembangan keluarga (Azza & Setyowati dalam Salamung et al., 2021). Menurut Akhriansyah et al. (2023) pemberdayaan keluarga adalah intervensi keperawatan yang dirumuskan untuk memaksimalkan kemampuan keluarga.

Model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan keperawatan komunitas merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan peran keluarga sebagai unit perawatan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola kesehatan

anggota keluarga, baik dalam konteks pencegahan penyakit, perawatan kronis, maupun dukungan emosional. Pendekatan ini membantu keluarga mengakses sumber daya, meningkatkan fungsi keluarga, dan menjaga harapan untuk masa depan (Cleek dkk., 2012; Karataş dkk., 2020; Rondhianto, 2020a). Pemberdayaan keluarga memberikan manfaat bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Manfaat ini meliputi peningkatan keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan, pengurangan kecemasan, peningkatan keterampilan merawat, dan penguatan kemandirian keluarga (Kuo, 2024; Rondhianto, 2020a).

Prinsip pemberdayaan keluarga menurut Graves and Shelton (2007) yaitu

1. Tidak memberikan bantuan yang bersifat *charity* yang akan menjadikan munculnya ketergantungan dan melemahkan. Pemberdayaan hendaknya memberikan bantuan berupa pendampingan dan atau pelatihan yang mempromosikan *self-reliance* dan meningkatkan kapasitas seseorang.
2. Menggunakan metode pemberdayaan yang menjadikannya menjadi lebih kuat melalui koping yang tepat, melalui pelatihan terhadap daya tahan dan daya juang menghadapi masalah.
3. Meningkatkan partisipasi sehingga meningkatkan kapasitas dan mampu mengambil kontrol penuh, pengambilan keputusan penuh, dan tanggung jawab penuh untuk melakukan kegiatan.

Model pemberdayaan keluarga ketika dihadapkan pada situasi pelayanan kesehatan yang membutuhkan kontak berkelanjutan dengan tenaga kesehatan profesional, keluarga memasuki proses pemberdayaan keluarga. Empat tahapan pemberdayaan keluarga menurut Hulme (1999) mencirikan proses interaktif yaitu dominasi profesional, partisipati, tantangan, dan kolaborasi. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, tenaga kesehatan profesional (termasuk perawat), sistem pelayanan kesehatan, dan masyarakat saat mereka terlibat dalam proses pemberdayaan keluarga.

Penerapan model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan keperawatan komunitas di Indonesia telah dilaksanakan dalam berbagai konteks untuk meningkatkan status kesehatan dan mengatasi tantangan yang ada di komunitas. Model pemberdayaan keluarga yang telah diaplikasikan yaitu pemberdayaan keluarga dalam perawatan lansia, program kesehatan yang berpusat pada keluarga, model pemberdayaan spesifik penyakit, dan pemberdayaan keluarga berbasis perawatan lintas budaya (Has dkk., 2023; Nitbani dkk., 2022; Prabowo dkk., 2025; Riasmini dkk., 2019; Rondhianto, 2020b; Sumiati dkk., 2025). Pemberdayaan keluarga dalam perawatan lansia melalui model “kelompok keluarga mandiri” mengintegrasikan kelompok swadaya dan dukungan untuk meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup lansia. Studi menunjukkan pemberian intervensi

model kelompok keluarga mandiri selama 3-6 bulan dapat meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup lansia di masyarakat (Riasmini dkk., 2019). Penerapan model berpusat pada keluarga bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan (Nitbani dkk., 2022). Intervensi ini telah digunakan untuk meningkatkan praktik pemberian makanan pendamping dan pertumbuhan anak, keragaman makanan, frekuensi makan, dan indikator pertumbuhan anak (Has dkk., 2023). Penerapan model pemberdayaan spesifik penyakit, misalnya dalam pengelolaan penyakit diabetes, perawat berperan penting dalam melakukan pemberdayaan pengasuh keluarga, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan manajemen diri pasien melalui pemberian kesempatan, penguatan, dan dukungan kepada pengasuh (Rondhianto, 2020b). Selain itu, model berbasis keluarga yang berintegrasi dengan konseling pribadi dapat meningkatkan perilaku pencegahan tuberkulosis (Sumiati dkk., 2025). Model pemberdayaan keluarga berbasis budaya dikembangkan untuk mengatasi stunting. Model ini mengintegrasikan kepekaan budaya, pendidikan, dan dukungan relawan kesehatan masyarakat yang secara signifikan meningkatkan kualitas pemberian makanan pendamping dan keterlibatan keluarga dalam mengatasi stunting (Prabowo dkk., 2025).

Tantangan dalam implementasi model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan keperawatan komunitas yaitu dokumentasi, hambatan budaya, dan keterbatasan sumber daya. Dokumentasi keluarga masih kurang dimanfaatkan karena beban kerja yang tinggi, keterbatasan staf, dan pedoman yang kurang jelas, sehingga dapat memengaruhi konsistensi pemberian perawatan (Sulidah & Hananti, 2024). Praktik dan kepercayaan budaya sering memengaruhi penerimaan intervensi kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan yang pekat terhadap budaya untuk memastikan keberhasilan program (Prabowo dkk., 2025; Setiawan dkk., 2016). Keterbatasan sumber daya disebabkan banyak program menghadapi berbagai tantangan seperti pendanaan yang tidak memadai, kekurangan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang terbatas, sehingga membatasi skalabilitas dan efektivitasnya (Nitbani dkk., 2022).

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan penerapan model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan keperawatan komunitas, yaitu integrasi peka budaya, memperkuat keterlibatan keluarga, dan kebijakan dan alokasi sumber daya. Model pemberdayaan keluarga harus menggabungkan praktik dan kepercayaan budaya lokal untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat (Prabowo dkk., 2025; Setiawan dkk., 2016). Memberdayakan keluarga melalui pendidikan, konseling, dan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan status kesehatan dan keberlanjutan program (Rondhianto, 2020b; Sumiati dkk., 2025). Selain itu, mengatasi kesenjangan sumber daya dan memberikan pedoman

yang jelas untuk dokumentasi keperawatan keluarga dan implementasi program sangat penting untuk keberhasilan (Nitbani dkk., 2022; Sulidah & Hananti, 2024).

D. Implementasi Model *Transcultural Nursing* dalam Pelayanan Keperawatan di Indonesia

Transcultural nursing sebagai area utama keperawatan yang berfokus pada studi komparasi dan analisis dari keragaman budaya dan sub-budaya di dunia dengan memperhatikan nilai *caring*, ekspresi, kepercayaan tentang sehat-sakit, serta pola perilaku mereka (Alligood, 2017). Model *transcultural nursing* atau keperawatan transkultural dalam pelayanan keperawatan adalah bidang khusus dalam keperawatan yang berfokus pada penyediaan perawatan yang sesuai dengan budaya dengan mengintegrasikan nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien ke dalam pemberian layanan kesehatan. Menurut Leininger, setiap orang dari masing-masing budaya mengetahui dan dapat mendefinisikan cara-cara sesuai pengalaman dan persepsi mereka terhadap keyakinan sehat secara umum dan praktiknya (Nursalam, 2020). Keperawatan transkultural menekankan perawatan yang selaras secara budaya dengan menjembatani perawatan tradisional dan perawatan profesional melalui model Sunrise. Pendekatan ini sangat relevan di Indonesia, mengingat keragaman budayanya dan kebutuhan akan praktik perawatan kesehatan yang peka terhadap budaya (Sagar & Sagar, 2018; Timoteo dkk., 2023).

Konsep-konsep utama dalam keperawatan transkultural yaitu kompetensi budaya, keperawatan etnis, dan keramahtamahan dan pendampingan. Dari segi kompetensi budaya menunjukkan bahwa perawat harus mengembangkan keterampilan untuk memahami dan mengatasi variasi budaya dalam komunikasi, kepercayaan, dan praktik. Hal ini termasuk menilai faktor-faktor seperti organisasi sosial, pengendalian lingkungan, dan variasi biologis (Andrews & Boyle, 2015; Giger & Haddad, 2020). Pendekatan keperawatan etnis menekankan kesadaraan budaya, kepekaan, dan keterampilan komunikasi (Pujiastuti dkk., 2026). Pendekatan keramahtamahan dan pendampingan yaitu berfokus membangun hubungan, mendengarkan cerita pasien, dan mengurangi stereotip untuk menciptakan ruang aman bagi populasi yang terpinggirkan (Enestvedt dkk., 2018).

Keperawatan transkultural di Indonesia telah diterapkan oleh mahasiswa keperawatan dari berbagai latar belakang budaya. Sebuah studi menunjukkan bahwa 72,4% mahasiswa mampu menerapkan keterampilan keperawatan transkultural dengan baik, meskipun tidak ditemukan hubungan signifikan antara asal daerah mahasiswa dengan kemampuan mereka dalam menerapkan keperawatan transkultural (Nur'ainun & Novieastari, 2019). Di daerah pedesaan,

norma budaya, hubungan keluarga, dan sistem dukungan sosial secara signifikan memengaruhi status kesehatan, seperti efikasi diri dalam mengelola kondisi kronis. Perawat dapat memanfaatkan faktor-faktor ini untuk memberikan intervensi yang disesuaikan dengan budaya setempat (Djerubu dkk., 2024). Dalam konteks budaya lokal, perawat di Yogyakarta menerapkan nilai-nilai tata krama Mataraman Jawa dalam praktik keperawatan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman budaya lokal dalam memberikan perawatan yang sesuai secara budaya (Arrini dkk., 2023).

Implementasi model keperawatan transkultural di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Pengintegrasian model transkultural ke dalam pendidikan, praktik, dan kebijakan, membuat perawat dapat lebih baik memenuhi kebutuhan populasi di Indonesia yang beragam. Namun, salah satu tantangan utama dalam menerapkan model transkultural adalah kurangnya dokumentasi keperawatan yang sesuai dengan standar, seperti SDKI, SLKI, dan SIKI, di pusat kesehatan masyarakat di Indonesia. Hanya 36,4% perawat yang mendokumentasikan perawatan dengan baik, sehingga perlu pelatihan lebih lanjut (Maksum dkk., 2026).

Rekomendasi untuk implementasi penerapan model transkultural yaitu dukungan sosial, integrasi kebijakan, serta penelitian dan pengembangan. Institusi layanan kesehatan harus menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi budaya perawat, termasuk paparan terhadap pengalaman multibudaya dan strategi pemecahan masalah (Ahn, 2017). Kebijakan harus memprioritaskan perawatan yang sesuai dengan budaya, terutama untuk populasi yang terpinggirkan dan imigran, dengan mengatasi hambatan bahasa dan perbedaan budaya (Chen dkk., 2008). Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak model keperawatan transkultural terhadap hasil kesehatan di Indonesia, khususnya di komunitas yang beragam dan kurang terlayani (Pujiastuti dkk., 2026; Timoteo dkk., 2023).

E. Implementasi Model *Continuity of Care* dalam Pelayanan Keperawatan Maternal dan Anak

Continuity of Care (CoC) dalam pelayanan keperawatan maternal dan anak adalah pendekatan yang menekankan kesinambungan layanan kesehatan dari masa kehamilan, persalinan, hingga periode pascapersalinan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, hasil kesehatan ibu dan bayi, serta kepuasan pasien. Adapun komponen utama model CoC yaitu *relational continuity*, *informational continuity*, dan *managerial continuity*. Hubungan yang konsisten antara pasien dan penyedia layanan, seperti bidan atau perawat,

memungkinkan perawatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan individu (Barimani & Hylander, 2012; Psaila dkk., 2014). Komunikasi yang baik dan berbagi informasi antara penyedia layanan memastikan transisi yang mulus di berbagai tahap perawatan (Austin, 2023; Psaila dkk., 2014). Koordinasi yang efektif antara berbagai layanan kesehatan, termasuk kolaborasi dengan dokter umum, spesialis obstetri, dan perawatan anak, sangat penting untuk keberhasilan model CoC (Cummins dkk., 2020; Psaila dkk., 2014).

Manfaat dari model CoC yaitu adanya peningkatan status kesehatan, kepuasan pasien, dan efisiensi biaya. Studi terdahulu menunjukkan bahwa model CoC yang dipimpin oleh perawat atau bidan (*midwifery-led continuity of care*) terbukti meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi, seperti menurunkan angka kelahiran prematur, morbiditas neonatal, dan intervensi medis yang tidak perlu (Adnani dkk., 2025; Homer, 2016; Palimbo dkk., 2021). Selain itu, model ini juga memberikan hasil yang positif, termasuk pengurangan komplikasi obstetrik dan peningkatan tingkat menyusui (Fox dkk., 2023). Dari segi kepuasan pasien, studi menunjukkan pasien melaporkan hubungan yang lebih baik dengan penyedia layanan, perawatan yang lebih personal, dan komunikasi yang lebih efektif dalam model CoC (Cummins dkk., 2020, 2022; Symon dkk., 2019). Dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan yang sama meningkatkan kepercayaan pasien (Symon dkk., 2019; Yokoyama dkk., 2024). Dari segi efisiensi biaya, model CoC dapat mengurangi biaya layanan kesehatan dengan menurunkan kebutuhan intervensi medis dan meningkatkan efisiensi sistem (Homer, 2016; Middlemiss dkk., 2024).

Model CoC dalam pelayanan keperawatan maternal dan anak di Indonesia telah diimplementasikan melalui berbagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Studi yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan terjadinya peningkatan kepuasan pasien postpartum. Adanya fitur seperti penjadwalan janji temu, edukasi kesehatan, komunikasi setiap saat dengan bidan dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan interpersonal (Darmawan dkk., 2025). Menurut Susanti dkk. (2023) model CoC juga terbukti lebih efektif dibandingkan dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam meningkatkan pengetahuan ibu muda tentang kehamilan, persalinan, dan peran pengasuhan. Mar'atus Sholikhah dkk. (2025) mengemukakan bahwa intervensi CoC pada kehamilan berisiko tinggi di Sidoarjo meningkatkan kemandirian keluarga dalam mendukung kebutuhan fisiologis, psikologis, dan persiapan persalinan serta postpartum.

Tantangan implementasi model CoC yaitu adanya keterbatasan sumber daya, literasi kesehatan rendah, dan kesenjangan layanan. Keterbatasan sumber daya

seperti kurangnya tenaga terlatih, beban kerja bidan, dan koordinasi yang lemah antara fasilitas kesehatan yang dapat menghambat implementasi CoC, terutama dalam kasus bayi lahir rendah (BBLR) (Tambunan, 2025). Menurut (Probandari dkk., 2017) rendahnya literasi kesehatan ibu dan keluarga, serta norma sosial yang menghambat praktik perawatan pasca persalinan, menjadi tantangan utama di daerah pedesaan. Selain itu, penurunan signifikan dalam kesinambungan layanan terjadi setelah kunjungan antenatal, dengan banyak ibu tidak melanjutkan ke layanan persalinan dan postnatal (Andriani dkk., 2022; Rammohan dkk., 2024).

Rekomendasi implementasi model CoC dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan, kolaborasi multidisiplin, serta edukasi dan pelatihan. Menurut (Lazuardi dkk., 2021) sistem informasi kesehatan ibu dan anak berbasis digital memiliki potensi untuk mendukung CoC, meskipun masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan regulasi. Penggunaan tim multidisiplin dapat meningkatkan efektivitas layanan maternal di Indonesia (Ekawati dkk., 2023). Adanya edukasi dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas bidan dalam memberikan perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga (Probandari dkk., 2017; Tambunan, 2025).

F. Implementasi Model *Self-Care* dalam Manajemen Penyakit Kronis

Model *self-care* dalam manajemen penyakit kronis adalah pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan pasien untuk secara aktif mengelola kondisi mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi beban pada sistem kesehatan. Beberapa model telah dikembangkan untuk mendukung *self-care*, dengan berbagai pendekatan yang menekankan aspek biopsikososial, teknologi, dan pemberdayaan pasien. Model biopsikososial mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan untuk memahami perilaku *self-management* pasien. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku dan hasil kesehatan jangka panjang (Huang dkk., 2023; Nair dkk., 2021). Konsep pemberdayaan menekankan partisipasi aktif pasien dalam pengelolaan penyakit mereka. Contohnya model lima langkah untuk diabetes yang dapat membantu pasien mencapai keseimbangan antara kontrol penyakit dan kehidupan sehari-hari (Wu & Lin, 2014). Teknologi seperti *telehealth* dan avatar virtual telah menunjukkan potensi dalam mendukung *self-management*, terutama bagi populasi lansia dengan keterbatasan akses ke layanan kesehatan (Krutter dkk., 2022; Straub & Thekkekkandam, 2023).

Implementasi model *self-care* Indonesia berperan penting dalam pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit ginjal kronis (PPOK). Pengelolaan diri sangat penting untuk perawatan diabetes, dengan faktor-

faktor seperti efikasi diri, dukungan keluarga, dan literasi kesehatan digital yang secara signifikan memengaruhi perilaku pengendalian glikemik (Appulembang, 2025; Kurnia dkk., 2017). Perilaku perawatan diri untuk hipertensi, seperti perubahan gaya hidup dan kepatuhan pengobatan. Faktor-faktor seperti etnis, status perkawinan, dan indeks massa tubuh dapat memengaruhi praktik perawatan diri pada pasien hipertensi (Sarfika dkk., 2023). Menurut (Mailani dkk., 2023) pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis menunjukkan perilaku manajemen diri yang kurang optimal. Hal ini disebabkan pendidikan dan pengetahuan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi manajemen diri. Selain itu, keterlibatan keluarga dan program berbasis komunitas sangat penting untuk perawatan diri yang efektif.

Tantangan dalam implementasi model perawatan diri yaitu adanya hambatan sistem pelayanan kesehatan, hambatan yang berkaitan dengan pasien, dan integrasi teknologi. Keterbatasan sumber daya, pasokan medis yang tidak konsisten, dan kekurangan staf menghambat implementasi model perawatan diri secara efektif (Febriani dkk., 2021; Hustrini dkk., 2026). Rendahnya literasi kesehatan, kendala sosial ekonomi, dan faktor budaya mengurangi partisipasi dan kepatuhan terhadap program perawatan diri (Febriyanti dkk., 2025; Khasanah dkk., 2024). Meskipun perangkat digital seperti aplikasi seluler menunjukkan potensi, penerapannya terbatas oleh literasi digital dan akses di daerah pedesaan (Cahyadi dkk., 2025; Putri dkk., 2022).

Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menerapkan model perawatan diri melalui pendidikan dan pelatihan, penggunaan perangkat aplikasi digital, pendekatan berbasis komunitas, dan adanya kebijakan serta alokasi dana. Program pendidikan terstruktur untuk pasien dan penyedia layanan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan efikasi diri, sehingga menghasilkan hasil manajemen diri yang baik (Hustrini dkk., 2026; Kurnia dkk., 2017; Mailani dkk., 2023). Memperluas penggunaan perangkat digital kesehatan dan mengintegrasikannya ke dalam perawatan primer dapat meningkatkan kepatuhan dan pemantauan (Cahyadi dkk., 2025; Putri dkk., 2022). Memperkuat kemitraan komunitas dan melibatkan keluarga dalam perawatan dapat mengatasi hambatan budaya dan sosial ekonomi (Febriyanti dkk., 2025; Subrata, 2021). Selain itu, mengatasi masalah sistemik seperti pendanaan, infrastruktur, dan SOP sangat penting untuk meningkatkan skala model perawatan diri secara efektif (Febriyanti dkk., 2025; Rachmawati dkk., 2020).

G. Implementasi Model *Collaborative Care* dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Model Collaborative Care adalah pendekatan berbasis bukti yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Model ini melibatkan kolaborasi antara manajer perawatan, konsultan psikiatri, dan penyedia layanan kesehatan primer untuk memberikan perawatan yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Manfaat model *collaborative care* telah terbukti lebih efektif dibandingkan perawatan standar dalam mengelola kondisi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Model ini dapat meningkatkan hasil klinis, seperti pengurangan gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Eghaneyan dkk., 2014; Lahijani & Rosenthal, 2015; Reist dkk., 2022). Menurut Matzke dkk. (2018) dan Reist dkk. (2022) meskipun biaya implementasi awal tinggi, model *collaborative care* menghasilkan penghematan jangka panjang melalui pengurangan rawat inap dan peningkatan efisiensi sistem kesehatan. Model collaborative care dapat disesuaikan untuk berbagai populasi, termasuk lansia, wanita dengan depresi perinatal, dan pasien dengan penyakit kronis (James, 2025; Reist dkk., 2022; Whitfield dkk., 2023). Model ini memperluas akses ke layanan kesehatan mental, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas, seperti dengan negara berpenghasilan rendah dan menengah (Acharya dkk., 2017; Whitfield dkk., 2023).

Komponen utama dari model *collaborative care* yaitu tim multidisiplin, pendekatan berbasis data, pendekatan perawatan bertahap, dan dukungan manajemen mandiri. Melibatkan kolaborasi antara dokter, psikiater, perawat, dan manajer perawatan untuk memberikan perawatan yang terintegrasi (Goodrich dkk., 2013; Lahijani & Rosenthal, 2015; Whitfield dkk., 2023). Penggunaan alat pengukuran berbasis data untuk memantau hasil klinis dan menyesuaikan perawatan (Eghaneyan dkk., 2014; Reist dkk., 2022). Menurut (Whitfield dkk., 2023) perawatan diberikan secara bertahap berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien. Pasien didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kondisi mereka melalui pendidikan dan dukungan (Goodrich dkk., 2013; Sanchez, 2017).

Implementasi model collaborative care di Indonesia menghadapi tantangan seperti adanya keterbatasan sumber daya, kesenjangan infrastruktur digital, dan fragmentasi sistem kesehatan. Di negara dengan sumber daya rendah seperti di Indonesia, tidak semua komponen collaborative care dapat diterapkan secara penuh. Pendekatan yang disesuaikan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini, seperti menggunakan strategi berbasis biaya-manfaat untuk memprioritaskan komponen yang paling berdampak (Jackson dkk., 2022). Menurut (Payne dkk., 2025) meskipun ada upaya digitalisasi seperti inisiatif SATUSEHAT, integrasi data

yang efektif masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Selain itu, sistem rujukan dan data yang terfragmentasi di Indonesia menghambat integrasi layanan antara sektor publik dan swasta, serta antara tingkat perawatan primer, sekunder, dan tersier (Payne dkk., 2025).

Rekomendasi untuk implementasi model *collaborative care* di Indonesia dapat dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, pendekatan terdesentralisasi, dan adanya kebijakan yang mendukung implementasi model ini. Menurut (Payne dkk., 2025) memperkuat integrasi data melalui platform SATUSEHAT untuk mendukung koordinasi layanan. Memberikan pelatihan khusus untuk tenaga kesehatan dalam kolaborasi interpersonal dan penggunaan teknologi digital (Jackson dkk., 2022; Soemantri dkk., 2019). Memanfaatkan jaringan puskesmas dan pos kesehatan desa untuk memperluas akses layanan berbasis kolaborasi (Payne dkk., 2025). Mendorong kebijakan yang mendukung model perawatan kolaboratif, termasuk finansial dan panduan operasional (Prasetyo, 2025).

H. Penutup

Implementasi model dalam pelayanan yang telah diterapkan yaitu implementasi model asuhan keperawatan berbasis *evidence-based nursing* dalam pelayanan klinis, model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan keperawatan komunitas, model *transcultural nursing* dalam pelayanan keperawatan, dan model *continuity of care* dalam pelayanan keperawatan maternal dan anak, model *self care* dalam manajemen penyakit kronis, dan model *collaborative care* dalam sistem pelayanan kesehatan.

Implementasi EBN di Indonesia secara signifikan dapat meningkatkan kualitas perawatan klinis. Namun, mengatasi hambatan seperti keterbatasan pengetahuan, kendala sumber daya, dan tantangan organisasi sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan, dukungan kepemimpinan, dan kerangka kerja terstruktur untuk memajukan integrasi EBN ke dalam sistem kesehatan di Indonesia.

Model pemberdayaan keluarga dalam pelayanan komunitas dapat meningkatkan status kesehatan diberbagai populasi di Indonesia. Namun, tantangan seperti hambatan budaya, keterbatasan sumber daya, dan masalah dokumentasi perlu diatasi untuk mengoptimalkan implementasi dan keberlanjutannya.

Model keperawatan transkultural sangat penting untuk memberikan perawatan yang kompeten secara budaya. Model ini membimbing perawat dalam mengatasi kesenjangan kesehatan dan mendorong status kesehatan pasien di

berbagai lingkungan perawatan kesehatan. Diperlukan penguatan dalam pendidikan, pelatihan, dan dokumentasi keperawatan untuk memastikan perawatan yang lebih sesuai secara budaya.

Model *Continuity of Care* (CoC) di Indonesia telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas layanan maternal dan anak, terutama melalui pendekatan digital dan edukasi keluarga. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, literasi kesehatan yang rendah, dan kesenjangan layanan perlu diatasi melalui inovasi teknologi, kolaborasi multidisiplin, dan pelatihan tenaga kesehatan.

Model *self care* dalam manajemen penyakit kronis mencakup pendekatan bipsikososial, pemberdayaan pasien, dan dukungan teknologi. Implementasi yang terstruktur dan berpusat pada pasien dapat meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang kompleks.

Implementasi model *collaborative care* di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam mengelola penyakit kronis dan kesehatan mental. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada adaptasi terhadap konteks lokal, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor.

Referensi

- Acharya, B., Ekstrand, M., Rimal, P., Ali, M. K., Swar, S., Srinivasan, K., Mohan, V., Unützer, J., & Chwastiak, L. A. (2017). Collaborative care for mental health in low- and middle-income countries: A WHO health systems framework assessment of three programs. *Psychiatric Services*, 68(9), 870–872. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201700232>
- Adnani, Q. E. S., Nurfitriyani, E., Merida, Y., Khuzaiyah, S., Okinarum, G. Y., Susanti, A. I., Adepoju, V. A., & Hashim, S. H. (2025). Ninety-one years of midwifery continuity of care in low and middle-income countries: a scoping review. *BMC Health Services Research*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12612-0>
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Ahn, J.-W. (2017). Structural Equation Modeling of Cultural Competence of Nurses Caring for Foreign Patients. *Asian Nursing Research*, 11(1), 65–73. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2017.03.001>
- Akhriansyah, M., Ester, Langelo, W., Immawanti, Aji, R., Anugrah, A. K., Syarif, I., Dasat, M., Wiratikusuma, Y., Nulhakim, L., Budiawan, H., & Samiun, Z. (2023). *Keperawatan Keluarga*. Get Press Indonesia.
- Alligood, M. R. (2017). *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka* (A. Y. S. Hamid & K. Ibrahim, Ed.; 8th Indonesia, Vol. 1). Elsevier Singapore Pte Ltd.
- Amir, H., Chanafie, D., & Hastono, P. S. (2020). The Effect of Nursing Professional Practice Models Training Towards the Implementation of Element Management Approach and Element IV Nurse's Nursing Care Delivery System in X Hospital of Kotamobagu. *MPPKI*, 3(3), 168–178.
- Andrews, M. M., & Boyle, J. S. (2015). Transcultural concepts in nursing care. Dalam *Transcultural Concepts in Nursing Care*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84973425973&partnerID=40&md5=f54308186053608c774b1ca97c6758a8>
- Andriani, H., Rachmadani, S. D., Natasha, V., & Saptari, A. (2022). Continuum of care in maternal, newborn and child health in Indonesia: Evidence from the Indonesia Demographic and Health Survey. *Journal of Public Health Research*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/22799036221127619>
- Appulembang, I. (2025). Improving Glycemic Control Among Indonesian Urban Adults: A Digital and Behavioral Extension of the Information–Motivation–Behavioral Skills Model. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 20(4), 305–313. <https://doi.org/10.7454/kesmas.v20i4.2459>

- Arrini, M. N., Putri Pertiwi, A. A., & Noviana, U. (2023). The Application of Mataraman Javanese Manners in Patient Care. *Journal of Transcultural Nursing*, 34(3), 181–186. <https://doi.org/10.1177/10436596231152217>
- Asmirajanti, M., Hamid, A. Y. S., & Hariyati, R. T. S. (2019). Supporting factors of the implementation of clinical pathway approach in nursing care. *Enfermeria Clinica*, 29, 455–458. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.067>
- Austin, C. (2023). The impact of social determinants of health of Australian Indigenous women on access and engagement in maternal child health services. *Journal of Advanced Nursing*, 79(5), 1815–1829. <https://doi.org/10.1111/jan.15493>
- Barimani, M., & Hylander, I. (2012). Joint action between child health care nurses and midwives leads to continuity of care for expectant and new mothers. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 7. <https://doi.org/10.3402/qhw.v7i0.18183>
- Cahyadi, F. A., Agwa, M. M., & Ghozali, M. T. (2025). Telecommunication-Enabled mHealth Intervention: Evaluating the Effect of a Medication Reminder App on Adherence Among Hypertensive Patients. *ICE3IS 2025 - Conference Proceedings: 5th International Conference on Electronic and Electrical Engineering and Intelligent System*, 344–348. <https://doi.org/10.1109/ICE3IS66769.2025.11280922>
- Chen, M.-J., Tang, C.-H., Jeng, H.-M., & Chiu, A. W.-H. (2008). The maternal and child healthcare needs of new immigrants in Taipei. *Journal of Nursing Research*, 16(4), 307–320. <https://doi.org/10.1097/01.JNR.0000387318.50880.b5>
- Cleek, E. N., Wofsy, M., Boyd-Franklin, N., Mundy, B., & Howell, T. J. (2012). The Family Empowerment Program: An Interdisciplinary Approach to Working with Multi-Stressed Urban Families. *Family Process*, 51(2), 207–217. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2012.01392.x>
- Cordo, J., & Hill-Rodriguez, D. (2017). The Evolution of a Nursing Professional Practice Model Through Leadership Support of Clinical Nurse Engagement, Empowerment, and Shared Decision Making. *Nurse Leader*, 15(5), 325–330. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2017.07.009>
- Cummins, A., Coddington, R., Fox, D., & Symon, A. (2020). Exploring the qualities of midwifery-led continuity of care in Australia (MiLCCA) using the quality maternal and newborn care framework. *Women and Birth*, 33(2), 125–134. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.03.013>
- Cummins, A., Griew, K., Devonport, C., Ebbett, W., Catling, C., & Baird, K. (2022). Exploring the value and acceptability of an antenatal and postnatal midwifery continuity of care model to women and midwives, using the Quality Maternal Newborn Care Framework. *Women and Birth*, 35(1), 59–69. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.03.006>
- Darmawan, F. H., Wirakusumah, F. F., Rinawan, F. R., Purbasari, A., & Widiyanti, R. (2025). Effectiveness of Digital-Based Continuity of Midwifery Care on Client Satisfaction

- in West Java, Indonesia. *Malaysian Journal of Nursing*, 16, 39–46. <https://doi.org/10.31674/mjn.2025.v16isupp2.005>
- Djerubu, D., Mariati, L. H., Dewi, C. F., & Eka, A. R. (2024). Transcultural Nursing Factor Related to Self-efficacy of People with Hypertension in Remote Area of Indonesia. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 20, 43–47. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85209155132&partnerID=40&md5=a29818952a9d85c4845c065af30d9e32>
- Eghaneyan, B. H., Sanchez, K., & Mitschke, D. B. (2014). Implementation of a collaborative care model for the treatment of depression and anxiety in a community health center: Results from a qualitative case study. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 7, 503–513. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S69821>
- Ekawati, F. M., Muchlis, M., & Tuteja, A. (2023). Adopting international recommendations to design a model for maternal health service to cope with pandemic disruption for Indonesian primary care. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05433-8>
- Enestvedt, R. C., Clark, K. M., Freborg, K., Miller, J. P., Leuning, C. J., Schuhmacher, D. K., McHale, K. M., Baumgartner, K. A., & Loushin, S. L. (2018). Caring in the Margins: A Scholarship of Accompaniment for Advanced Transcultural Nursing Practice. *Advances in Nursing Science*, 41(3). https://journals.lww.com/advancesinnursingscience/fulltext/2018/07000/caring_in_the_margins__a_scholarship_of.5.aspx
- Febriani, E., Wibowo, A., Kak, N., & Al-Mossawi, H. J. (2021). Empowering health cadres to support drug-resistant tuberculosis (DR-TB) patient to enroll in treatment. *Kesmas*, 16(2), 84–90. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V16I2.3307>
- Febriyanti, R. M., Irawan, A. A., Anggriani, N., Andriyana, Y., & Abdulah, R. (2025). Challenges in implementing Indonesia's community-based chronic disease management program (Prolanis): A scoping review. *AIMS Public Health*, 12(3), 890–915. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2025045>
- Fox, D., Scarf, V., Turkmani, S., Rossiter, C., Coddington, R., Sheehy, A., Catling, C., Cummins, A., & Baird, K. (2023). Midwifery continuity of care for women with complex pregnancies in Australia: An integrative review. *Women and Birth*, 36(2), e187–e194. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2022.07.001>
- Friesen-Storms, J. H. H. M., Beurskens, A. J. H. M., & Bours, G. J. J. W. (2017). Teaching and implementing evidence-based practice in a hospital unit with secondary vocational trained nurses: Lessons learned. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 48(9), 407–412. <https://doi.org/10.3928/00220124-20170816-06>
- Giger, J. N., & Haddad, L. G. (2020). Transcultural Nursing. Dalam *Transcultural Nursing: Assessment and Intervention*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105032634634&partnerID=40&md5=3fdd19f988277ab4933b600bd0fdd056>

- Goodrich, D. E., Kilbourne, A. M., Nord, K. M., & Bauer, M. S. (2013). Mental health collaborative care and its role in primary care settings. *Current Psychiatry Reports*, 15(8). <https://doi.org/10.1007/s11920-013-0383-2>
- Graves, K. N., & Shelton, T. L. (2007). Family Empowerment as a Mediator Between Family-Centered Systems of Care and Changes in Child Functioning: Identifying an Important Mechanism of Change. *Journal of Child and Family Studies*, 16(4), 556–566. <https://doi.org/10.1007/s10826-006-9106-1>
- Has, E. M. M., Nursalam, & Arief, Y. S. (2023). Improving complementary feeding practice and child growth in Indonesia through family empowerment intervention. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 73(2), S7–S12. <https://doi.org/10.47391/JPMA.Ind-S2-2>
- Homer, C. S. (2016). Models of maternity care: Evidence for midwifery continuity of care. *Medical Journal of Australia*, 205(8), 370–374. <https://doi.org/10.5694/mja16.00844>
- Huang, Y., Liu, Y., Wang, Y., & Huang, M. (2023). Research progress of the Common-Sense Model of Self-Regulation in the management of chronic diseases. *Chinese Journal of Nursing*, 58(18), 2293–2298. <https://doi.org/10.3761/j.issn.0254-1769.2023.18.018>
- Hulme, P. A. (1999). Family Empowerment: A Nursing Intervention with Suggested Outcomes for Families of Children with a Chronic Health Condition. *Journal of Family Nursing*, 5(1), 33–50.
- Hustrini, N. M., Susalit, E., van Diepen, M., & Rotmans, J. I. (2026). Perceived barriers to management of patients with diabetes mellitus and hypertension in primary care centers in Indonesia. *Frontiers in Health Services*, 5. <https://doi.org/10.3389/frhs.2025.1715125>
- Irawan, E., Murtiningsih, Anto, A., Dirdjo, M. M., Manoppo, I. A., Riyana, A., Mukaromah, R. S., Rahman, I., Sihombing, F., Yulis, R., Idris, M., Harianto, J. W., Imallah, R. N., Kurniasih, E., Purdani, K. S., Burhanto, Mouliansyah, R., Wardhani, I. K., Kurnia, A., ... Nurdianti, R. (2026). *Buku Ajar Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2024)*. CV Eureka Media Aksara.
- Jackson, J., Dangal, R., Dangal, B., Gupta, T., Jirel, S., Khadka, S., Rimal, P., & Acharya, B. (2022). Implementing Collaborative Care in Low-Resource Government, Research, and Academic Settings in Rural Nepal. *Psychiatric Services*, 73(9), 1073–1076. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.202100421>
- James, J. L. (2025). Effectiveness and Challenges of Integrated Care Models in Managing Mental Health in Chronic Illness and Disability: A Literature Review. *Undergraduate Research in Natural and Clinical Science and Technology Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.26685/urncst.780>

- Juniarti, N., & Fuller, J. (2025). Strategies to enhance the integration of health services, education, research and community engagement within the Nursing Center Model. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 13(2), 115–119. <https://doi.org/10.24198/jkp.v13i2.2888>
- Karataş, P., Çalışır, H., & Sarikaya Karabudak, S. (2020). Ailenin Güçlendirilmesi ve Pediatri Hemşireliğinde Uygulanması. *Deuhfed*, 13(3), 200–205. <http://www.deuhyoedergi.org>
- Khasanah, U., Kelliat, B. A., Afiyanti, Y., Besral, B., & Sari, D. W. (2024). The Problems and Needs of Self-Management Among Indonesian Older Adults With Hypertension: A Qualitative Study. *SAGE Open Nursing*, 10. <https://doi.org/10.1177/23779608241282915>
- Krutter, S., Schuessler, N., Kutschar, P., Šabić, E., Dellinger, J., Klausner, T., Nestler, N., Beasley, M., Henderson, B., Pitzer, S., Mitterlehner, B., Langegger, D., Winkler, A., Kloesch, M., Ebl-Maurer, R., Van Der Zee-Neuen, A., & Osterbrink, J. (2022). Piloting of the virtual telecare technology Addison Care' to promote self-management in persons with chronic diseases in a community setting: protocol for a mixed-methods user experience, user engagement and usability pilot study. *BMJ Open*, 12(9). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062159>
- Kuo, Y.-H. (2024). Theory and Practice of Empowerment for Family Members of Patients Under Custodial Protection Sentence. *Journal of Nursing*, 71(1), 99–104. [https://doi.org/10.6224/JN.202402_71\(1\).12](https://doi.org/10.6224/JN.202402_71(1).12)
- Kurnia, A. D., Amatayakul, A., & Karuncharernpanit, S. (2017). Predictors of diabetes self-management among type 2 diabetics in Indonesia: Application theory of the health promotion model. *International Journal of Nursing Sciences*, 4(3), 260–265. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2017.06.010>
- Lahijani, S., & Rosenthal, L. J. (2015). Insights from collaborative care: A review of the evidence for depression and diabetes. *Psychiatric Annals*, 45(8), 401–405. <https://doi.org/10.3928/00485713-20150803-04>
- Lazuardi, L., Sanjaya, G. Y., Ali, P. B., Siahaan, R. G. M., Achmad, L., & Wulandari, H. (2021). Interoperability of Health Digitalization: Case Study on Use of Information Technology for Maternal and Child Health Services in Indonesia. *Business Information Systems*, 1, 317–327. <https://doi.org/10.52825/bis.v1i.53>
- Ligita, T., Nurbianti, S., Yulanda, N. A., Pramana, Y., Saputri, C. K., & Kumala, E. E. M. (2024). Preceptors' experiences in guiding nursing students to use research findings and to implement evidence-based practice. *Frontiers of Nursing*, 11(3), 313–317. <https://doi.org/10.2478/fon-2024-0034>
- Mailani, F., Huriani, E., & Muthia, R. (2023). Self-Management and Relating Factors among Chronic Kidney Disease Patients on Hemodialysis: An Indonesian Study. *Nurse Media Journal of Nursing*, 13(1), 109–120. <https://doi.org/10.14710/nmjn.v13i1.48708>

- Maksum, E., Haroen, H., Satuhu, N. R., Rahayu, S., & Herawati, A. (2026). Analysis of The Implementation of Nursing Care and Exposure To 3s (Sdki, Slki, Siki) Ppni Community Area for Bandung City Health Center Nurses. *Social Medicine*, 19(1), 105–110. <https://doi.org/10.71164/socialmedicine.v19i1.2026.2073>
- Mar'atus Sholikhah, S., Nurwulansari, F., Aini, E. N., Wardoyo, S., & Pramudita, J. J. (2025). The role of continuity of care in high-risk pregnant women in Indonesia. *European Journal of Midwifery*, 9(January), 1–6. <https://doi.org/10.18332/ejm/195831>
- Matzke, G. R., Moczygembka, L. R., Williams, K. J., Czar, M. J., & Lee, W. T. (2018). Impact of a pharmacist-physician collaborative care model on patient outcomes and health services utilization. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 75(14), 1039–1047. <https://doi.org/10.2146/ajhp170789>
- Middlemiss, A. L., Channon, S., Sanders, J., Kenyon, S., Milton, R., Prendeville, T., Barry, S., Strange, H., & Jones, A. (2024). Barriers and facilitators when implementing midwifery continuity of carer: a narrative analysis of the international literature. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06649-y>
- Nair, D., Cukor, D., Taylor, W. D., & Cavanaugh, K. L. (2021). Applying A Biopsychosocial Framework to Achieve Durable Behavior Change in Kidney Disease. *Seminars in Nephrology*, 41(6), 487–504. <https://doi.org/10.1016/j.semnephrol.2021.10.002>
- Narulita, S., Mustikowati, T., Hijriati, Y., Marianna, S., Setyaningsih, W., & Subu, M. A. (2025). Experiences and Perspectives of Indonesian Nurses on Barriers and Facilitators for Implementing Evidence-Based Nursing Practice: A Qualitative Study. *Malaysian Journal of Nursing*, 16(4), 208–217. <https://doi.org/10.31674/mjn.2025.v16i04.020>
- Nitbani, Y. E., Jati, S. P., & Shaluhiah, Z. (2022). Evaluasi Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas di Indonesia: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 5(6), 662–670. <https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3>
- Novrianda, D., & Fajria, L. (2022). Comparing Learning Media on Evidence-Based Practice Program for Nurses: A Quasi-Experimental Study. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 18, 8–14. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85144141630&partnerID=40&md5=3ec784aaefd56f7df01fc56917dc6cad>
- Nur'ainun, & Novieastari, E. (2019). Students' ability in delivering transcultural nursing linked to their place of origin: A cross-sectional study. *Enfermería Clínica*, 29, 556–559. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.086>
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis* (5 ed.). Salemba Medika.
- Palimbo, A., Salmah, A. U., Amiruddin, R., & Syam, A. (2021). An overview of the implementation of the continuity of care model in maternal health services: A

- literature review. *Gaceta Sanitaria*, 35, S388–S392. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.058>
- Payne, S., Ross, J., Kartika, M. P., Rosas, A. D., Dewi, S., Hirschhorn, L. R., & Bitton, A. (2025). PCIPHC: Indonesia Case Study: Pursuing Person-Centered Primary Care in a Decentralized Health System: Indonesia's Efforts to Strengthen Primary Healthcare Services Through Integrated Networks at the Community Level. Dalam *People-Centered Integrated Primary Healthcare System Development in Asia and Beyond* (hlm. 187–230). https://doi.org/10.1142/9789819807468_0007
- Prabowo, B., Wardani, R., Dian, A., & Suwanto, S. (2025). Determinants of Family Empowerment and Complementary Feeding Quality: Evidence from a Transcultural Care Framework. *Healthcare (Switzerland)*, 13(17). <https://doi.org/10.3390/healthcare13172237>
- Prasetyo, N. T. (2025). Exploring Patient-Centered Care Implementation in Indonesian Hospitals: Insights from a Literature Review. *Hospital Topics*. <https://doi.org/10.1080/00185868.2025.2527721>
- Probandari, A., Arcita, A., Kothijah, K., & Pamungkasari, E. P. (2017). Barriers to utilization of postnatal care at village level in Klaten district, central Java Province, Indonesia. *BMC Health Services Research*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2490-y>
- Psaila, K., Schmied, V., Fowler, C., & Kruske, S. (2014). Discontinuities between maternity and child and family health services: Health professional's perceptions. *BMC Health Services Research*, 14. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-4>
- Pujiastuti, R. S. E., Rianti, E., Umami, H., & Kusuma, A. H. (2026). Ethno-nursing skills in multicultural nursing practice: A systematic literature review. *Multidisciplinary Reviews*, 9(8). <https://doi.org/10.31893/multirev.2026377>
- Putri, D. M. P., Suhoyo, Y., Pertiwi, A. A. P., & Effendy, C. (2022). Integrated Diabetes Self-Management (IDSM) mobile application to improve self-management and glycemic control among patients with Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) in Indonesia: A mixed methods study protocol. *PLoS ONE*, 17(11 November). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277127>
- Rachmawati, S., Prihastuti-Puspitasari, H., & Zairina, E. (2020). The implementation of a chronic disease management program (Prolanis) in Indonesia: A literature review. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology*, 30(6). <https://doi.org/10.1515/jbcpp-2019-0350>
- Rachmawaty, R., Wahyudin, E., & Bukhari, A. (2025). Exploring patient's clinical outcomes, hospital costs, and satisfaction after the implementation of integrated clinical pathway-based nursing practice model. *Cost Effectiveness and Resource Allocation*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12962-025-00645-5>

- Rammohan, A., Goli, S., & Chu, H. (2024). Continuum of care in maternal and child health in Indonesia. *Primary Health Care Research and Development*, 25. <https://doi.org/10.1017/S1463423624000094>
- Reist, C., Petiwala, I., Latimer, J., Raffaelli, S. B., Chiang, M., Eisenberg, D., & Campbell, S. (2022). Collaborative mental health care A narrative review. *Medicine (United States)*, 101(52). <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000032554>
- Riasmini, N. M., Sahar, J., Supartini, Y., & Maryam, R. S. (2019). Independent family group model improving health status and quality of life of elderly in the community. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(12), 1930–1934. <https://doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/192152>
- Rondhianto, R. (2020a). Path analysis of the influence of nurses role on family caregiver diabetes self-management capabilities with empowerment as intervening variables in Indonesia. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(2), 571–579. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088618617&partnerID=40&md5=0ec821ff2a11e55933da6f013f354e8f>
- Rondhianto, R. (2020b). Path analysis of the influence of nurses role on family caregiver diabetes self-management capabilities with empowerment as intervening variables in Indonesia. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(2), 571–579. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088618617&partnerID=40&md5=0ec821ff2a11e55933da6f013f354e8f>
- Sagar, P. L., & Sagar, D. Y. (2018). Current state of transcultural nursing theories, models, and approaches. Dalam *Annual Review of Nursing Research, Volume 37: Transcultural and Social Research* (hlm. 25–42). <https://doi.org/10.1891/0739-6686.37.1.25>
- Salamung, N., Pertiwi, M. R., Ifansyah, M. N., Riskika, S., Maurida, N., Suhariyati, Primasari, N. A., Rasiman, N. B., Maria, D., & Rumbo, H. (2021). *Keperawatan Keluarga (Family Nursing)*. Duta Media Publishing.
- Sampeangin, H., Wulandari, C. I., Sudrajat, D. A., Rejeki, Y. F., Saefulloh, M., Sihombing, F., Wati, I. M., Bintan, F., Damayanti, L. T., Rizany, I., Riyana, A., Rodinih, Dewi, L. P., Makausi, E., Rohayani, L., Supriyati, Lestari, A. D., Dirdjo, M. M., & Manoppo, I. A. (2025). *Buku Referensi Manajemen Ruang Perawatan*. CV Eureka Media Aksara.
- Sanchez, K. (2017). Collaborative care in real-world settings: Barriers and opportunities for sustainability. *Patient Preference and Adherence*, 11, 71–74. <https://doi.org/10.2147/PPA.S120070>
- Sarfika, R., Afriyanti, E., & Yanuar Saifudin, I. M. M. (2023). Self-care behavior among adult patients with hypertension in Padang, West Sumatra, Indonesia: A cross-sectional study. *Belitung Nursing Journal*, 9(6), 595–602. <https://doi.org/10.33546/bnj.2915>
- Setiawan, A., Dignam, D., Waters, C., & Dawson, A. (2016). Improving Access to Child Health Care in Indonesia Through Community Case Management. *Maternal and*

- Child Health Journal*, 20(11), 2254–2260. <https://doi.org/10.1007/s10995-016-2149-z>
- Soemantri, D., Kambey, D. R., Yusra, R. Y., Timor, A. B., Khairani, C. D., Setyorini, D., & Findyartini, A. (2019). The supporting and inhibiting factors of interprofessional collaborative practice in a newly established teaching hospital. *Journal of Interprofessional Education and Practice*, 15, 149–156. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2019.03.008>
- Straub, L., & Thekkekandam, M. (2023). Chronic Disease Self-Management. Dalam *Chronic Illness Care: Principles and Practice, Second Edition* (hlm. 61–69). https://doi.org/10.1007/978-3-031-29171-5_5
- Subrata, S. A. (2021). The nursing outlook of the self- and family management support programs among Indonesian with diabetes: An umbrella review. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, 15(1), 109–119. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.12.018>
- Sulidah, S., & Hananti, W. L. (2024). Application of family nursing documentation in Tarakan City, Indonesia. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 12(3). <https://doi.org/10.4081/hls.2024.11949>
- Sumiati, S., Suwanto, S., Wardani, R., & Wahyuningsih, A. S. (2025). Integrating Family Support and Personal Counseling in a Behavioral Model for Tuberculosis Prevention. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(12), 1538–1547. <https://doi.org/10.56338/mppki.v8i12.8665>
- Susanti, D., Machmud, R., Nursal, D. G. A., Maputra, Y., & Hasnita, E. (2023). Comparing Continuity of Midwifery Care Model with the Mother-Child Health Book: Enhancing Knowledge for Adolescent Pregnancy in Indonesia. *Open Public Health Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.2174/0118749445278067231108064225>
- Symon, A., McFadden, A., White, M., Fraser, K., & Cummins, A. (2019). Using the Quality Maternal and Newborn Care Framework to evaluate women's experiences of different models of care: A qualitative study. *Midwifery*, 73, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.03.002>
- Tambunan, E. S. (2025). Assessment of Continuity of Care Policies Implementation for Low-Birth-Weight Infants in DKI Jakarta: A Nursing Perspective. *Malaysian Journal of Nursing*, 17(1), 65–75. <https://doi.org/10.31674/mjn.2025.v17i01.007>
- Tian, L., Yang, Y., Sui, W., Hu, Y., Li, H., Wang, F., Qian, K., Ji, J., & Tao, M. (2017). Implementation of evidence into practice for cancer-related fatigue management of hospitalized adult patients using the PARIHS framework. *PLoS ONE*, 12(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187257>
- Timoteo, F. P. N., da Silva, R. M. M., Manfrini, G. C., & Baggio, M. A. (2023). Cross-cultural Care in Primary Health Care Nurse's Experience in Border Territories. *Texto e Contexto Enfermagem*, 32. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2022-0250en>

- Whitfield, J., Owens, S., Bhat, A., Felker, B., Jewell, T., & Chwastiak, L. (2023). Successful ingredients of effective Collaborative Care programs in low- and middle-income countries: A rapid review. *Global Mental Health*, 10. <https://doi.org/10.1017/gmh.2022.60>
- Wu, C.-C., & Lin, C.-C. (2014). Fusing empowerment concept into patient-centered collaborative care model. *Journal of Nursing*, 61(6), 87–92. <https://doi.org/10.6224/JN.61.6.87>
- Xue, C., Ma, W., Teng, H., & Liu, H. (2022). Methods of development of model Applied to nursing research. *Chinese Journal of Practical Nursing*, 38(33), 2637–2641. <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn211501-20211206-03352>
- Yokoyama, Y., Ogata, Y., Suzuki, K., Kanaoka, S., Furushou, K., Masuda, R., Horiuchi, S., Yamagata, Z., Kondo, N., & Silventoinen, K. (2024). Continuous Support from the Same Public Health Nurse and Parental Perception and Use of Health Care Services: A Retrospective Observational Study. *Maternal and Child Health Journal*, 28(10), 1726–1736. <https://doi.org/10.1007/s10995-024-03971-x>

Glosarium

E

Evidence-Based Nursing (EBN): adalah pendekatan terstruktur untuk mengintegrasikan bukti terbaik yang tersedia ke dalam praktik keperawatan klinis untuk meningkatkan status kesehatan pasien, meningkatkan kualitas perawatan, dan mendorong perawatan profesional.

F

Fragmentasi sistem kesehatan: adalah terpecah-pecahnya pelayanan dan pendanaan kesehatan menjadi subsistem-subsistem kecil yang tidak terkoordinasi dengan baik.

K

Keputusan hierarkis: adalah proses pengambilan keputusan yang disusun secara bertingkat berdasarkan wewenang, jabatan, atau struktur organisasi, di mana otoritas tertinggi berada di atas dan mengalir ke bawah.

T

Tantangan sistemik: adalah permasalahan mendasar yang berakar pada struktur, kebijakan, atau mekanisme suatu sistem secara keseluruhan, bukan sekadar faktor eksternal atau spesifik.

Terdesentralisasi: adalah sistem di mana kontrol, pengambilan keputusan, atau wewenang disebarkan ke berbagai unit atau node, bukan terpusat pada satu otoritas tunggal

BAB 7

ARAH PENGEMBANGAN MODEL KEPERAWATAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Pengembangan model keperawatan di Indonesia menjadi suatu kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit kronis, perubahan demografi, serta tuntutan kualitas pelayanan kesehatan, profesi keperawatan dituntut untuk mampu memberikan asuhan yang tidak hanya berbasis pengalaman, tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan yang terstruktur dan teruji secara ilmiah. Model keperawatan berperan sebagai kerangka konseptual yang memandu perawat dalam memberikan asuhan yang sistematis, terarah, dan konsisten, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Alligood, 2022; Fawcett & DeSanto-Madeya, 2017).

Dalam konteks Indonesia, sistem pelayanan kesehatan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, beban kerja perawat yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas pelayanan. Selain itu, kompleksitas kasus pasien, khususnya penyakit kronis seperti diabetes melitus dan penyakit degeneratif lainnya, menuntut pendekatan asuhan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Laporan global menunjukkan bahwa peningkatan penyakit tidak menular menjadi tantangan utama sistem kesehatan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia (World Health Organization, 2023). Di sisi lain, hambatan dalam penerapan praktik keperawatan berbasis bukti meliputi keterbatasan waktu, kurangnya akses terhadap hasil penelitian, serta rendahnya kemampuan literasi riset di kalangan perawat (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019; Saunders & Vehviläinen-Julkunen, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik keperawatan di Indonesia masih memerlukan penguatan baik dari aspek konseptual maupun implementatif.

Model keperawatan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Model yang dikembangkan secara sistematis mampu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan klinis, meningkatkan konsistensi praktik, serta memastikan bahwa asuhan yang diberikan sesuai dengan standar

profesional dan kebutuhan pasien. Selain itu, model keperawatan juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi dalam pelayanan keperawatan. Penggunaan model keperawatan yang tepat terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Alligood, 2022; McEwen & Wills, 2019).

Lebih lanjut, urgensi pendekatan berbasis riset atau **evidence-based nursing (EBN)** menjadi semakin penting dalam pengembangan model keperawatan di Indonesia. Evidence-based nursing merupakan pendekatan yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan asuhan keperawatan (Melnik & Fineout-Overholt, 2019). Pendekatan ini telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan (World Health Organization, 2023). Namun demikian, implementasi EBN di Indonesia masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam model keperawatan yang aplikatif dan kontekstual.

Dengan demikian, pengembangan model keperawatan berbasis riset di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional. Model yang dikembangkan diharapkan mampu mengakomodasi nilai budaya lokal, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi kesehatan, sehingga dapat menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa kini dan masa depan.

B. Konsep Dasar Model Keperawatan

1. Definisi Model Keperawatan

Model keperawatan merupakan representasi konseptual yang menggambarkan struktur, hubungan, dan pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan. Model ini berfungsi sebagai panduan bagi perawat dalam memahami fenomena keperawatan serta dalam memberikan asuhan yang terarah dan terstandar. Menurut Alligood (2022), model keperawatan adalah kerangka kerja yang mengorganisasikan konsep-konsep utama dalam keperawatan sehingga dapat digunakan untuk memandu praktik, pendidikan, dan penelitian. Sementara itu, Fawcett dan DeSanto-Madeya (2017) menyatakan bahwa model keperawatan merupakan struktur konseptual yang mengintegrasikan berbagai konsep dan proposisi untuk menjelaskan fenomena keperawatan secara sistematis.

Dengan demikian, model keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai alat konseptual, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis, pengembangan intervensi, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan. Model yang baik harus mampu menjelaskan hubungan antara perawat, pasien, lingkungan, dan kesehatan secara komprehensif (McEwen & Wills, 2019).

2. Komponen Utama Model Keperawatan (Konsep, Asumsi, Proposisi)

Model keperawatan dibangun atas beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu konsep, asumsi, dan proposisi.

a. Konsep (Concepts)

Konsep merupakan elemen dasar dalam model keperawatan yang mewakili fenomena atau ide yang menjadi fokus perhatian dalam praktik keperawatan. Konsep utama dalam keperawatan umumnya meliputi manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan itu sendiri (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2017). Konsep-konsep ini membantu perawat dalam memahami kondisi pasien secara holistik.

b. Asumsi (Assumptions)

Asumsi adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan pembuktian langsung, yang menjadi dasar dalam pengembangan model. Asumsi dalam keperawatan sering kali berkaitan dengan pandangan tentang manusia sebagai makhluk holistik, kemampuan adaptasi individu, serta interaksi antara individu dan lingkungannya (Alligood, 2022).

c. Proposisi (Propositions)

Proposisi merupakan pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih konsep dalam model keperawatan. Proposisi memberikan arah dalam memahami bagaimana suatu intervensi keperawatan dapat memengaruhi kondisi pasien. Dengan adanya proposisi, model keperawatan menjadi lebih aplikatif dalam praktik klinis (McEwen & Wills, 2019).

Ketiga komponen ini saling terintegrasi dan membentuk struktur yang utuh dalam suatu model keperawatan, sehingga memungkinkan penerapan yang sistematis dan berbasis ilmiah.

3. Perbedaan Model, Teori, dan Kerangka Konsep

Dalam ilmu keperawatan, istilah model, teori, dan kerangka konsep sering digunakan secara bergantian, namun ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar. Model keperawatan merupakan representasi luas yang menggambarkan keseluruhan pandangan tentang praktik keperawatan. Model

bersifat lebih umum dan memberikan kerangka besar dalam memahami fenomena keperawatan (Alligood, 2022).

Teori keperawatan adalah kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang lebih spesifik dan teruji secara empiris, yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena keperawatan. Teori memiliki tingkat abstraksi yang lebih rendah dibandingkan model dan lebih mudah diuji dalam penelitian (McEwen & Wills, 2019).

Sementara itu, kerangka konsep (conceptual framework) merupakan struktur yang disusun berdasarkan teori atau model tertentu untuk memandu penelitian atau praktik. Kerangka konsep biasanya digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2017).

Dengan demikian, model bersifat paling abstrak dan luas, teori lebih spesifik dan operasional, sedangkan kerangka konsep bersifat aplikatif dalam konteks tertentu, terutama dalam penelitian.

4. Fungsi Model dalam Praktik, Pendidikan, dan Penelitian

Model keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek profesi keperawatan, yaitu praktik, pendidikan, dan penelitian. Dalam praktik keperawatan, model berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan asuhan yang sistematis dan konsisten. Model membantu perawat dalam melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan secara terstruktur. Selain itu, model juga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih rasional dan berbasis bukti (Melnik & Fineout-Overholt, 2019).

Dalam pendidikan keperawatan, model digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran. Mahasiswa keperawatan diajarkan untuk memahami konsep dan teori keperawatan melalui model tertentu, sehingga memiliki kerangka berpikir yang jelas dalam praktik profesionalnya (Alligood, 2022).

Dalam penelitian keperawatan, model berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan hipotesis dan kerangka konsep penelitian. Model membantu peneliti dalam mengidentifikasi variabel yang relevan serta hubungan antar variabel, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan terarah (McEwen & Wills, 2019).

Dengan demikian, model keperawatan memiliki fungsi yang integral dalam pengembangan profesi keperawatan secara menyeluruh, baik dalam aspek praktik klinis, pendidikan, maupun penelitian.

C. Kondisi Eksisting Model Keperawatan di Indonesia

1. Implementasi Model Keperawatan di Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Komunitas)

Implementasi model keperawatan di Indonesia telah dilakukan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan berbasis komunitas. Di rumah sakit, model keperawatan umumnya diintegrasikan dalam proses asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi). Namun, penerapannya masih belum sepenuhnya optimal dan sering kali bersifat administratif dibandingkan konseptual.

Di tingkat puskesmas, penerapan model keperawatan mulai berkembang melalui integrasi pendekatan berbasis komunitas dan promotif-preventif. Misalnya, penerapan pendekatan *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)* dalam pelayanan lansia di puskesmas terbukti dapat mendukung deteksi dini risiko komplikasi, perencanaan intervensi yang lebih personal, serta kolaborasi lintas profesi, meskipun membutuhkan dukungan pelatihan dan sistem yang jelas (Yunara, 2024).

Sementara itu, dalam konteks komunitas, perawat memiliki peran penting dalam edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pencegahan penyakit. Namun, model keperawatan berbasis komunitas di Indonesia masih belum terstandarisasi secara nasional dan cenderung bergantung pada program-program pemerintah atau inisiatif lokal.

2. Adaptasi Model Internasional dalam Konteks Lokal

Sebagian besar praktik keperawatan di Indonesia masih mengadopsi model dan teori keperawatan internasional, seperti model adaptasi, model kebutuhan dasar, dan model sistem. Adaptasi ini dilakukan karena keterbatasan model keperawatan yang dikembangkan secara spesifik sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Namun demikian, proses adaptasi sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan nilai budaya, kearifan lokal, serta karakteristik masyarakat Indonesia. Padahal, faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kesehatan, perilaku pasien, serta keberhasilan intervensi keperawatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan model keperawatan yang lebih kontekstual dan berbasis lokal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan.

3. Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu permasalahan utama dalam praktik keperawatan di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam pendidikan keperawatan dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Studi menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep akademik dan implementasi klinis, yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan keperawatan (Pradana, 2022). Kesenjangan ini terjadi akibat beberapa faktor, antara lain keterbatasan waktu dalam praktik, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya dukungan sistem dalam penerapan teori keperawatan. Selain itu, rendahnya keterlibatan perawat dalam penelitian juga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya penerapan teori berbasis bukti dalam praktik klinis (Berek et al., 2024). Akibatnya, praktik keperawatan cenderung bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya berbasis pada model atau teori yang kuat, sehingga menghambat pengembangan profesionalisme perawat.

4. Tantangan dalam Penerapan Model Keperawatan (SDM, Kebijakan, dan Budaya)

Penerapan model keperawatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), kebijakan, maupun budaya. Dari aspek SDM, keterbatasan jumlah perawat serta tingginya beban kerja menjadi hambatan utama dalam implementasi model keperawatan berbasis bukti. Penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi serta kurangnya pelatihan menjadi faktor utama yang menghambat penerapan evidence-based nursing di rumah sakit (Indra, 2024). Selain itu, tingkat partisipasi perawat dalam penelitian masih relatif rendah, sehingga menghambat pengembangan praktik berbasis riset (Berek et al., 2024).

Dari aspek kebijakan, meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai regulasi terkait standar pelayanan kesehatan, implementasi di lapangan masih belum merata. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik sering terjadi akibat kurangnya pengawasan, evaluasi, serta dukungan sumber daya (Rina et al., 2023). Sementara itu, dari aspek budaya, masih terdapat paradigma praktik keperawatan yang berorientasi pada rutinitas dan tugas, bukan pada pendekatan berbasis model atau teori. Budaya kerja yang kurang mendukung inovasi dan riset juga menjadi hambatan dalam pengembangan model keperawatan yang lebih maju.

D. Konsep Landasan Pengembangan Model Keperawatan di Indonesia

Pengembangan model keperawatan di Indonesia perlu didasarkan pada landasan yang kuat dan kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang beragam. Landasan ini mencakup aspek budaya, sistem kesehatan nasional, standar praktik profesional, pendekatan holistik, serta pemanfaatan teknologi digital. Integrasi berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan model keperawatan yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

1. Nilai Budaya dan Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang tinggi, sehingga nilai budaya dan kearifan lokal menjadi faktor penting dalam pengembangan model keperawatan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, serta kepercayaan terhadap pengobatan tradisional memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, model keperawatan yang dikembangkan perlu mengakomodasi aspek budaya tersebut agar lebih mudah diterima dan efektif dalam praktik.

Pendekatan berbasis budaya juga sejalan dengan konsep *transcultural nursing*, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap nilai, keyakinan, dan praktik budaya pasien dalam pemberian asuhan keperawatan (Leininger & McFarland, 2006). Penelitian menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan pasien, kepuasan, serta hasil kesehatan secara keseluruhan (Purnell, 2018). Dengan demikian, pengembangan model keperawatan di Indonesia harus mengedepankan pendekatan berbasis budaya lokal sebagai bagian integral dari praktik keperawatan.

2. Sistem Kesehatan Nasional dan Kebijakan Pemerintah

Landasan penting lainnya dalam pengembangan model keperawatan adalah sistem kesehatan nasional dan kebijakan pemerintah. Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan transformasi sistem kesehatan, yang menekankan pada peningkatan akses, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Kebijakan ini memberikan arah bagi pengembangan praktik keperawatan, termasuk dalam hal standar pelayanan, penguatan layanan primer, serta integrasi pelayanan berbasis komunitas. Model keperawatan yang dikembangkan perlu selaras dengan kebijakan nasional agar dapat

diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi model keperawatan di lapangan (World Health Organization, 2023).

3. Standar Praktik Keperawatan Nasional (SDKI, SIKI, SLKI)

Pengembangan model keperawatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari standar praktik keperawatan nasional, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Ketiga standar ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan asuhan keperawatan yang sistematis, terukur, dan berbasis bukti.

SDKI digunakan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan, SIKI sebagai panduan dalam menentukan intervensi, dan SLKI untuk mengevaluasi hasil asuhan keperawatan (PPNI, 2017; PPNI, 2018; PPNI, 2019). Integrasi ketiga standar ini dalam model keperawatan akan meningkatkan kualitas dokumentasi, konsistensi praktik, serta akuntabilitas profesional perawat.

Selain itu, penggunaan SDKI, SIKI, dan SLKI juga mendukung implementasi evidence-based practice dalam keperawatan, sehingga model yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pendekatan Holistik: Bio-Psiko-Sosial-Spiritual

Pendekatan holistik merupakan salah satu landasan utama dalam praktik keperawatan, yang memandang manusia sebagai makhluk yang utuh dan kompleks. Dalam pendekatan ini, asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual.

Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama pada penyakit kronis dan kondisi terminal (Engel, 1977; Sulmasy, 2002). Dalam konteks Indonesia, aspek spiritual memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Oleh karena itu, model keperawatan yang dikembangkan perlu mengintegrasikan aspek spiritual sebagai bagian dari asuhan keperawatan yang komprehensif.

Dengan pendekatan holistik, perawat dapat memberikan asuhan yang lebih manusiawi, personal, dan sesuai dengan kebutuhan pasien secara menyeluruh.

5. Integrasi Teknologi dan Digital Health

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam praktik keperawatan. Integrasi teknologi dan *digital health* menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan model keperawatan di era modern.

Pemanfaatan teknologi seperti *electronic health records (EHR)*, *telehealth*, *mobile health (mHealth)*, serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta aksesibilitas pelayanan keperawatan (Topol, 2019; World Health Organization, 2021). Di Indonesia, transformasi digital kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi sistem kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Integrasi teknologi dalam model keperawatan juga membuka peluang untuk pengembangan inovasi, seperti aplikasi edukasi pasien, sistem deteksi dini penyakit, serta monitoring kesehatan berbasis digital. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses di beberapa wilayah.

E. Arah Pengembangan Model Keperawatan Indonesia

Pengembangan model keperawatan di Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Perubahan pola penyakit, kemajuan teknologi, serta tuntutan mutu pelayanan kesehatan menuntut adanya transformasi model keperawatan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berbasis praktik dan riset. Arah pengembangan ini mencakup beberapa pendekatan strategis sebagai berikut:

1. Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan *evidence-based practice* (EBP) menjadi fondasi utama dalam pengembangan model keperawatan modern. EBP mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan (Melnik & Fineout-Overholt, 2019).

Integrasi hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan mutu asuhan. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan akses terhadap penelitian dan rendahnya kemampuan literasi riset perawat. Oleh karena itu, penguatan literasi riset melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting (Saunders & Vehviläinen-Julkunen, 2016).

Selain itu, translasi ilmu ke praktik klinis (*knowledge translation*) perlu dikembangkan secara sistematis agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada

publikasi, tetapi dapat diimplementasikan dalam praktik nyata. Strategi ini terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (World Health Organization, 2023).

2. Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan model keperawatan yang kontekstual. Model berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan serta memperkuat hubungan antara perawat dan pasien.

Pengembangan model keperawatan berbasis budaya perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kekeluargaan, serta kepercayaan terhadap pengobatan tradisional. Integrasi pengobatan herbal, seperti pemanfaatan tanaman lokal dalam pengendalian penyakit kronis, menjadi salah satu bentuk inovasi yang relevan (Purnell, 2018).

Pendekatan komunitas dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam model ini, mengingat struktur sosial masyarakat Indonesia yang masih kuat berbasis keluarga. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien dan keberhasilan intervensi kesehatan (Leininger & McFarland, 2006).

3. Berbasis Teknologi dan Inovasi Digital

Transformasi digital kesehatan membuka peluang besar dalam pengembangan model keperawatan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *telehealth*, dan *mobile health (mHealth)* dapat meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan keperawatan (Topol, 2019; World Health Organization, 2021).

Pengembangan aplikasi keperawatan, seperti aplikasi edukasi pasien berbasis digital, memungkinkan pemberian asuhan yang lebih personal, interaktif, dan berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes melitus.

Selain itu, pemanfaatan *big data* dan sistem informasi keperawatan dapat mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas dokumentasi dan evaluasi asuhan keperawatan. Integrasi teknologi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di era digital.

4. Berbasis Patient-Centered Care

Pendekatan *patient-centered care* menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh proses pelayanan kesehatan. Model ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan, preferensi, dan nilai pasien dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan (Institute of Medicine, 2001).

Peningkatan partisipasi pasien dalam perawatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pendekatan ini. Pasien tidak lagi diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai mitra dalam proses penyembuhan. Selain itu, pendekatan personalisasi dan adaptif memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang disesuaikan dengan kondisi individu pasien, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi dan kepuasan pasien (McCormack & McCance, 2017).

5. Berbasis Interprofessional Collaboration

Kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi aspek penting dalam pengembangan model keperawatan yang terintegrasi. Kompleksitas masalah kesehatan saat ini membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi, seperti dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Model asuhan terintegrasi melalui tim multidisiplin terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan medis, serta meningkatkan keselamatan pasien (World Health Organization, 2010). Penguatan komunikasi dan koordinasi antar profesi menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan.

6. Berbasis Community dan Preventif-Promotif

Arah pengembangan model keperawatan di Indonesia juga perlu menekankan pada pendekatan komunitas serta upaya preventif dan promotif. Hal ini sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional yang menekankan penguatan pelayanan kesehatan primer. Perawat memiliki peran strategis dalam edukasi kesehatan masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta pencegahan penyakit. Model edukasi berbasis masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan serta mengurangi risiko penyakit kronis (World Health Organization, 2023).

Pencegahan penyakit kronis, seperti diabetes melitus, menjadi prioritas utama dalam model ini. Pendekatan edukasi, perubahan gaya hidup, serta pemanfaatan sumber daya lokal menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Arah pengembangan model

keperawatan di Indonesia harus bersifat multidimensional, mencakup pendekatan berbasis bukti, budaya lokal, teknologi digital, patient-centered care, kolaborasi interprofesional, serta pendekatan komunitas. Integrasi berbagai pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan model keperawatan yang inovatif, kontekstual, dan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

F. Strategi Implementasi Pengembangan Model

Implementasi pengembangan model keperawatan di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada aspek konseptual, tetapi juga mencakup penguatan sistem pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan pendanaan riset dan inovasi. Pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan model keperawatan berbasis riset di Indonesia.

1. Penguatan Kurikulum Pendidikan Keperawatan

Penguatan kurikulum pendidikan keperawatan merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa perawat memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Kurikulum perlu dirancang berbasis *evidence-based practice*, dengan menekankan pada kemampuan berpikir kritis, clinical reasoning, serta integrasi teori dan praktik.

Integrasi model keperawatan dalam kurikulum juga penting untuk membentuk pola pikir mahasiswa sejak dini, sehingga mereka mampu mengaplikasikan konsep dan teori dalam praktik klinis. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran inovatif seperti *problem-based learning* dan simulasi klinis terbukti dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pengambilan keputusan klinis (McEwen & Wills, 2019).

Penguatan kurikulum juga perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pelayanan kesehatan berbasis komunitas, sehingga lulusan keperawatan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan masa depan.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Perawat

Selain pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) menjadi strategi penting dalam meningkatkan kompetensi perawat. Pelatihan ini dapat mencakup peningkatan kemampuan

dalam evidence-based practice, penggunaan teknologi kesehatan, serta penerapan model keperawatan dalam praktik klinis.

Program pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan serta keselamatan pasien (Melnik & Fineout-Overholt, 2019). Selain itu, mentoring dan supervisi klinis juga berperan penting dalam memastikan bahwa perawat mampu mengimplementasikan model keperawatan secara konsisten.

Pengembangan kompetensi juga perlu didukung dengan sistem sertifikasi dan resertifikasi profesional untuk menjaga standar praktik keperawatan.

3. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Dukungan kebijakan dan regulasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi model keperawatan di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kebijakan kesehatan perlu memberikan arah yang jelas terkait standar praktik, sistem pelayanan, serta pengembangan profesi keperawatan.

Regulasi yang mendukung implementasi evidence-based practice, penggunaan teknologi kesehatan, serta penguatan pelayanan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan model keperawatan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi juga perlu dikembangkan untuk menilai efektivitas implementasi model di lapangan (World Health Organization, 2023). Kebijakan yang kuat dan konsisten akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan praktik keperawatan.

4. Kolaborasi Akademisi, Praktisi, dan Pemerintah

Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah merupakan strategi penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Akademisi berperan dalam menghasilkan penelitian dan pengembangan model, sementara praktisi bertanggung jawab dalam implementasi di lapangan. Pemerintah, di sisi lain, berperan dalam menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan.

Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sehingga model keperawatan yang dikembangkan lebih relevan dan aplikatif. Pendekatan kolaboratif juga mendukung pengembangan inovasi berbasis kebutuhan nyata di lapangan (WHO, 2010).

Selain itu, kemitraan dengan institusi internasional juga dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengembangan model keperawatan di Indonesia.

5. Pendanaan Riset dan Inovasi

Pendanaan merupakan aspek penting dalam pengembangan dan implementasi model keperawatan berbasis riset. Dukungan pendanaan diperlukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan model, uji coba implementasi, serta evaluasi hasil.

Investasi dalam riset keperawatan terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendorong inovasi dalam praktik keperawatan (Topol, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan alokasi dana untuk penelitian keperawatan, baik dari pemerintah, institusi pendidikan, maupun sektor swasta.

Selain itu, skema hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana dalam mengembangkan dan mengimplementasikan model keperawatan yang inovatif dan berkelanjutan. Strategi implementasi pengembangan model keperawatan di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, melibatkan penguatan pendidikan, peningkatan kompetensi, dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta pendanaan riset. Dengan strategi yang tepat, model keperawatan berbasis riset dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

G. Peluang dan Prospek Masa Depan

Perkembangan sistem kesehatan global dan nasional membuka peluang besar bagi pengembangan model keperawatan di Indonesia. Transformasi digital, dukungan kebijakan pemerintah, keterlibatan generasi perawat muda, serta kolaborasi internasional menjadi faktor kunci yang dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas praktik keperawatan di masa depan. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, model keperawatan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif, berbasis teknologi, dan berdaya saing global.

1. Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia

Transformasi digital kesehatan merupakan salah satu peluang terbesar dalam pengembangan model keperawatan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti *electronic health records (EHR)*, *telemedicine*, *mobile health (mHealth)*, serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah mengubah cara pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat.

Di Indonesia, transformasi digital kesehatan menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Teknologi

digital memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Selain itu, penggunaan teknologi digital juga mendukung pengembangan model keperawatan yang lebih inovatif, seperti pemantauan pasien secara real-time, edukasi kesehatan berbasis aplikasi, serta deteksi dini penyakit berbasis AI. Hal ini sejalan dengan rekomendasi global yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam sistem kesehatan modern (World Health Organization, 2021).

2. Dukungan Kebijakan Nasional (Transformasi Kesehatan)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan transformasi sistem kesehatan sebagai prioritas nasional, yang mencakup enam pilar utama, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi pengembangan model keperawatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dukungan regulasi yang kuat memungkinkan implementasi model keperawatan berbasis riset secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan nasional juga mendorong penguatan peran perawat dalam pelayanan kesehatan primer dan komunitas, yang menjadi fokus utama dalam sistem kesehatan modern (World Health Organization, 2023). Dengan adanya dukungan kebijakan, pengembangan model keperawatan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah.

3. Peran Generasi Perawat Muda

Generasi perawat muda memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan transformasi dalam praktik keperawatan. Generasi ini umumnya lebih adaptif terhadap perubahan, memiliki literasi digital yang tinggi, serta lebih terbuka terhadap pendekatan berbasis riset dan teknologi.

Keterlibatan perawat muda dalam penelitian, pengembangan inovasi, serta implementasi teknologi kesehatan dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan model keperawatan di Indonesia. Selain itu, generasi ini juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendekatan edukasi kesehatan yang lebih kreatif dan interaktif, terutama dalam penggunaan media digital.

Penguatan kapasitas generasi perawat muda melalui pendidikan, pelatihan, dan mentoring menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi mereka sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan.

4. Kolaborasi Global dan Internasional

Kolaborasi global dan internasional membuka peluang bagi pengembangan model keperawatan yang lebih berkualitas dan berstandar internasional. Melalui kerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian internasional, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) serta mengembangkan inovasi yang relevan dengan konteks lokal.

Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan penelitian keperawatan berbasis global. Organisasi seperti World Health Organization dan International Council of Nurses memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesi keperawatan melalui berbagai program dan kebijakan global.

Selain itu, publikasi ilmiah di jurnal internasional serta partisipasi dalam konferensi global juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan visibilitas dan kontribusi keperawatan Indonesia di tingkat dunia.

H. Kesimpulan

Pengembangan model keperawatan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang lebih sistematis, kontekstual, dan berbasis bukti. Berbagai arah pengembangan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa model keperawatan masa depan tidak dapat lagi bersifat konvensional, tetapi harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Integrasi pendekatan evidence-based practice, nilai budaya lokal, teknologi digital, patient-centered care, kolaborasi interprofesional, serta pendekatan komunitas menjadi fondasi utama dalam membangun model keperawatan yang relevan di Indonesia. Selain itu, dukungan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasinya.

Ke depan, peluang besar terbuka melalui transformasi digital kesehatan, peran generasi perawat muda, serta kolaborasi global yang dapat mempercepat inovasi dalam praktik keperawatan. Oleh karena itu, pengembangan model keperawatan berbasis riset harus terus didorong secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi

- Allgood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
- Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286), 129–136. <https://doi.org/10.1126/science.847460>
- Fawcett, J., & DeSanto-Madeya, S. (2017). *Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories* (3rd ed.). F.A. Davis.
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10027>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*.
- Leininger, M., & McFarland, M. R. (2006). *Culture care diversity and universality: A worldwide nursing theory* (2nd ed.). Jones & Bartlett.
- McCormack, B., & McCance, T. (2017). *Person-centred practice in nursing and health care: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley Blackwell.
- McEwen, M., & Wills, E. M. (2019). *Theoretical basis for nursing* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI)*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI)*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)*. DPP PPNI.
- Purnell, L. (2018). *Transcultural health care: A culturally competent approach* (5th ed.). F.A. Davis.
- Saunders, H., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2016). Nurses' evidence-based practice beliefs and the role of evidence-based practice mentors. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 13(5), 353–361. <https://doi.org/10.1111/wvn.12189>
- Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. *The Gerontologist*, 42(Suppl_3), 24–33. https://doi.org/10.1093/geront/42.suppl_3.24
- Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
- World Health Organization. (2010). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO.

World Health Organization. (2023). Noncommunicable diseases progress monitor 2023. World Health Organization.

World Health Organization. (2023). Strengthening primary health care through community-based approaches. World Health Organization.

Glosarium

Asuhan Keperawatan

Serangkaian tindakan yang dilakukan perawat secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien melalui proses keperawatan.

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis data dan mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan.

Big Data

Kumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks yang dianalisis untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan klinis.

Budaya (Culture)

Nilai, kepercayaan, dan praktik yang memengaruhi perilaku kesehatan individu atau kelompok.

Clinical Reasoning

Proses berpikir kritis dan analitis dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan data pasien.

Community-Based Nursing

Pendekatan keperawatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan komunitas.

Digital Health

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, seperti aplikasi kesehatan, telemedicine, dan sistem informasi.

Evidence-Based Nursing (EBN)

Pendekatan praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien.

Holistik (Holistic Care)

Pendekatan asuhan yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual secara menyeluruh.

Interprofessional Collaboration

Kerja sama antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi.

Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Nilai dan praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat dan digunakan dalam pendekatan kesehatan.

Kerangka Konsep (Conceptual Framework)

Struktur yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian atau praktik keperawatan.

Model Keperawatan

Kerangka konseptual yang digunakan untuk memandu praktik, pendidikan, dan penelitian keperawatan.

Mobile Health (mHealth)

Pemanfaatan perangkat mobile untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien.

Pendekatan Preventif

Upaya pencegahan penyakit sebelum terjadi melalui edukasi dan intervensi dini.

Pendekatan Promotif

Upaya peningkatan derajat kesehatan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Proposisi

Pernyataan yang menjelaskan hubungan antar konsep dalam suatu model keperawatan.

Proses Keperawatan

Metode sistematis dalam praktik keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia)

Standar nasional dalam penetapan diagnosis keperawatan di Indonesia.

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia)

Standar nasional dalam penentuan intervensi keperawatan.

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia)

Standar nasional dalam evaluasi hasil asuhan keperawatan.

Telehealth

Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi.

Teori Keperawatan

Kumpulan konsep dan proposisi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam keperawatan.

Transcultural Nursing

Pendekatan keperawatan yang mempertimbangkan aspek budaya pasien dalam pemberian asuhan.

PROFIL PENULIS



(Cicilia Nony Ayuningsih Bratajaya, S.Kep.,Ns.,MNS) Lahir di Bali, 02 November 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Sint Carolus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Kasetsart University Thailand dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sebagai perawat di Unit Rawat Inap RS Sint Carolus, kemudian menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Sint Carolus. Saat ini penulis bekerja di Universitas Medika Suherman mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Komunitas, dan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis memiliki kekhususan mengembangkan ilmu keperawatan dibidang soft skills perawat dan aplikasi keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: cicilia@medikasuherman.ac.id



Nurul Mawaddah, S.Kep.Ns., M.Kep.,

Lahir di Gresik, 13 April 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners lulus tahun 2009, di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Brawijaya lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009. Saat ini penulis bekerja di STIKES Majapahit Mojokerto mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai dosen, penulis buku, peneliti, publikasi, seminar, workshop, dan kegiatan pengabdian masyarakat, serta aktif pada berbagai organisasi profesi yaitu PPNI, IPKJI, dan IAKMI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mawaddah.ners@gmail.com

Motto: ""Terus Belajar, Berkarya, dan Memberikan Manfaat bagi Sesama""

PROFIL PENULIS



Anis Ika Nur Rohmah, S.Kep.,Ns.,M.Kep., Sp.Kep.MB. Lahir di Bantul, 15 April 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Spesialis pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah juga Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, publikasi, pengabdian, dan kegiatan ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anisikanur@umm.ac.id
Motto: "Man jadda wa jada"



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Doktorat pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019.

Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh. Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar [y2hhHCoAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=y2hhHCoAAAAJ). Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh. Adapun judul buku yang telah terbit: Profil Metabolik Remaja, Suami Siaga, Tips ibu hamil dan Pasca bersalin, Analisis Kepuasan pasien melalui Kinerja perawat di RS Pemerintah, Deteksi Dini Resiko Preeklampsia dan Inovasi Teknologi Kesehatan.

Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id

PROFIL PENULIS



Syamsul Alam Natsir, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Lahir di Jeneponto, 10 Februari 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Di UPTD Akper Anging Mammiri Propinsi Sulawesi Selatan, S1 di STIKes Gunung Sari Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2025 sebagai Dosen Tetap di STIK Indonesia Jaya Palu. Saat ini penulis bekerja di STIK Indonesia Jaya Palu mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syamsulalamnatsir95@gmail.com
Motto: "Living your life well"



Ns. Jelita Siska Herlina Hinonaung, S.Kep., M.Kep Lahir di Yogyakarta, 11 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sam Ratulangi. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai Dosen Tetap di Politeknik Negeri Nusa Utara. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: siskahinonaung@gmail.com
Motto: "hidup untuk menjadi berkat"

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep. merupakan dosen dan akademisi di bidang keperawatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) Keperawatan di Universitas Andalas (UNAND). Selanjutnya, penulis meraih gelar Doktor (S3) pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas, dengan fokus kajian pada pengembangan kesehatan masyarakat dan keperawatan berbasis promotif dan preventif serta metodologi penelitian.

Bidang keahlian dan minat riset penulis meliputi keperawatan pada penyakit degeneratif, promosi dan edukasi kesehatan, manajemen keperawatan, kesehatan masyarakat, serta pengembangan model edukasi dan intervensi keperawatan berbasis holistik dan teknologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas terutama pada penyakit degeneratif.

E-mail: febrianti160911@gmail.com

Sinopsis

Buku **“Pengembangan Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset di Indonesia”** merupakan buku referensi yang membahas secara komprehensif konsep, teori, pengembangan, validasi, serta implementasi model asuhan keperawatan yang berlandaskan penelitian dan bukti ilmiah. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan penguatan praktik keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada pengalaman klinis, tetapi juga didukung oleh kajian teoritis, hasil riset, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar pengembangan model dalam keperawatan, termasuk perbedaan model, teori, konsep, metaparadigma keperawatan, serta teori-teori model keperawatan. Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya integrasi teori dan praktik dalam pendidikan maupun pelayanan keperawatan, khususnya dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kesenjangan antara pembelajaran akademik dan praktik di lapangan. Berbagai model asuhan keperawatan klinik dan komunitas juga dibahas, termasuk penerapan *evidence-based practice*, dokumentasi keperawatan berbasis SDKI-SIKI-SLKI, integrasi teknologi, serta inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Selain membahas konsep dan penerapan, buku ini juga menekankan pentingnya validasi dan uji model asuhan keperawatan berbasis riset agar model yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah, relevan, dan dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Berbagai contoh implementasi model, seperti *evidence-based nursing*, pemberdayaan keluarga, *transcultural nursing*, *continuity of care*, *self-care*, dan *collaborative care* turut disajikan untuk memperkaya pemahaman pembaca. Pada bagian akhir, buku ini mengulas arah pengembangan model keperawatan Indonesia, mulai dari kondisi eksisting, landasan pengembangan, strategi implementasi, hingga peluang masa depan.

Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti, praktisi, manajer pelayanan kesehatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan mutu layanan keperawatan. Dengan pendekatan berbasis riset dan konteks Indonesia, buku ini diharapkan menjadi rujukan dalam menciptakan model asuhan keperawatan yang inovatif, aplikatif, berbudaya, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Buku “Pengembangan Model Asuhan Keperawatan Berbasis Riset di Indonesia” merupakan buku referensi yang membahas secara komprehensif konsep, teori, pengembangan, validasi, serta implementasi model asuhan keperawatan yang berlandaskan penelitian dan bukti ilmiah. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan penguatan praktik keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada pengalaman klinis, tetapi juga didukung oleh kajian teoritis, hasil riset, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar pengembangan model dalam keperawatan, termasuk perbedaan model, teori, konsep, metaparadigma keperawatan, serta teori-teori model keperawatan. Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya integrasi teori dan praktik dalam pendidikan maupun pelayanan keperawatan, khususnya dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kesenjangan antara pembelajaran akademik dan praktik di lapangan. Berbagai model asuhan keperawatan klinik dan komunitas juga dibahas, termasuk penerapan evidence-based practice, dokumentasi keperawatan berbasis SDKI-SIKI-SLKI, integrasi teknologi, serta inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Selain membahas konsep dan penerapan, buku ini juga menekankan pentingnya validasi dan uji model asuhan keperawatan berbasis riset agar model yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah, relevan, dan dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Berbagai contoh implementasi model, seperti evidence-based nursing, pemberdayaan keluarga, transcultural nursing, continuity of care, self-care, dan collaborative care turut disajikan untuk memperkaya pemahaman pembaca. Pada bagian akhir, buku ini mengulas arah pengembangan model keperawatan Indonesia, mulai dari kondisi eksisting, landasan pengembangan, strategi implementasi, hingga peluang masa depan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



Optimal
Untuk
Negeri



ISBN 978-634-7556-95-0 (PDF)



9

786347

556950